

Не просто накормить

*Как организовать безопасное, достойное и вариативное
питание людей с психическими нарушениями в домах
социального обслуживания*

От единого меню к поддерживаемому выбору: здоровье, безопасность, права жителей,
пищевая безопасность и ответственность руководителя

Санкт-Петербург · 25–27 августа 2026 года

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Для руководителей стационарных организаций социального обслуживания из 51 субъекта Российской Федерации

Чистяков Е. В., директор СПб ГАСУСОН «ДСО „Серафимовский“»

Содержание

Часть I. Основной текст

2. Обращение к участникам семинара
3. Аннотация
4. Резюме для руководителя
5. Собирательная ситуация: «Один обед — пять конфликтов»
6. Кто находится за столом
7. Что значит «накормить»
8. От мономеню к вариативности: лестница моделей
9. Пищевое поведение при психических расстройствах
10. Дисфагия и аспирационный риск: часто нераспознанная проблема стационарного ухода
11. Лекарства и еда: пять правил, которые обязана знать кухня
12. Отказ от еды: от первого пропуска до врачебного решения
13. Переедание, гиперфагия и ночное едение
14. Пикажизм, заглатывание и другие поведенческие риски за столом
15. Невербальный выбор: как услышать того, кто не говорит
16. Дееспособность, опека и выбор еды: карта решений
17. Право Российской Федерации: что разрешено, что требуется, что опасно
18. Санитария и пищевая безопасность при вариативности
19. Два варианта блюда: технология без второй кухни
20. Точка раздачи: дизайн линии, очередь и помощь
21. Когда выбор изменился: журнал, пересчёт и «фиктивная вариативность»
22. Как проверить реальность питания: аудит и замеры
23. Кто участвует: география семинара и система ПНИ-2026
24. Как устроены нормы в регионах
25. Российские практики: четыре подтверждённых кейса и одна региональная модель
26. Международный опыт: проверяемые нормы девяти систем
27. Что говорят исследования: доказательные вмешательства и их границы
28. Люди за линией: персонал стола
29. Финансовые модели: сколько стоит питание и сколько стоит выбор
30. Закупки продуктов: 44-ФЗ без кошмаров
31. Документальный комплект: как практика становится системой
32. Как отвечать проверяющему: сценарий диалога без страха

33. Ответственность директора: честная карта рисков без запугивания
34. Права жителей и совет жителей: от объекта заботы к соавтору меню
35. Пилот на 90 дней: минимальный безопасный старт
36. Дорожная карта на 12 месяцев: от пилота к системе
37. Четырнадцать возражений и честные ответы на них
38. Десять вопросов учредителю: повестка для разговора наверх
39. Предложения отрасли: что должно измениться выше уровня учреждения
40. Организационные предложения семинару
41. Заявление о достоверности: что в этом докладе на чём стоит
42. Аутсорсинг питания: контракт как место вариативности
43. Заключение: что остаётся после последней страницы
44. Библиография и источники

Часть II. Учебные кейсы (22 разбора)

- Учебные кейсы 1–4
- Учебные кейсы 5–8
- Учебные кейсы 9–12
- Учебные кейсы 13–16
- Учебные кейсы 17–20
- Учебные кейсы 21–22

Часть III. Приложения: проекты локальных форм (45 шаблонов)

- Приложения 1–6
- Приложения 7–12
- Приложения 13–18
- Приложения 19–24
- Приложения 25–30
- Приложения 31–36
- Приложения 37–38
- Приложения 39–42
- Приложения 43–44
- Приложение 45. План Б: питание при закрытии столовой

Часть IV. Одностраничные инфографики (для печати)

Часть I. Основной текст

Сорок четыре раздела: от границы «кухня не назначает клинику» до пилота на девяносто дней, папки проверяющему и честного заявления о том, на чём стоит каждая цифра.

БЛОК I.1. ВСТУПЛЕНИЕ И РЕЗЮМЕ (РАЗДЕЛЫ 1–4)

Как организовать безопасное, достойное и вариативное питание людей с психическими нарушениями в домах социального обслуживания

Методическое руководство к межрегиональному методическому семинару-совещанию «Пространство Новых Идей 2.0»

Автор: Чистяков Евгений Владимирович, директор Санкт-Петербургского государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения «Дом социального обслуживания „Серафимовский“»

Со-модератор дискуссии 26.08.2026: Нурбаев Тимур Аликович, директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания населения «Дом социального обслуживания „Тесовый берег“»

Тема семинара: «Права, свободы, интересы жителей и персонала социальных стационаров»

Дискуссионная сессия 26 августа 2026, 14:00–15:30 — «Организация питания: опыт реализации проектов» (площадка № 2)

Санкт-Петербург, 25–27 августа 2026 года

Организаторы: Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Аудитория: руководители стационарных организаций социального обслуживания — психоневрологических интернатов и домов социального обслуживания — из 51 субъекта Российской Федерации

Это справочник для внедрения, а не конспект девяноста минут. На стол в зал — презентация v6 и памятка на две страницы; полный текст — в сумку. Документ не является нормативным правовым актом, клиническим руководством или индивидуальной юридической консультацией. Все локальные формы в приложениях — проекты и требуют адаптации. Заявление о достоверности — в разделе 41.

2. Обращение к участникам семинара

Коллеги, начну не с витрины.

Один обед — пять конфликтов: очередь против помощи, отказ без журнала, кофе на клозапине, «добавка» без врача, журналы «к комиссии». Голодный житель и оплаченное сырьё в баке — одна система. Национальной доли отходов нет. Её даёт семидневный замер в пилоте, не лозунг. Дисфагия в изученных клинических группах — 21,9–69,5 %; на все российские ДСО это не переносится¹.

Кто в вашем доме сегодня решает, что лежит на тарелке: он сам, сиделка, врач, кухня, контракт или региональная норма? Чаще всего отвечают «кухня» и «норма». Реже всего — «он сам». Для человека в вашем доме еда — три-четыре события в день. Тема семинара — права жителей. Здесь они либо доходят до тарелки, либо остаются в статье закона.

Что унести, если закрыть этот том после двух страниц. Ответ проверке — комплект, не формула «запрета нет». Закон не требует шведский стол и не запрещает замену. Проверяющему нужна папка: положение, меню с вариантами, журнал заказа, журнал замен, пищевые карты, согласование с учредителем; пищевые предпочтения — в ИППСУ, где это уместно (442-ФЗ). Без комплекта та же практика выглядит как отступление от раскладки. Шаблоны — в приложениях; порядок сборки — разделы 31–32. Гуманное отношение — ст. 5 ч. 2 Закона № 3185-1.

Клинику кухня не назначает. Таблица «лекарство × еда», текстуры, «диабетический стол», отказ от еды — только с врачом. Иначе осторожный директор правильно услышит: «мне предлагают медицинскую реформу руками повара». Граница — разделы 4.0 и 4.3.

Практика уже есть. Два дома в Новосибирской области, Усть-Илимск, Серафимовский — публично. Иркутская область масштабирует выбор на регион^{2, 3, 4, 5, 6}.

Про 74 %. По данным за 2024 год, обработанным проектом «Если быть точным», порядка трёх из четырёх жителей ПНИ признаны судом недееспособными⁷. В вашем доме цифра будет другой. Логика та же: повседневное пищевое предпочтение обычно не сделка; опекун учитывает мнение (ст. 29 ГК).

Последнее слово этого текста — не «внедряйте», а «измеряйте». Семь дней замера отделяют убеждение от знания. Если получилось в Успенском — жители «с лёгкостью освоили новую систему»³ — это методика, не чудо.

Как пользоваться пакетом. Сессия 26.08 — презентация v6, основной показ слайды 1–18. Со стола — памятка на две страницы. Этот файл — справочник: маршруты в разделе 4.6, достоверность — в разделе 41. GitHub директорам ПНИ не канал доставки; ссылку и PDF отдаёт организатор или флешка.

Это методическое руководство, а не стенограмма. В зале звучит восемнадцать слайдов и памятка. Здесь — 44 раздела, 22 учебных кейса, 45 шаблонов, 126 источников (34 правовых и практических, 48 клинических, 44 международных). На семинаре покрывается около десяти процентов материала. Остальное — на случай, если понадобится в работе, и не для того, чтобы читать подряд. Пятнадцать минут — раздел 4. Вечер — раздел 4.6. Неделя внедрения — главы 31 и 35. Разговор с учредителем без лужи — 31, 32, 33, 37. Полный реестр — раздел 44.

3. Аннотация

Методическое руководство по организации питания в стационарных организациях социального обслуживания, где живут люди с психическими расстройствами, — психоневрологических интернатах и домах социального обслуживания. Подготовлено к семинару «Пространство Новых Идей 2.0» (Санкт-Петербург, 25–27 августа 2026 года). Автор — Чистяков Е. В., директор СПб ГАСУСОН «ДСО „Серафимовский“». Адресат — руководители таких организаций из 51 субъекта Российской Федерации.

Три вопроса. **Клинический:** чем кормление людей с психическими расстройствами отличается от «обычного» стационарного питания и какие риски — лекарственно-пищевые взаимодействия, метаболические эффекты антипсихотиков, дисфагия и аспирация, расстройства пищевого поведения — стол обязан учитывать через врача, не через самостоятельность кухни. **Правовой:** что российское законодательство разрешает и чего не требует в части выбора блюд; как оформить вариативное питание документами, которые можно положить проверяющему. **Управленческий:** пилот на 90 дней, замер вместо лозунга, разговор с учредителем.

Доказательная база: 34 позиции российского правового и практического реестра (часть — внутренние или вторичные; ограничения — в разделе 41), 48 клинических публикаций, 44 международных источника. Подтверждены четыре российские публичные практики (Новосибирская и Иркутская области, Санкт-Петербург, 2024–2025); Иркутская область масштабирует выбор на регион.

Объём: 44 раздела, 22 учебных кейса, 45 шаблонов. Справочник для внедрения после сессии. На 26.08 — презентация v6 и памятка на две страницы; полный текст — в сумку.

Ограничения: не заменяет клинических руководств, нормативных актов и индивидуальных юридических заключений; шаблоны — проекты локальных форм; редакции актов — по датам проверки (июль–август 2026 года).

4. Резюме для руководителя

Пятнадцать минут. Если меньше — боль стола (один обед — пять конфликтов), затем раздел 4.0, выводы 2, 5, 7, 10 и модель 4.4. Не начинайте с витрины «как хорошо у нас получается». Сначала несъеденное и голод, потом броня документов и пилот на одно отделение.

Это руководство. Перед сессией его не читают подряд. На 26.08 в зале три предмета: презентация v6, памятка на две страницы, этот том в сумке.

4.0. Сначала граница: что кухня не назначает

Это произносят раньше списка взаимодействий. Иначе зал услышит медицинскую реформу руками повара.

Без врача: любые ограничения рациона (включая «диабетический стол»), изменение текстур (протёртое, загущённое), правила при дисфагии и протокол свободной воды, действия при длительном отказе от еды, режим питания при седации, решения об энтеральном и зондовом питании и о комфортном кормлении в конце жизни, сдвиг времени еды у жителей на инсулине, слабительные и реакция на запор, назначение анализов и добавок микронутриентов, интерпретация MUST и витаминизация при ОРИ.

Без учредителя: изменение финансирования продуктовой строки, изменение штатного расписания (норма помощи за столом), аутсорсинг питания, официальный статус пилота и его публичность.

Без правовой проверки: формулировки о «согласии недееспособного» в локальных актах, обработка пищевых карт как персональных данных, ответы на запросы прокуратуры, любые конструкции, где учреждение одновременно является опекуном жителя.

Таблица «лекарство × еда» на посту законна только с подписью врача. Кухня исполняет назначение, не ставит диагноз.

4.0а. Методология за один экран (как читать цифры)

Четыре класса утверждений. Цифры, акты и цитаты помечены ⁸ (российские правовые и практические), ⁹ (клинические) или ¹⁰ (международные). В PDF они становятся нумерованными сносками; раскрытый список — раздел 44.

Класс 1 — норма. Цитата закона с реквизитами, первоисточником и датой проверки. Этим спорят с юристом и проверяющим.

Класс 2 — толкование. Системное прочтение нормы в ситуации, которой сама норма не регулирует. В разделе 41.2 помечено, что это толкование, не норма.

Класс 3 — рекомендация. «Делайте так, потому что так делает Успенский ПНИ» — опыт конкретного дома с публикацией, не императив.

Класс 4 — проект локальной практики. Шаблоны приказов, положений, журналов — черновики. Каждый требует локальной правовой проверки. В шапке: «проект локальной формы, не норматив».

Слово «проверено» без даты и URL — реклама. «Общий опыт» — анекдот. «Как известно» — либо тривиальность, либо ложь. Утверждение без маркера — ошибка автора, не недоразумение читателя.

Источники проверены 23.07.2026; правовая сверка — 19–21.08.2026. После этой даты акт мог измениться. СанПиН 2.3/2.4.4282-26 вступает в силу 01.09.2026; в тексте обе редакции — 3590-20 и 4282-26 — помечены, какая действует сейчас и какая с 1 сентября. Полный разбор — раздел 41.

4.1. Одиннадцать главных выводов

Вывод 1. Ошибки за столом проверяют как юридически значимые. Проживающие в ПНИ и ДСО для лиц с психическими расстройствами пользуются правами пациентов психиатрических стационаров (ст. 43 Закона № 3185-1). Питание нормировано СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (не менее трёх приёмов в день, диетическое по показаниям); с 01.09.2026 ту же норму закрепляет СанПиН 2.3/2.4.4282-26, п. 56 подп. 11^{11, 12}. Дела по ст. 6.6 КоАП — про качество и достаточность, не про «два вторых»¹³. Разделы 17, 32, 33.

Вывод 2. Ответ проверяющему — комплект документов, не формула «запрета нет». Федеральное право не запрещает вариативность и не обязывает давать выбор каждого блюда. Таблицы замены в раскладках — законный механизм^{14, 15}. Директору этого мало: нужна бумага, которая *разрешает у вас*. Минимальный комплект: положение, меню с вариантами, журнал заказа, журнал замен, пищевые карты, согласование с учредителем. Без комплекта та же практика выглядит как отступление от раскладки. Разделы 31, 32.

Практика уже есть. Два ПНИ Новосибирской области, Усть-Илимск, Серафимовский — публично; Иркутская область масштабирует на регион^{2, 3, 4, 5, 6}. Разделы 8, 23, 25.

Вывод 3. Главные риски стола — клинические, и они измеримы. Антипсихотики различаются по прибавке веса в разы (мета-анализ 100 РКИ: от −0,23 кг до +3,01 кг за 6 недель)¹⁶. В отдельных изученных клинических группах распространённость дисфагии — от 21,9 до 69,5 %; переносить этот диапазон на все российские ДСО нельзя⁴. Смертность от пневмонии при тяжёлых психических расстройствах в семь раз выше популяционной¹⁷. Организация стола входит в профилактику преждевременной смертности. Разделы 9–14.

Вывод 4. Четыре лекарственно-пищевых правила кухня исполняет по таблице врача. Клозапин — кофеин, литий — соль и вода, ИМАО — тирамин, карбамазепин — грейпфрут^{18, 19, 20, 21}. Одна подписанная таблица на посту. Кухня не «убирает кофе сама». Раздел 11 и граница 4.0.

Вывод 5. По агрегированным данным о российских ПНИ за 2024 год порядка трёх из четырёх признаны судом недееспособными; в вашем доме цифра будет другой. 74 % — данные за 2024 год, проект «Если быть точным» (публикация 09.04.2026), не текущая статотчётность Минтруда⁷. Сделки совершает опекун (ст. 29 ГК РФ). Повседневное предпочтение обычно не сделка — а мнение недееспособного обязаны выяснять и учитывать. Опекун учитывает мнение подопечного (ст. 29 ГК, 48-ФЗ). Статья 43 Закона № 3185-1 задаёт статус проживающих, не эту обязанность. 442-ФЗ — права получателя и ИППСУ. Кто не говорит — показ двух порций, наблюдение, пищевая биография. Разделы 15, 16.

Вывод 6. «Диабетический стол» и другие жёсткие ограничения — зона врача, а не шаблона. Лечебное питание назначается поимённо, с целью и сроком пересмотра; приказы Минздрава о лечебном питании адресованы медицинским организациям и не распространяются на СОСО автоматически^{22, 23}. Разделы 17, 19.

Вывод 7. Вариативность без журналов — имитация для проверяющего. См. комплект в выводе 2. Разделы 31, 32.

Вывод 8. Честная финансовая модель начинается с замера. Мы не утверждаем, что вариативность «почти бесплатна». Семидневный замер отходов и трудозатрат до старта — первый шаг; иллюстративные расчёты в докладе помечены. Разделы 29, 35. «Средний житель» здесь опасен: одного перекормили, другого недокормили, среднее по отделению выглядит нормой (раздел 6.5).

Вывод 9. Директор отвечает за систему контроля. Ответственность наступает не за каждое событие, а за неработающий контроль^{13, 24}. Письмо учредителю о дефиците ресурсов не индульгенция, но доказательство своевременного реагирования. Раздел 33.

Вывод 10. Пилот за 90 дней реалистичен на одном отделении без новой сметы. Месяц измерений, месяц документов и обучения, месяц пилота: два варианта на завтрак и обед (модель Новосибирской области)^{2, 3}. «Без новой сметы» не значит «без затрат»: полный переход дома может потребовать оборудования и ставок⁵. Раздел 35.

Вывод 11. Шесть вопросов дискуссии 26.08 — развилка зала. Модераторы: Чистяков Е. В. и Нурбаев Т. А.; площадка № 2 — ДСО «Тесовый берег». Лечебное питание и вариативное меню совместимы, если диета задаёт множество, не одно блюдо. Серафимовский — 223-ФЗ; Тесовый берег — 44-ФЗ. Раздел 17.12 не читать вслух, пока зал не спросил. Разделы 17.12–17.13, 8, 17, 29, 35.

4.2. Что сказать повару в понедельник

1. Семь дней считаем отходы и смотрим, что реально остаётся на тарелках (приложение 25).
2. Замеряем интервал ужин → завтрак одной строкой в журнале.
3. На пост — таблица врача «лекарство × еда», не самостоятельность кухни (приложение 21).
4. Три отказа подряд — звонок врачу в тот же день (приложение 9).
5. Если кухня чужая — открыть спецификацию: есть ли строка выбора (разделы 42 и 35.9).

Остальное — опрос, письмо учредителю, рабочая группа, поднос для постельных — после этих пяти. Чек-листы — приложения 18–20.

4.3. Чего нельзя делать без врача, учредителя или правовой проверки

См. границу раздела 4.0. Повтор, чтобы её не пропустили те, кто листает выводы и сразу ищет «что можно».

4.4. Минимальная безопасная модель

Два варианта блюда, журнал и карта. Без второй кухни.

1. **Документы:** положение об организации питания и журналы (пробы, бракераж, отказов, заказа) ведутся в ритме смены.
2. **Клиника:** таблица врача на посту; список риска дисфагии у сиделки; три отказа — врач в тот же день.
3. **Люди:** на каждого кормимого — конкретный помощник; еда не подаётся, пока помощь не готова.
4. **Голос жителя:** остатки на тарелках разбирают; есть хотя бы один канал пожеланий.
5. **Замер:** ночной интервал и отходы известны числом.
6. **Ночной интервал:** операционная цель дома — не больше 13 часов (рабочий ориентир авторов внутри международного диапазона 11–14 ч, не нормативное требование). 14 часов — верхняя граница CMS (США), не целевой показатель российского чек-листа. Если больше 13 — сдвиг расписания (ужин позже или завтрак раньше) либо вечерний перекус по согласованию с врачом (раздел 13.9).

Если хотя бы один из шести пунктов не выполняется — начните с него.

Одна просьба к 26.08. Не меняйте всё меню. Один обед, одно отделение, одна неделя замера — затем пилот на 90 дней с двумя безопасными вариантами и журналом фактического выбора.

4.5. Что сделать в понедельник до обеда

Пять действий. Новой сметы не нужно, меню не трогают. Врач входит в рабочую группу: он ставит границу, а не «назначает диету руками кухни».

1. **Посчитать сырьевую строку** (1 час). Расходы на продукты за последний полный месяц разделить на число жителей и на число дней. Записать своё число. Если за пять минут его никто не называет — это первая находка аудита. Методика — раздел 29.3, приложение 25.
2. **Запустить семидневный замер отходов и времени раздачи** (10 минут на запуск). Ответственный — завпроизводства или старшая смена. Замерять: тарелочные остатки по трём основным приёмам, граммы на порцию; кухонные остатки; время от начала раздачи до последней тарелки. Журнал — приложение 25. Без замера через 90 дней сравнивать нечего.
3. **Приказ о рабочей группе** (30 минут). Директор или зам по АХЧ, врач или фельдшер, диетсестра или завпроизводства, старшая медсестра одного отделения, представитель учредителя — если получится. Пункт: «в срок до [дата + 30 дней] подготовить предложение по пилоту на одном отделении на 90 дней».
4. **Письмо-уведомление учредителю** (30 минут). Одна страница: обоснование (Новосибирская и Иркутская области, Санкт-Петербург), ссылка на СанПиН 3590-20 п. 7.1.11 / 4282-26 п. 56(11), сроки, просьба о согласовании или уведомительном порядке. Шаблон — приложение 32; разделы 31, 38. Уведомление потом закрывает претензию «самоуправство».

5. Точка пилота (1 час с завождением). Одно отделение 20–35 жителей; лучше «сложное» (группа помощи, неговорящие), не самое удобное; одна смена; один приём пищи — обед. В протокол рабочей группы. Почему «сложное» — раздел 35.7.

В первый понедельник не делать. Не выбирать модель М1–М5 — это решение группы после замера. Не менять меню. Не выпускать пресс-релиз. Совет жителей подключается на этапе пар эквивалентов.

Через семь дней на руках: сырьевая строка, замер отходов запущен, приказ с пятью фамилиями, письмо учредителю, выбранное отделение.

4.6. Три предмета на 26.08 и три маршрута после

На сессию: презентация v6, слайды 1–18. **На стол:** памятка «что унести в регион». **В сумку:** этот том.

После семинара. **Маршрут директора (два часа):** разделы 4, 5, 8, 22, 35, 37, 42. **Маршрут внедрения (неделя):** 6–8, 17–19, 31, 35–36 и приложения. **Маршрут спорщика (вечер):** 23–27, 37, 39–40. Раздел 41 не пропускать: по клинике и международным нормам база плотная, по эффекту вариативности в психиатрии — почти пустая. Поэтому последнее слово — «измеряйте».

5. Собирательная ситуация: «Один обед — пять конфликтов»

БЛОК 1.2. СЦЕНА, ТЕРМИНОЛОГИЯ, ЛЕСТНИЦА МОДЕЛЕЙ (5–8)

Учебный кейс, составленный для анализа. Все персонажи и совпадения вымышлены; ситуация собрана из типичных элементов, описанных в проверенных источниках и практиках учреждений.

5.1. Обед, как он есть

Средний российский психоневрологический интернат — 289 коек⁷. Обеденный зал на 120 мест, поточная раздача в три захода²⁵. На линии — один вариант каждого блюда: борщ, гречка с котлетой, компот. Двенадцать жителей первого захода едят только с помощью. На смене четыре сиделки, из них одна развозит лекарства. До конца смены — пять часов.

Первый конфликт: очередь против помощи. Тех, кто ест сам, раздали первыми — так быстрее, — и они уже сидят перед остывающими тарелками. Четыре сиделки на двенадцать кормимых: не менее трёх циклов по 15–20 минут; последних кормят холодным. Международная норма, которую мы приводим в разделе 26, требует не больше двух полностью кормимых на работника и подачи только под готовую помощь²⁶. У нас это нигде не закреплено и нарушением не считается. Именно здесь рождаются недоедание и аспирация «на скорость».

Второй конфликт: «он опять не ест кашу». Житель С. третий день отодвигает тарелку. Журнала отказов нет: запись в тетради или нет, врач узнает в четверг. Депрессивный эпизод и, возможно, начинающаяся дисфагия — проверить некому, логопеда в штате нет. Покашливание за столом, «влажный» голос после еды с отказами никто не связывает²⁷. «Каприз» или «симптом» — кто дежурит.

Третий конфликт: лекарства и кофе. Житель К. на клозапине с утра выпил две большие кружки крепкого кофе от родственников. Семью и К. не предупредили: кофеин взаимодействует с клозапином; резкий рост потребления даёт клинически значимый рост концентрации^{18, 28}. Вечером седация сильнее. Дежурная: «плохой день».

Четвёртый конфликт: добавка. Житель П. на оланзапине за год набрал 14 килограммов; мета-анализы: один из самых выраженных весогенных профилей¹⁶. Просит вторую котлету. Сиделка: «вам нельзя, вы полнеете» — по своему представлению о пользе, без врачебного назначения. Вечером забирает хлеб у соседа. Разбирают дисциплину, не самовольное ограничение рациона.

Пятый конфликт: проверка на следующей неделе. Четверг — комиссия учредителя. Завхоз: журналы «в порядок», суточные пробы за двое суток подпишут сегодня. Самое опасное из пяти — документальная имитация контроля. Прокуратуры: нет суточных проб и недоброкачественные продукты — типовой состав дел по ст. 6.6 КоАП для социальных учреждений¹³.

5.2. Почему все пять конфликтов — одна система

У каждого свой «виноватый»: медленная сиделка, капризный С., неведущая семья К., несдержанный П., нерадивый завхоз. На деле — отказ системы.

Конфликт	Отказ системы	Где в докладе решение
Очередь против помощи	Нет нормы помощи за столом и порядка подачи	Разделы 20, 28
«Не ест кашу»	Нет журнала отказов, триггеров и маршрута дисфагии	Разделы 10, 12
Лекарства и кофе	Нет лекарственно-пищевой таблицы и информирования семьи	Раздел 11, приложение 32

Конфликт	Отказ системы	Где в докладе решение
Добавка	Ограничение рациона принято не врачом и не зафиксировано	Разделы 13, 17, 19
Журналы «в порядок»	Контроль имитируется	Разделы 31, 33

Ни один из пяти не требует денег для начала — решение директора и документы. Три упираются в кадровую нагрузку. Вариативное питание добавит шестой конфликт: «кто выбирает блюдо». Пять базовых не закрыты — шестой добьёт систему. Дорожная карта (разделы 35–36) начинается с измерения и фундамента.

5.3. Сцена спустя год

Та же столовая, тот же час — год работы по этому докладу. Женщина, которой нужно молчание, ест за тихим столом у окна. Мужчина на клозапине пьёт кофе, согласованный с врачом. Житель с дисфагией ест свою текстуру; тарелка не выглядит «детской». Неговорящий показал на карточку и получил то, на что показал. Смена работает по журналам. Пять конфликтов не исчезли — они получили процедуры.

6. Кто находится за столом

6.1. Неоднородность как единственная норма

Первая ошибка — «средний житель ПНИ». Его нет. Даже в агрегате: 65 % старше 45 лет, 74 % признаны недееспособными, 11 % — постельные или маломобильные⁷. В одной столовой сидят сразу: пожилой человек с шизофренией и старческой дисфагией; молодой мужчина с расстройством аутистического спектра и сенсорной невосприимчивостью текстур; женщина средних лет с аффективным расстройством и выраженным набором веса на препаратах; человек с умеренной умственной отсталостью, который не читает меню; житель в стойкой ремиссии, готовящийся к переводу в сопровождаемое проживание, — ему навыки «свой стол» нужнее, чем кому-либо.

Задача не «накормить контингент» — маршрут каждой группы к достаточной, безопасной и выбранной им еде. Разделы 9–14 — по механизмам; здесь — карта.

6.2. Пять измерений неоднородности

Психическое состояние. Депрессия — безразличие к еде; мания и возбуждение не оставляют времени на стол; психоз добавляет «отравлено»; тревога делает шумную очередь местом избегания. Состояние волнообразно: один житель в разные недели требует разной организации. «Особые состояния» — штатный режим, не авария (раздел 12).

Когнитивные функции. От сохранного интеллекта до глубокой умственной отсталости и деменции — не юридическая «компетентность», а способ выбора: слово по меню, указание на порцию, жест, устойчивый паттерн потребления (раздел 15). Статус задаёт инструмент, не наличие выбора.

Коммуникация. Неговорящие и малоговорящие — значимая доля. «Что будете?» для них худший инструмент. Выбор фиксируется иначе. Международное право (Замечание общего порядка № 1 к ст. 12 КПИ) требует поддержанного, а не подменяющего принятия решений²⁹.

Соматика. Дисфагия (раздел 10), диабет и метаболический синдром (разделы 11, 13), запоры — в том числе опасные клозапиновые³⁰, сердечно-сосудистая патология, эпилепсия с риском аспирации при припадке за столом. Соматическая карта — рамка выбора.

Жизненный опыт и культура. «Всю жизнь ужинал в девять», религиозные правила, детские и праздничные блюда как якоря идентичности. Немецкий стандарт собирает «биографию питания» при поступлении: позже это может стать единственным доступом к воле³¹. Форма — приложение 3.

6.3. Классификация для практики

Карта должна работать, а не украшать стенд.

Группа	Как распознать	Главный риск за столом	Маршрут питания
Самостоятельные, стабильные	Едят сами, выражают предпочтения словом	Однообразие, «столовская» еда	Полный выбор, участие в совете жителей
Самостоятельные, нестабильные	Волнообразное состояние	Пропуски приёмов при обострении	Выбор + «особые состояния» в пищевой карте
Маломобильные	Едят в жилой зоне	Холодная еда, очередь «в последнюю очередь»	Подача под готовую помощь, контроль температуры
Нуждающиеся в кормлении	Не могут есть сами	Недоедание, аспирация «на скорость»	Норма помощи 1:2 (ориентир), медленный темп

Группа	Как распознать	Главный риск за столом	Маршрут питания
Неговорящие / малоговорящие	Не отвечают на вопрос о выборе	Подмена выбора удобством персонала	Показ порций, наблюдение, пищевая биография
С дисфагией	Покашливание, «влажный» голос, долгий приём	Аспирация, пневмония	Назначенная текстура, поза, темп (раздел 10)
С выраженным набором веса	+5 % и более за 3 месяца на препаратах	Метаболический синдром	Мониторинг, пищевая среда, без самостоятельных «диет» (раздел 13)
С расстройствами пищевого поведения	Переедание, ночное едение, пика, заглатывание	Соматические и бытовые риски	Индивидуальные протоколы (разделы 13, 14)

Таблица — проект рабочей классификации для локального использования, не нормативная документация.

6.4. Что сказать повару в понедельник

Пять действий раздела 4.2 остаются. Здесь — пять других чисел: сколько едят сами, сколько с помощью, сколько неговорящих, сколько в группе дисфагического риска, сколько на весогенных препаратах. Форма — приложение 35. Без них планируете для абстракции.

6.5. Почему «средний житель» — опасная конструкция

«Средняя порция» промахивается в обе стороны, и промахи складываются. Гиперфагия получает «среднее» и ищет еду ночью и в чужих тарелках (раздел 13). Депрессивная фаза оставляет две трети: отходы растут, вес падает, учёт видит «норму» — среднее по отделению прежнее. Одного перекормили, другого недокормили. Защита — распределение: сколько оставляют больше трети порции. Форма замера (приложение 25) — построчно.

6.6. Контингент меняется — карта стареет

Пять чисел не константа. Контингент стареет, доля постельных и помощных растёт, назначения меняются. Числа год назад — питание для людей, которых уже нет. Квартальное обновление — калибровка прицела. Самый дорогой вид старения карты — рост группы помощи без роста ставок: сначала темп кормления, потом вес жителей, потом, если повезёт, документы.

6.7. Как собрать пять чисел за один обход

Ни статистик, ни неделя. Обход с заведующими, полтора часа: из головы, сверка с листом жителей. Точность «из головы» — смысл метода: не называет число кормимых своего отделения — находка важнее числа. Второй проход — врач: весогенные препараты (таблица раздела 11) и назначенные текстуры. Третий — старшие смены: кто оставляет еду, кто ест ночью, кто «не ест в зале». Три прохода — живая карта для разделов 19–20. Обновление — раз в квартал, строка в панели (приложение 35).

7. Что значит «накормить»

7.1. Шесть измерений одной тарелки

«Накормить» в управленческой речи обычно одно: порция по норме и съедена. Этого мало — не из гуманизма: одномерное «накормить» само производит недоедание, конфликты и нарушения. Шесть измерений — у каждого свои нормы, провалы, измерители.

1. Достаточность. Вес и состав покрывают рекомендуемые нормы Минтруда (приказ № 520н) и региональные нормы на их основе^{32, 14, 15}. Измеритель — фактическое потребление: выданная и не съеденная порция достаточностью не является. Замер остатков (приложение 25) — сколько доходит.

2. Безопасность. Три слоя. Санитарный: пробы, температуры, отдельные потоки, питьевой режим — СанПиН 2.3/2.4.3590-20 к организациям соцобслуживания (до 31.08.2026; с 01.09.2026 — СанПиН 2.3/2.4.4282-26, п. 56 подп. 11–13, п. 62)¹². Клинический: назначенные текстуры при дисфагии (раздел 10), лекарственно-пищевые ограничения (раздел 11). Поведенческий: защита от заглатывания, пика, отбирания еды (раздел 14). Провал любого слоя — не «недовольство качеством», а ответственность (раздел 33)¹³.

3. Удовольствие. Вкус, температура, вид, разнообразие. Еда здесь — главный ежедневный опыт: удовольствие не роскошь, а фактор потребления. Невкусное съедается хуже — недоедание при формально достаточных нормах. Международные нормы связывают качество и привлекательность блюд с нутритивными исходами^{33, 34}. Измеритель: остатки и жалобы.

4. Социальность. Разговор, общий ритм, участие персонала. Финская национальная рекомендация закрепляет совместные трапезы персонала и проживающих как элемент качества³⁵. Голландское рандомизированное исследование семейной подачи: рост качества жизни и потребления энергии за счёт социальной организации

стола³⁶. У нас это ещё бесплатный мониторинг: работник за общим столом замечает «он сегодня не жуёт» раньше журнала.

5. Самостоятельность. Пройти линию, выбрать, поесть приборами, убрать за собой. Для части жителей — реабилитация к сопровождаемому проживанию; в России такие программы действуют и расширяются⁷. Стол, который делает всё за человека, закрепляет зависимость. Поточная линия с самообслуживанием, как отмечает одно из российских учреждений, «развивает навыки самообслуживания»²⁵.

6. Выбор. Что, когда, где и как есть — формула австралийского стандарта «Еда и питание»³⁷. Единственное измерение, которое нельзя делегировать: систему можно построить за человека, решение — нет. Здесь право (разделы 16–17), технология (разделы 19–22) и тема семинара.

7.2. Матрица провалов

Типовой провал каждого измерения виден без обследований:

Измерение	Типовой провал	Быстрый измеритель
Достаточность	Норма на бумаге, недоедание на тарелке	Доля несъеденных порций (7-дневный замер)
Безопасность	Журналы есть, контроль имитируется	Сверка фактических проб с графиком без предупреждения
Удовольствие	«Столовая» еда, однообразие	Блюда-аутсайдеры по остаткам; жалобы
Социальность	Столовая как конвейер, тишина или команды	Наблюдение за одним обедом: есть ли разговор
Самостоятельность	Всё делают за жителя	Доля жителей, проходящих линию сами
Выбор	Решает кухня	Ответ жителя на вопрос «что ты сегодня выбрал?»

«Накормить» — шесть задач. «Питание в порядке» — по которому из шести? Деньги закрывают в основном первые три; последние три — организацию и документы. Вариативное питание работает, когда первые пять не провалены.

7.4. Проверка каждого измерения на вашей линии

Шесть проверок по десять минут за день — не директору, а тому, кто будет честен. **Безопасность:** сколько из списка риска едят вне поля зрения смены. **Физиология:** ужин и завтрак против шведского ориентира ночного интервала (не более 11 часов³³; пример — ужин 17:30 → завтрак 8:30 = 15 часов без еды; без замера в своём доме это нельзя называть типовым распорядком РФ). **Психология:** вечером спросить у трёх жителей, что было на обед; не помнят или «как обычно» — еда фон. **Социальность:** персонал ест с жителями или «потом, на кухне» — второй ответ описывает культуру стола. **Право:** реальность выбора (приложение 24). **Экономика:** сырьевая строка за минуту деления (приложение 25). Ни рубля. Карта первого провала. Начинать с него, не с красивого проекта.

7.5. Граница измерений: что не входит

Два понятия за рамкой. **Кулинарное качество** (вкус как искусство) важно, но не предмет системы: свежесть, температура, рецептура — да; субъективный вкус — совет жителей и дегустации (раздел 34), не нормативы. **Медицинская нутрициология** в полном объёме (нутриентный расчёт под заболевания) — врач и, где есть, диетолог. Доклад организует исполнение назначений, не подменяет содержание. Границы — от кулинарного эстетства и псевдомедицины.

7.6. Минимальная планка каждого измерения

Одно действие на измерение. **Безопасность:** список риска на посту. **Физиология:** ночной интервал ≤13 часов (диапазон 11–14 часов, раздел 26). **Психология:** показ меню каждому ежедневно. **Социальность:** один «тихий стол» в зале. **Право:** журнал замен. **Экономика:** посчитанная сырьевая строка. Не идеал — вывод из зоны отказа. Так собирается минимальная безопасная модель раздела 4: не совершенство в одном и провал в пяти, а планка в шести.

8. От мономеню к вариативности: лестница моделей

8.1. Термины, чтобы не путаться

Смешивают четыре вещи. **Цикличное меню** — повторяющийся цикл (14 дней по российским раскладкам, 21 день в Онтарио, 4 недели по немецкому стандарту)^{25, 26, 34}: разнообразие во времени, не выбор. **Вариативное меню** — в одной точке приёма больше одного варианта, из которых житель выбирает. **Замена по таблице** — эквивалентная замена продуктов в раскладке, в нормах десятилетиями^{14, 15}: делает вариативность законной, выбором жителя не является. **Персонализация** — индивидуальные назначения (текстуры, ограничения, усиленное питание) вне общего выбора.

Типовая ошибка: назвать «вариативным» цикличное меню («14 дней без повторов») или таблицу замен («гречку на рис по остаткам»). Выбора жителя нет. В докладе «вариативность» строгая: в момент еды житель реально может получить не менее двух вариантов и влияет на то, какой получит.

8.2. Лестница моделей

Между мономеню и «полным выбором» — лестница. Каждая модель (M0–M5) — рабочая конфигурация с известной ценой и рисками. M1–M2 подтверждены российской практикой (Болотнинский, Успенский, Иркутск)^{2, 3, 4, 6}.

Модель M0. Мономеню с учётом отказов. Выбора нет, но отказ влечёт замену по таблице — житель не остаётся голодным, — а остатки влияют на цикл. Не вариативность, а фундамент: американская федеральная норма требует альтернативу при отказе как базовый минимум³⁸.

Модель M1. Выбор из двух вариантов в одной позиции. Один второй вариант ключевого блюда (каша А/каша Б, второе А/второе Б) на части приёмов и дней. Российский старт: Болотнинский ПНИ — «несколько раз в неделю», завтрак и обед, перечень определяет диетсестра². Цена: вторая гастрорёмкость, журнал заказа; при парных эквивалентах новых денег почти нет (раздел 29).

Модель M2. Выбор по всем основным позициям ежедневно. Два варианта первых, вторых, гарниров, напитков. Успенский ПНИ (все отделения)³ и региональная модель Иркутской области⁶. Нужны журнал заказа и пересчёт объёмов по статистике выбора (раздел 21).

Модель M3. Выбор на линии раздачи («шведский стол»). Житель комплектует тарелку из выставленного ассортимента. Больше выбора — площадь раздачи, скорость потока, санитарный контроль открытых блюд¹². Для ПНИ — выборочно. Публично такая линия — у ДДСОЛ⁵. Успенский ПНИ — M2 (два вторых, два салата, два напитка), не M3³.

Модель M4. Семейная подача за столом. Общие блюда, жители накладывают сами. Доказанный эффект у пожилых с деменцией: качество жизни, вес, потребление энергии³⁶. Точно, где рассадка и поведение позволяют. Персонал — от раздачи к сопровождению.

Модель M5. «Своя кухня». Жители готовят сами при поддержке: британский self-catering на реабилитационных отделениях³⁹ и американские малые дома Green House⁴⁰. Горизонт квартир тренинга жизненных навыков и подготовки к сопровождаемому проживанию, не массовая модель.

8.3. Критерии реального выбора

Любая модель — пять критериев. Формальная «вариативность» отсеивается (раздел 22 и приложение 24).

- 1. Доступность:** вариант Б существует, когда подходит житель, а не «закончился к первому отделению».
- 2. Равноценность:** эквивалентны по питательной ценности — замена по таблице, не «гречка или ничего»¹⁴.
- 3. Информированность:** знает о выборе и понимает доступным способом (слово, показ, визуальное меню).
- 4. Уважение:** выбранное подаётся; переубеждать «для вашей пользы» — не норма.
- 5. Учёт:** выбор фиксируется и влияет на завтрашние объёмы и будущие циклы.

8.4. Что сказать повару в понедельник

Понедельник раздела 4.2 — замер и журналы. Здесь задача недели: где вы стоите — M0, M1 или M2. Российские подтверждённые практики — M1–M2^{2, 3, 4, 6}. Хаотичные журналы — с M0; порядок в документах — с M1 на одном отделении.

8.5. Движение вниз по лестнице: тихий регресс

Лестница работает в обе стороны. Вниз — чаще. Уходит инициатор (заведующая, диетсестра) → показ меню «временно» упрощают → через квартал журнал «для проверки», выбор снова делает кухня. Снаружи организация «внедрила»: положение действует. Регресс читается в панели раньше жалоб: падает доля выбирающих, растёт доля «стандартных», журнал срывов пустеет — не потому что срывов нет, а потому что записывать перестали. Противоядие: документ и ритм, не человек — приказ, ротация ответственных, квартальная панель (раздел 31). Практика, пережившая смену двух заведующих, устоялась. До этого рубежа — проект энтузиаста.

8.6. Лестница участия жителя: критерий измерения

Примечание: нумерация ступеней участия (0–5) не совпадает с моделями организации (M0–M5, раздел 8.2). Это разные оси: модели — технология раздачи, ступени участия — мера контроля над едой, возвращённого жителю.

Степень измеряется одним вопросом: что изменилось в тарелке конкретного жителя сегодня? Проверка через жителя, не через документ. Нулевая: еду определили регион — кухня — смена. Первая: спросили, тарелка та же. Вторая: выбор дошёл до тарелки сегодня. Третья: дошли ещё время и место. Четвёртая: влияет на меню через совет. Пятая: еда снова часть жизни, не процедуры. «На какой мы ступени» звучит абстрактно, пока вопрос не про одного жителя по имени — дальше это план.

8.7. Как определить свою ступень за 15 минут

Самооценка почти всегда завышает: «у нас выбор» оказывается «спрашиваем, готовим одно». Три вопроса к фактам. **Покажите вчерашний журнал** — нет записи вчера, ступень не выше первой, что бы ни говорило положение. **Был ли второй вариант физически на линии вчера** — спросить смену, сверить с журналом срывов. **Кто вчера выбрал не то, что принесли бы по умолчанию** — «таких нет» третью неделю: выбор декоративен. Ответы ставят ступень без субъективности. Полная форма — в семинарском пакете (форма ступени). Правило: ступень — вчерашний день, не положение.

8.8. Еда как навык сопровождаемого проживания

Сопровождаемое проживание уже не гипотеза: порядка семи тысяч человек вышли из ПНИ в такие программы⁷. Кто десятилетиями не выбирал даже кашу, на выходе встречает магазин и плитку как чужой язык. Ступени 3–5 (время и место, совет, своя кухня) — не «ресторан для интерната», а тренировка: назвать, показать, отказаться, убрать за собой. Вариативное меню внутри дома и менее институциональные формы жизни не конкурируют: первое готовит навык, без которого второе — лозунг. Ближайший год для большинства — ступени 1–2; ступень 5 — горизонт квартир тренинга, не массовая модель (раздел 8.2).

9. Пищевое поведение при психических расстройствах

БЛОК 1.3. КЛИНИКА: ПОВЕДЕНИЕ, ДИСФАГИЯ, ЛЕКАРСТВА, ОТКАЗ, ГИПЕРФАГИЯ, ПИКАЦИЗМ (9–14)

9.1. Почему обычные правила здесь работают иначе

Стационарный стол рассчитан на «среднего едока»: пришёл вовремя, сел на 20–30 минут, съел что дали, сказал, если не так. Психические расстройства ломают каждое из этих допущений — системно. Здесь — паттерны, которые стол обязан предвидеть.

Паттерн — симптом, лекарственный эффект или оба. Не характер. На симптом — врач; на лекарственный эффект — врач с кухней; на сбой стола — администрация. «Дисциплиной» не отвечает никто.

9.2. Паттерны и их механизмы

Снижение интереса к еде (депрессия). Не «отказывается» — еда перестаёт значить, тарелка уходит без слов. Тихое недоедание видно по весу через месяцы. Журнал и триггеры — раздел 12; при долгом снижении — врач. *Wunschkost*: мотивация есть важнее нутритивной строгости^{31, 41}.

Подозрительность к пище (психоз). «Отравлено», «не то», «с запахом». Убеждать бесполезно. Работают запечатанная упаковка, блюдо из общего котла на глазах, выбор из двух порций, доверенный человек, иногда еда вне зала. Каждый эпизод — врачу: это симптом плана лечения.

Возбуждение и мания. Два укуса на ходу — и ушёл. «Мало и часто», *finger food* (BDA — меню без приборов именно для этого)³⁹, отдельная комната, отложенная порция. «Обед с 13:00 до 13:30» не работает. Отложенный доступ — британские и австралийские стандарты^{42, 37}.

Седация. Утренние препараты — человек спит в часы завтрака. Гибкое окно и отложенная порция — прямая рекомендация BDA³⁹; австралийский стандарт держит еду и перекусы круглосуточно³⁷. «Опоздал — остался голодным» — не дисциплина, а нарушение доступности.

Ригидность и сенсорные особенности (РАС, умственная отсталость). Узкий круг «безопасных» блюд; смешанные текстуры не идут; вид, запах, температура, посуда, соседи. Расширять постепенно, без насилия; в каждом приёме — «безопасный» вариант; сенсорика — в карте. Два незнакомых блюда «в лоб» не работают: выбор внутри привычного ряда.

Быстрое заглатывание. Почти без жевания, за минуты. Риски: аспирация, удушье, рвота, отбирание еды «по инерции». Малые порции с добавкой, питьё между глотками, посадка рядом с работником, без сухих крупных кусков. Наблюдение — раздел 10: механика риска та же.

Переедание и гиперфагия. Раздел 13: препараты и метаболика.

Прятание и «хомячение». В тумбочку, под матрас. Причины: опыт голода, тревога, симптоматика, ночное едение (раздел 13). Не изымать — легализовать: перекус на посту снимает мотив прятать. Санитарные правила — заменой запасов, не конфискацией.

Избирательность «всё или ничего». Съедает только любимое. Учёт в карте, «опорные» блюда в цикле регулярно, расширение через парные предложения.

9.3. Что это меняет в организации стола

Три следствия. Журнал потребления — диагностика: паттерны видны только в записи, врач читает его еженедельно. «Особые состояния» — штатный режим (три строки — 9.6, приложение 3). Гибкость по времени и месту — часть

безопасности: отложенные порции, отдельные столы, приём в жилой зоне стоят в положении о питании, иначе это «нарушение распорядка».

9.4. Границы раздела

Доклад не ставит диагнозов и не описывает лечения. Клиника здесь — стол и наблюдение: что видят сиделка и повар, что фиксирует журнал, когда эскалация к врачу. Кухня клинику не назначает: видит, фиксирует, передаёт врачу.

9.5. Ограничение: паттерн ≠ диагноз

Обратная ошибка — психологизация: «ест быстро, потому что в детстве голодал». Наблюдаемое пишется как наблюдаемое («съедает за 3–4 минуты, не прожёвывает»). «Почему» — врачу и психологу. В журнале и карте — факты; гипотезы — в беседе с врачом. Бережёт жителя от ярлыков и смену от выхода за компетенцию (раздел 28).

9.6. Питание при обострениях: заготовленный режим

Волнообразное течение — норма. Режим на обострение готовится до него. Три строки в карте: что с едой у этого жителя при ухудшении (отказывает / объедается / не выходит в зал / всё отравлено); что помогало (форматы, продукты, люди); кто переводит на режим и обратно (врач). Есть три строки — смена исполняет план. Нет — каждый эпизод заново. Проверка: три заведующих показывают эти строки у трёх жителей. Нечего показать — первая задача на месяц, важнее нового блюда.

9.7. Паттерны по сменам: что видит пост и что с этим делать

Обзоры дают диапазоны, пост начинает со сцены. Переедание при тяжёлых психических расстройствах — 4,4–45 % в зависимости от диагноза и инструмента, тяга к еде — 16,1–64 %, ночное едение — 4–30 %⁴³. «Средней частоты» нет. Есть частота вашего контингента. Мерить — самим.

Четыре сцены. Съел всё за минуты и просит ещё — не жадность, возможная гиперфагия терапии (раздел 13) → врач и структурированная доступность. Прячет в тумбочку — часто опыт дефицита (биография, приложение 3) → не отбирать, легальный «запас» из допустимого. Ест только белое / только мягкое — сенсорная селективность → пары эквивалентов внутри спектра, не ломка. Ест только в комнате — перегрузка зала → право на место, не принуждение к залу. Сцена — информация о механизме. Пост, который так читает, — первый диагност системы.

10. Дисфагия и аспирационный риск: часто нераспознанная проблема стационарного ухода

10.1. Масштаб, о котором не говорят

Расстройство глотания (дисфагия) при психических расстройствах в отдельных изученных клинических группах встречалось, по разным исследованиям, у 21,9–69,5 % пациентов. Разброс — популяции и методы скрининга. Диапазон **нельзя переносить на все российские ДСО и ПНИ** как единую распространённость^{1, 27}. Даже нижняя граница: проблема не редка. В типовом ПНИ часто нет ни логопеда, ни скрининга, ни назначенных текстур. Дисфагия невидима до первой тяжёлой пневмонии.

Цена измерена. Смертность от пневмонии у людей с тяжёлыми психическими расстройствами в семь раз выше популяционной (RR 7,00 по национальным когортным данным); аспирация — ключевой механизм¹⁷. Разрыв продолжительности жизни — 15–20 лет, и значимая его часть связана с причинами, на которые влияет стол¹⁷. Дисфагия — вопрос смертности.

10.2. Откуда берётся дисфагия при психических расстройствах

Механизмов шесть, в наших домах они идут сразу:

- 1. Лекарственные:** антипсихотики дают экстрапирамидные нарушения мускулатуры глотания и сухость рта (ксеростомия); седация замедляет глотательный рефлекс²⁷.
- 2. Болезненные:** течение расстройства ломает координацию «жевание — глоток — дыхание».
- 3. Поведенческие:** быстрое заглатывание без жевания (раздел 9) перегружает глотание.
- 4. Возрастные:** 65 % жителей старше 45 лет⁷; саркопения и старческая дисфагия накладываются сверху.
- 5. Сопутствующие:** последствия инсультов, болезнь Паркинсона, деменция, эпилепсия.
- 6. Стоматологические:** нет зубов, плохие протезы — «жевательная» задача становится «глотательной».

Дисфагия в ПНИ статистически ожидаема. Система обязана её искать.

10.3. Признаки, которые видит сиделка без логопеда

Скрининг не требует специалиста — обученный глаз и правило записи. Тревожные признаки: покашливание или поперхивание во время еды или после; «влажный», булькающий голос после глотка; многократное проглатывание одного куса; еда «за щекой»; необычно долгий приём; отказ от твёрдого или сухого при сохранном аппетите; повторные пневмонии в анамнезе^{27, 44}. Любой — повод для врача и теста с водой. Несколько — немедленная коррекция подачи до выяснения.

10.4. Текстуры: система IDDSI и её измеримый эффект

Международный стандарт **описания** текстур — IDDSI (восемь уровней: напитки — 0–4, пища — 3–7). «Протёртое» становится проверяемым: вилка, ложка, наклон⁴⁵. Это терминология и проверка консистенции, не диагностика и не лечение. Текстуру назначает уполномоченный медицинский специалист по индивидуальной оценке. Кухня клинику не назначает.

Исследование в пяти учреждениях: соответствие поданных текстур назначенным с 44 % до 90 %, загущённых жидкостей — с 31 % до 100 %; эффект держался 6 месяцев. Барьер — осведомлённость персонала, не техника⁴⁶. Меряется долей правильных текстур на тарелках (чек-лист пищеблока, приложение 19).

10.5. Организационный пакет без логопеда

Дом без реабилитолога — почти каждый — делает пять вещей:

1. **Список риска** по 10.3. Живёт на посту и в кухне, не в истории болезни.
2. **Назначенные текстуры**: врач назначает поимённо (мягкая, протёртая, загущённые жидкости) с датой пересмотра; кухня маркирует порции.
3. **Правила стола**: вертикальная поза, медленный темп, малые глотки, без спешки «на бегу», питьё весь приём, работник до конца еды.
4. **Достоинство текстур**: протёртое не выглядит наказанием. Австралийская практика — подача в формах, имитирующих обычные блюда⁴⁷.
5. **«Осознанный риск»**: настаивает на обычной пище — информированное решение с врачом, не самодеятельность сиделки и не насилие⁴⁷.

10.6. Связка с вариативностью

Дисфагия не отменяет выбор — переносит его внутрь текстуры: два варианта протёртого второго вместо одного (пара эквивалентов, раздел 19). Иначе группа теряет и здоровье, и голос. В карте (приложение 3) текстура и основание — отдельный раздел с датой пересмотра.

10.7. Жидкости: забытая половина дисфагии

Загущение жидкостей — свой контур IDDSI. В исследовании внедрения здесь был самый низкий старт (31 %) и самый большой эффект обучения (до 100 %)⁴⁶. Минимум: загуститель по назначениям, тест стекания с вилки/ложки перед выдачей, кружки с клапанами по показаниям. «Просто меньше пить» ведёт к обезвоживанию; у пожилого оно само провоцирует пневмонии и делирий.

Загущённые напитки снижают потребление жидкости и создают нагрузку лечения; убедительных данных о снижении респираторных осложнений при рутинном применении нет^{48, 49}. «Загустить и забыть» — худшая стратегия. Текстура напитка — решение врача с пересмотром.

Дом без врача мониторит: объём выпитого за сутки («стакан» как единица); предложения жидкости между приёмами (чайная пауза — лежачим и при жаре); у жителей на загущённых — тёмная моча, сухость языка, сонливость вне режима. Панель 22: «выпито за сутки, мл (или стаканов), среднее по группе риска».

Протокол свободной воды (Frazier), если врач считает риск аспирации чистой воды приемлемым: неограниченная чистая вода между приёмами после гигиены полости рта; иначе — назначенная текстура⁴⁸. Не российская норма. Допуск, группу, исключения назначает врач. Дом: гигиена рта до воды и журнал объёма. Без гигиены рта протокол противопоказан: вода смывает бактериальную нагрузку в лёгкие.

10.8. Пакет «без логопеда»: что организация делает своими силами

Специалистов глотания у большинства СОСО нет. Это ограничение, не повод стоять. К пакету 10.5 — четыре элемента.

Распознавание. К 10.3 добавляются длительное пережёвывание без глотка и подтекание изо рта. Один инструктаж. Любой признак → запись → врач.

Поза и темп. 90°, подбородок чуть вниз, малые глотки, паузы, 30 минут после еды без укладывания⁴⁴.

Текстура. IDDSI с вилкой и наклоном⁴⁵ — одно занятие повару. 44 → 90 % поднимали обучением, не оборудованием⁴⁶ (см. 10.4).

Инцидент. Алгоритм приложения 12; два обученных человека на посту в часы еды.

Пакет не лечит, не заменяет инструментальную оценку, не отменяет врача. Переводит дом из «не знаем, кто в риске» в «знаем, наблюдаем, исполняем назначения» — уровень проверки и уровень, который спасает жизни.

10.9. Структурированный скрининг: шкала вместо «опытного глаза»

Признаки 10.3 зависят от наблюдателя. Там, где дисфагия вероятна (тяжёлые нарушения, повторные пневмонии, кашель при еде), нужен валидированный инструмент. **GUSS** (Gugging Swallowing Screen) — четыре шага: непрямая проба, полужидкое, жидкость, твёрдое; валидирован против эндоскопии; выполняет подготовленная медсестра⁵⁰. **EAT-10** — 10 вопросов о симптомах, с жителем или интервью⁵¹. Число в карту, сравнение через полгода.

Созданы не для психиатрического контингента; инструкцию адаптируют. Текстуру назначает врач. GUSS/EAT-10 — по показаниям; шесть признаков — ежедневно всем.

10.10. Гигиена полости рта: самая дешёвая профилактика аспирационной пневмонии

Аспирационная пневмония — главный смертельный риск (10.1). Бактериальная нагрузка формируется во рту. РКИ на 366 проживающих домов ухода: уход после каждого приёма (щётка; в части случаев — повидон-йод) плюс еженедельный осмотр стоматолога снизил пневмонии с 19 % до 11 %⁵². Обзор van der Maarel-Wierink et al. (пять публикаций): улучшение ухода **может снижать** частоту пневмонии и связанную смертность у немощных пожилых⁵³. «Примерно каждая десятая смерть» — узкая выборка, не доказанный эффект для российских ПНИ: дома ухода, не психиатрия.

Не «две минуты на всех 951 место», а **группа зависимости**: кто не чистит зубы сам (постельные, тяжёлая умственная отсталость, выраженная седация). Формула: зависимые × 2–3 минуты × приёмы. На 80 зависимых и три приёма — около 8 человеко-часов в сутки: ставка, не жест. Минимум: щётка/губка и паста не «по запросу»; строка обхода («рот осмотрен, обработан»); обучение смены. Панель 22: «осмотр полости рта выполнен, % группы риска». Протезы: плохо сидящие и сухость во рту — две главные жалобы домов ухода⁵⁴. Протез, мешающий жевать, маскирует «плохой аппетит» (раздел 12).

10.11. Зондовое и энтеральное питание: отдельный контур, не «без выбора»

Для зонда и гастростомы вариативность — не два вторых на линии, а **время, объём, положение, вкус разрешённых пастообразных добавок** (если врач допускает пероральные пробы) и ритуал стола: сидеть со всеми, не есть в палате как исключённый. Прямых исследований вариативного меню при энтеральном питании в ПНИ нет. Смесь, скорость, положение — только врач. График вне пика седации; «нельзя в столовую» — не дисциплина. Пероральная проба при зонде — информированное решение врача, не инициатива смены.

11. Лекарства и еда: пять правил, которые обязана знать кухня

11.1. Принцип раздела

Взаимодействий «препарат — пища» — десятки. Стол держит не справочник, а перечень с действием для кухни, поста и меню. **(установлено)** — исследования и официальные инструкции/справочники. **(мониторинг)** — стабильность и наблюдение, не запрет. **(рекомендация)** — предосторожность руководств.

11.2. Правило 1. Клозапин – кофеин: считать чашки (установлено)

Кофеин ингибирует метаболизм клозапина: в контролируемом исследовании добавление кофеина повышало AUC в среднем на 19 %¹⁸; резкий рост потребления доводил концентрацию до токсических значений (случай 1796 нг/мл)²⁸. Резкая отмена привычного кофеина: падение на 37–47 % с риском потери эффекта⁵⁵. Курение индуцирует метаболизм клозапина и оланзапина, снижая концентрации примерно вдвое; резкое прекращение без коррекции опасно¹⁸.

Действия: в карте — привычное потребление кофе/чая/энергетиков; запрет на резкие изменения (семья письменно, приложение 32); кофе не «награда» и не «наказание»; изменение привычки — врачу. Правило входит в британскую таблицу в меню³⁹.

11.3. Правило 2. Литий – соль и вода: стабильность, а не запрет (мониторинг)

Литий чувствителен к водно-солевому балансу. Резкое уменьшение соли или обезвоживание повышают концентрацию до токсической (дрожь, спутанность, рвота); резкое увеличение снижают эффект^{19, 56}. Опасные сцены: «малосольный стол» по инициативе кухни; жара без воды; рвота/диарея; отказ от питья при обострении. Кухня не назначает солевой режим.

Действия: без врача солевой режим не меняют; вода видна, не «по просьбе»; рвота/диарея или жара — врачу в тот же день; отказ от еды и питья — эскалация раздела 12 сокращается.

11.4. Правило 3. ИМАО – тирамин: тираминовая разметка меню (установлено)

Неселективные ингибиторы МАО (редко, но назначают) с тирамином дают гипертонический криз: выдержанные и плесневые сыры, копчёности, соленья, брынза, пиво, квас домашний, соевый соус^{20, 57}. Описано: давление со 160/90 до 220/115 и выше⁵⁸.

Действия: отдельная строка в меню-потребности; кухня получает тираминовую разметку от врача; выбор — внутри безопасного множества. Вариативность полная.

11.5. Правило 4. Грейпфрут – ряд психотропных: исключить по списку (установлено)

Грейпфрут и его сок ингибируют CYP3A4 и повышают концентрации. Для карбамазепина — рост AUC порядка 40 %²¹. В зоне внимания — некоторые бензодиазепины и часть антипсихотиков.

Действия: грейпфрут и сок не входят в закупку и в меню вовсе; «подарочные» фрукты проверяет дежурный. Одна строка в положении закрывает вопрос.

11.6. Правило 5. Алкоголь и энергетики: нулевая терпимость + серые зоны (рекомендация)

Алкоголь при психотропных непредсказуемо усиливает седацию и риски. В стационаре исключён полностью — в правилах передач. Серая зона — энергетики (кофеин + стимуляторы): для клозапина это правило 1, для тревожных и биполярных — провокация. Энергетики в буфете закрывает ассортиментный перечень.

11.7. Лекарственно-пищевая таблица: форма

Пять правил — таблица (приложение 21): препарат — недопустимо/контролируется — кухня — пост — врачу. Заполняет врач по назначениям, пересматривает при смене терапии. Копии: пост, кухня, комната передач. BDA встраивает такую таблицу в меню и в информирование пациентов³⁹. Наша форма — тем же российским документооборотом.

11.8. Чего в разделе нет

Перечень не исчерпывающий: полный список ведёт врач. Кухня не трактует инструкции: исполняет таблицу. Правила задают границы, внутри которых выбор полный.

11.9. Передачи как фармакологический канал

Без управления комната передач — неконтролируемая аптека. Кофе, крепкий чай, энергетики, грейпфруты, копчёности, алкоголь приходят оттуда — с любовью и без рецепта. Порядок: перечень на стенде (санитарный и лекарственный блоки отдельно), регистрация, маркировка, выдача по режиму для позиций таблицы. Памятка (приложение 32): «проверяем передачи, потому что у вашего близкого лекарства конфликтуют с продуктами».

11.10. Границы таблицы

Таблица (приложение 21) — минимум дома, не справочник. Полный справочник — у врача и в аптечных системах. Полная фармакология на посту не читается. Классы уверенности учат смену: «установлено» (клозапин – кофеин, литий – соль) и «осторожность по классу» (отдельные комбинации ИМАО) — разная жёсткость при разной доказательности.

11.11. Три сценария из практики поста

«Добрый кофе». Житель на клозапине — термос от близких. Кофеин ингибирует CYP1A2; случай 1796 нг/мл с тяжёлой клиникой²⁸; популяционно AUC +19 % уже при обычном потреблении¹⁸. Не конфискация со скандалом — врачу и согласованный режим. Резкая отмена: –37–47 %⁵⁵.

«Солёные огурцы к выходным». Солёная передача раз в неделю на литии. Натрий конкурирует с литием за выведение^{19, 56}. Не запрет огурцов — стабильность и врач.

«Сок вместо воды». Грейпфрутовый сок «для витаминов» на карбамазепине: +40 %²¹. Исключение на уровне кухни, не памяти смены.

Ловятся конструкцией: таблица, правило передач, «увидел → врачу сегодня».

12. Отказ от еды: от первого пропуска до врачебного решения

12.1. Почему отказ — самая опасная бытовая ситуация

Отказ в ПНИ случается ежедневно и обрабатывается «глазами»: заметил, сказал, решил. За ним — «невкусно», депрессия, психоз, дисфагия, соматика, предсмертный период. Пропущенный «каприз» стоит тарелки; пропущенная дисфагия или депрессия — жизни^{17,27}. Нужен алгоритм, не интуиция дежурного.

12.2. Классификация причин

Шесть корзин, у каждой — владелец решения:

Причина	Признаки	Владелец решения
Организационная («невкусно», «не то», «холодное»)	Избирательно, на конкретные блюда; остальное ест	Кухня + администрация
Состояние (депрессия, тревога, психоз)	Изменение поведения, сна, контакта	Врач
Лекарственная (тошнота, седация, сухость)	Совпадает с назначением/сменой терапии	Врач
Дисфагия/соматика	Покашливание, долгий приём, боль, запор	Врач (срочно)
Осознанный отказ конкретного человека	Аргументированный, стабильный, при ясном состоянии	Житель (фиксируется)
Предсмертный период	Общее угасание, паллиативный статус	Врач + паллиативная служба

Смешение корзин — главная ошибка: «осознанный отказ» лечат как симптом, симптом списывают на «характер».

Строки «болит жевать» в таблице нет — частая маска. Плохо сидящие протезы и сухость во рту — две главные проблемы полости рта у проживающих домов ухода; их сообщают более половины опрошенных⁵⁴. Выглядит как «плохо ест твёрдое, просит мягкое» и уходит в «организационную», хотя место — в стоматологическом маршруте. Вопрос «болит ли жевать, мешает ли что-то во рту» разделяет пути за десять секунд. Рот и протезы — в пищевом паспорте при поступлении (приложение 37).

12.3. Алгоритм эскалации

Канадское регулирование: отказ от трёх приёмов подряд и оставление ≥25 % порции за двумя из трёх приёмов за неделю — триггеры врачебной оценки^{26, 59}. Проект российского правила (не российская норма — маркировка обязательна):

1. **Каждый отказ фиксируется** в журнале (приложение 9): кто, приём, что отвергнуто, сколько съедено, поведение.
2. **Отказ → альтернатива** в тот же приём по таблице. Житель не остаётся голодным — норма американского федерального правила³⁸.
3. **Три отказа подряд → врач в тот же день**. Не «на обходе в четверг», не «завтра утром».
4. **≥25 % порций несъедено системно за неделю → врач + пересмотр карты** (два дня).
5. **Отказ от воды или от еды и воды → немедленно**. Обезвоживание при литии и ряде препаратов — прямая угроза⁵⁶.
6. **Эпизод закрывается записью**: что установлено, что назначено, когда пересмотр.

12.4. Насилие недопустимо — и что это значит юридически

«Кормить силой» недопустимо безоговорочно. Это насилие, противоречащее праву на уважительное и гуманное отношение, исключаящее унижение достоинства (ст. 5 ч. 2 Закона № 3185-1). Статья 43 распространяет на проживающих в стационарных организациях социального обслуживания права ст. 37; ч. 2 ст. 37 — перечень прав пациентов психиатрического стационара, не норма о гуманном обращении¹¹. Иное — медицинское искусственное питание: решает врач по законодательству об охране здоровья и правилам психиатрической помощи. Доклад в эту плоскость не входит. Граница: предлагают, заменяют, адаптируют, фиксируют, эскалируют — силой не вводят.

12.5. Дееспособность и осознанный отказ

Британская модель: дееспособность — по конкретному решению в конкретный момент. Человек с психическим расстройством может быть способен отказаться от конкретного приёма — решение фиксируется и уважается⁴². Российская рамка иная (раздел 16): недееспособность не отменяет учёта мнения; отношение к бытовому вопросу оценивается по существу¹¹. Форма: слова жителя в журнале («отказался от ужина, поел в 21:00 по просьбе») — данные, не «нарушение».

12.6. Предсмертный период

В паллиативной фазе нутритивные цели уступают комфорту. Wunschkost: то, что человек хочет и может, важнее полноты^{31, 41}. Для ПНИ со стареющим контингентом⁷ маршрут питания существует письменно: кто определяет статус, как меняется меню, как информируется семья. Оформление — комплект раздела 31.

12.7. Что сказать смене в понедельник

Журнал отказов. «Три подряд → врач сегодня». Альтернатива при каждом отказе. Список дисфагического риска на посту. Стоимость — тетрадь и инструктаж.

12.8. Что говорить жителю: фразы смены

Слова в момент отказа рождаются плохие: «ну что ты, давай ложечку». Готовые формулы. От блюда: «Хорошо, это уберу. Есть ещё __, принести?» — без «почему» и без оценки. От еды: «Не будете сейчас — оставляю, скажете, когда захотите» — контроль жителю, еда сохраняется. «Отравлено»: «Я вас услышала. Скажу врачу, он придёт сегодня. Хотите, принесу в упаковке?» — без спора с содержанием. Запрещены: «а кто будет доедать», «врач сказал надо», «в последний раз предлагаю».

12.9. Насилие: почему формулировка жёсткая

Запрет 12.4 без оговорок сознателен. «Принуждение в исключительных случаях» в стационаре расширяется усталостью смен и дефицитом рук. Удержание, вливание, шантаж, лишение «пока не съешь» недопустимы всегда. Истощение решает врач (назначения, энтеральная поддержка по показаниям, госпитализация), не сила смены. Эпизод принудительного кормления — готовый сюжет для прокуратуры¹¹.

12.10. Разбор эскалации по часам

Правило работает с часами и фамилиями. Завтрак 8:30 — отказ в журнале к 9:00, замена предложена. Обед 13:00 — второй отказ; старшая смены выясняет контекст до 14:00 (болен? конфликт? «отравлено?»). Ужин 17:30 — третий; 18:00 — дежурному врачу или по телефону; решение письменно тем же вечером.

Три провала. «Подожждём утреннего обхода» — обход через сутки; для бреда поздно. «Передадим устно» — второй отказ теряется, счёт с нуля. «Наблюдайте» без записи — не решение; в записи: что, как часто, когда пересмотр. Три-четыре сообщения в месяц — рабочий поток. Никогда — вопрос, ведётся ли журнал.

12.11. Паллиативное питание: comfort feeding и границы искусственного питания

В периоде 12.6 отказ — часть процесса. Вопрос не «как накормить», а «что еда делает для человека». **Comfort feeding** (комфортное кормление): еда и питьё, пока приносят комфорт — любимые блюда, малые порции, помощь и время — без принуждения и без искусственного питания против воли⁶⁰.

Исходы читать точно. Ретроспективное госпитальное исследование после рекомендаций comfort feeding — без группы сравнения: среди глубоко паллиативных госпитализированных с деменцией медиана выживаемости — 13 дней⁶¹. Описывает популяцию, не сравнивает режимы; вывода «не меняет выживаемость» не содержит. Обзор перорального питания при деменции фиксирует прибавку веса при высококалорийных добавках, нет доказанных эффектов на другие исходы, сильна роль предпочтений и культуры ухода⁶⁰. Рамка меняет качество процесса, не доказанно длительность.

Локальный акт — три строки: (1) формат в конце жизни определяет врач с семьёй и, где возможно, с жителем; (2) любимые блюда и доступные текстуры — элемент паллиативного контура, не «поблажка»; (3) отказ документируется по 12.4–12.5. *Маркировка: comfort feeding — международный ориентир, не российская норма; зондовое и парентеральное питание — исключительно врачебное решение (раздел 18 семинарского пакета: «не без врача»).*

13. Переедание, гиперфагия и ночное едение

13.1. Метаболическая цена антипсихотиков: что доказано

Прибавка веса на антипсихотиках — измеренный классовый эффект с большим разбросом, не «особенность». Мета-анализ 100 рандомизированных исследований (Pillinger и соавт., 2020): от −0,23 кг до +3,01 кг за шесть недель¹⁶. Клинически значимая прибавка (≥7 % массы тела) при длительном применении (около 38 недель, Campforts и соавт., 2023, BJPsych Open, DOI bjo.2022.619): клозапин — 76,3 %, оланзапин — 36,9 %, рисперидон — 23,0 %⁸². Первый эпизод психоза: долгосрочно +9,34 кг (оланзапин) и +7,19 кг (клозапин)⁶³. Мониторинг предписан: вес, глюкоза, липиды по расписанию⁶⁴.

Переедание на весогенном препарате — гиперфагия, не «прожорливость»; дисциплина здесь ошибка. Кухня не лечит голоданием: самостоятельные ограничения без врача незаконны (раздел 17) и опасны. Клинику кухни не назначает.

13.2. Пищевое поведение: что показывают исследования

RESOLVE при тяжёлых психических расстройствах: переёдание 4,4–45 %, тяга к еде (food craving) 16,1–64 %, ночное едение 4–30 %⁴³. Широта — методы и популяции; даже нижние границы — заметный контингент в каждом доме.

Вмешательства по весу скромны. Мета-анализ образа жизни: порядка –1,4 кг⁶⁵; программа с диетологом (Teasdale) лучше именно при специалисте⁶⁶. Марафон с малыми цифрами. Ядро — среда, мониторинг, врач, не ограничения.

13.3. Что может организация питания (без подмены врача)

Мониторинг веса. Старт терапии, 4-я, 8-я, 12-я неделя и далее. Триггеры +5 % за 3 месяца и онтарианские пороги 5/7,5/10 % — сигналы врачу^{64, 26}. Весы, журнал, ответственный — стоимость нулевая.

Среда вместо запретов. Доступное между приёмами важнее запрещённого: фрукты и кисломолочное вместо выпечки; нет энергетиков, лимит сладких напитков (раздел 11); приёмы без «дыр». Это не диета и не режет порций — законно без врача.

Добавка по правилам. «Дай вторую котлету» (кейс раздела 5) закрывает письменный порядок: кому, что, когда. Ограничение порций — только врач, только поимённо (раздел 17).

13.4. Ночное едение: не наказывать, а структурировать

Ночные набеги (4–30 %⁴³) имеют три корня: препаратная гиперфагия, сон-аппетит, тревога. Замок на кухне добавляет тревогу, конфликт, поиск еды вне дома. **Структурированная ночная доступность:** поздний перекус по расписанию; вода, чай, сухой перекус на посту.

Та же мера сокращает интервал «ужин — завтрак». Международные нормы: 11–14 ч^{33, 38}. 14 ч — верх CMS (США), не российская норма и не цель. Рабочая цель дома — ≤13 ч. Одна бесплатная мера закрывает две задачи — поведенческую и нормативную.

13.5. Когда вопрос клинический

Врачу: +5 % и более за 3 месяца на препарате; гиперфагия, ломающая режим; ночное едение как синдром; любой запрос «посадить на диету». Только врач: смена препарата, ограничительный рацион, эндокринолог, метформин. Дом даёт вес, журнал, карту и исполняет назначения.

13.6. Что сказать повару в понедельник

Вес с триггерами, правила добавки, ночная доступность. «Посадить на диету» без врача нельзя. Выбор внутри среды снижает конфликт.

13.7. Разговор с жителем о весе: без стыда

«Воспитательные беседы» бесполезны и жестоки: весогенность не лечится стыдом¹⁶. Формула: «побочный эффект лечения, который мы вместе обходим», не «ваше переёдание». Инструменты: объёмные низкокалорийные добавки, дробность, доступность по режиму, активность. Понимающий порцию сотрудничает. Без объяснений обходит — передачи, чужие тарелки, подполье, где калорий больше.

13.8. Метаболический мониторинг как часть питания

Вес и сахар — предмет кухни не меньше кабинета. Антипсихотики различаются на килограммы за недели¹⁶; при первом эпизоде +9,34 кг на оланзапине⁶³; мониторинг на практике неполный⁶⁴. Для СОСО: ежемесячно, одни весы, одно время; >5 % за квартал → врач и пересмотр плана.

Отдельно — недостаточность, не набор. MUST (Malnutrition Universal Screening Tool, BAPEN) — пять шагов: ИМТ, непреднамеренная потеря >5 % за 3–6 месяцев, острое заболевание; в домах ухода обычно ежемесячно⁶⁷. Это не «+5 % на оланзапине»: набор и потеря — две строки панели 22. Заполняет медсестра или врач. Кухня даёт вес и факт поедания, категорию риска не ставит. Лежащий без кресла-весов: строка «вес» — фикция. Онтарио: ≥5 % / 30 дней, ≥7,5 % / 90, ≥10 % / 180²⁶ — врачу сегодня.

13.9. Ночная доступность: конструкция, а не «открытый холодильник»

Не свободный доступ к кухне и не «ночью ничего нет». Четыре элемента к 13.4. **Перечень** — два-три продукта с врачом (кефир, хлеб, фрукты по сезону; при метаболическом риске — низкокалорийные объёмные). **Место** — пост или буфет отделения, не кухня. **Режим** — окно (например, 21:00–22:00 и при ночном пробуждении), запись. **Границы** — гиперфагия порционно, не «возьми сам».

Клинически: едение перестаёт быть подпольным. Право: ночная еда — услуга, не «нарушение режима». 4–30 %⁴³ на 30 человек — от одного до девяти еженощно. Вопрос — «подпольно или организовано».

13.10. Запор: скрытый регулятор аппетита и поведения

Сниженный аппетит, «необъяснимое» беспокойство, отказы часто имеют причину — запор. На клозапине: 30–60 %; гипомотильность ЖКТ при объективных исследованиях — до 80 %; исход — илеус, перфорация, смерть. TGA (Австралия) ввёл предупреждение в инструкцию⁶⁸. NHS называет запор при клозапине потенциально фатальным: мониторинг стула и профилактические слабительные по назначению врача⁶⁹.

Стол: да/нет стула за сутки в постовом журнале, без деталей; вода и клетчатка в меню, не «по просьбе»; движение после еды. Трое суток без стула в группе антихолинергической нагрузки — врач сегодня. Журнал — сведения о здоровье: пост и врач, не кухня и не «все смены»; основание — соцслужбы / 152-ФЗ (раздел 17.6); диагноз не пишется. *Маркировка: питание — поддержка и мониторинг; слабительные, диагностика, подбор — только врач (раздел 18 семинарского пакета: «не без врача»).*

13.11. Микронутриенты: то, что не видно на весах

Мониторинг 13.8 не видит дефицитов настроения, когнитии, аппетита. **Витамин D:** дефицит в психиатрической популяции распространён, рутинный скрининг рекомендован⁷⁰; карбамазепин — фермент-индуктор, мета-анализ связывает его со снижением 25(OH)D⁷¹; он уже в таблице раздела 11. **B12 и фолат:** с возрастом, связаны с депрессией и когнитивными нарушениями, недодиагностируются у пожилых⁷². **Железо:** редкое мясо плюс потери — анемия под маской «усталость и не ест». Дом спрашивает и подсвечивает: «профиль микронутриентов обсудить с врачом» в годовом маршруте антиконвульсантов и вегетарианцев. Анализы и добавки — врач⁷⁰.

13.12. Инсулин и время еды: гибкий стол без гипогликемии

Диабет в стационаре обычен; вариативность ломает «все едят в одно время». Инъекция привязана к раздаче, житель выбрал отложенный приём или другой объём — клинический риск. Прямых российских норм «инсулин × вариативное меню» нет. Список на инсулине — у поста и кухни без диагноза в открытом доступе («время еды фиксировано / гибкое»). Сдвиг больше [локальный порог, согласовать с врачом] — только с отметкой врача. Отложенный обед — с переносом инъекции или не предлагается. Гибкость остальных не страдает. *Только врач меняет схему; организация не сдвигает инсулин «по договорённости смены».*

14. Пикацизм, заглатывание и другие поведенческие риски за столом

14.1. Круг рисков

Помимо паттернов 9–13, столовая ПНИ встречается с рисками, редкими по отдельности и неизбежными в сумме. Их не лечит организация — ими управляет. Цена — безопасность.

Пикацизм (поедание несъедобного). Бумага, земля, мел, вата, бытовая химия, чужие лекарства. Умственная отсталость, психозы, деменция. Среда без доступных опасных объектов (химия и медикаменты вне досягаемости — отдельный учёт); наблюдение за зафиксированным пикацизмом за едой и на прогулке; информирование всей смены, не только врача. Запись в карте обязательна: это пищевая безопасность не меньше аллергии.

Быстрое заглатывание. В разделе 9 — паттерн; здесь — риск. Как у дисфагии: непрожёванный кусок перекрывает дыхательные пути. Удушье пищей (choking) — документированная причина смерти в психиатрических учреждениях⁴⁴. Малые порции с добавкой, без крупных сухих кусков, посадка рядом с работником, приём Геймлиха у смены. Это пищевая безопасность, не «первая помощь вообще».

Отбирание еды и «грабёж» стола. Гиперфагия на препаратах (раздел 13), недокорм прошлого опыта, поведение. Рассадка не рядом с медленными едоками группы риска; правила добавки; вес обоих. Жертву не делают виноватой: порция восполняется всегда.

Опрокидывание, бросание, отказ от приборов. Возбуждение или протест. Посуда без стекла; finger food как штатная опция (BDA включает его именно для этого)³⁹; отдельный стол; приём после снижения возбуждения — отложенная порция вместо пропущенной (раздел 12).

Ритуалы и пищевые «правила». Цвет, своя тарелка, порядок блюд. Пока не опасен — учитывается, не «лечится»: самый дешёвый вид персонализации. Карта фиксирует как данность, кухня считается.

14.2. Общий протокол: среда, наблюдение, запись, эскалация

Четвёрка для локального акта:

- 1. Среда:** опасное вне досягаемости; посуда безопасная; рассадка продуманная.
- 2. Наблюдение:** работник за столом видит, не только подаёт. «Обеденный дежурный» — штатная роль.
- 3. Запись:** пика, заглатывание с поперхиванием, отбирание, опрокидывание — строка в журнале, не рассказ «на кухне».
- 4. Эскалация:** повтор — врач; угроза (поперхивание, несъедобное, чужое лекарство) — врач немедленно.

14.3. Граница с насилием — вторая сторона

Соблазн: связать, запереть, изолировать от еды, кормить отдельно «наказанием». Вне закона (ст. 37 Закона № 3185-1: гуманное отношение и уважение достоинства)¹¹ и вне доказательности: сила не меняет гиперфагию, пикацизм, заглатывание. Изоляция при возбуждении — клиническая процедура (питание по 12.4 и BDA³⁹), не «дисциплина за столом». Локальный акт запрещает: лишение еды как меру, ограничение питья, «штрафные» порции. Строка положения защищает жителя и директора.

Здесь дешевле предвидение. Один инструктаж (среда — наблюдение — запись — эскалация), безопасная посуда, раскладка и добавка, запрет «едовых наказаний» — и эпизод кончается записью, не травмой.

14.5. Заглатывание предметов: граница с соматикой

Проглоченный предмет — соматика. Стул, температура, боль в животе в последующие дни — по назначению врача, с записью. «Проглотил — вышло — забыли» опасно: часть предметов травмирует не сразу. Каждый эпизод — протокол разбора (приложение 34). Вопрос не «кто недосмотрел», а «как предмет оказался доступен»: второй чинит систему, первый учит смену молчать.

14.6. Пикацизм и кухня: точка пересечения

Часть эпизодов — поиск еды несоциальными способами на фоне голода (реального или субъективного при гиперфагии). Два инструмента: структурированная доступность (перекусы снижают поисковое поведение) и безопасный буфет (нет ничего, что нельзя есть). Правильный стол здесь — профилактика инцидентов.

14.7. Протокол «среда — наблюдение — запись — эскалация» на практике

Четыре звена 14.2 — по людям и часам. **Среда:** еженедельный осмотр зоны старшей сменой (мелкие предметы, оторванная одежда и мебель, моющие, пуговицы и шнурки), строка с подписью; десять минут ловят риск до эпизода. **Наблюдение:** не «смотреть постоянно», а окна риска — скука и безструктурное время после еды; занятие, прогулка, присутствие сильнее надзора. **Запись:** что, когда, где, что предшествовало; серия за месяц даёт паттерн. **Эскалация:** врач при первом эпизоде (пикацизм — симптом, не «привычка»: дефициты, компульсии); скорая — при опасном проглатывании. Замещение: жевательные альтернативы и доступность еды с врачом. Как ночная доступность (раздел 13): нет легального выхода — поведение уходит в подполье.

15. Невербальный выбор: как услышать того, кто не говорит

БЛОК I.4. ПРАВО И САНИТАРИЯ: НЕВЕРБАЛЬНЫЙ ВЫБОР, ДЕЕСПОСОБНОСТЬ, ПРАВО РФ, САНПИН (15–18)

15.1. Масштаб вопроса

Три четверти жителей российских ПНИ признаны недееспособными⁷. Значимая часть остальных не скажет выбора словом: неговорящие и малоговорящие, глубокая умственная отсталость, деменция, острые состояния. Если вариативность стоит на вопросе «что будете?», она сама отсекает большинство. Технология выбора для тех, кто не говорит, — ядро системы, не пристройка.

15.2. Правовая рамка: поддержанное, а не подменяющее решение

Международный стандарт — Замечание общего порядка № 1 к ст. 12 Конвенции о правах инвалидов: «мы знаем лучше» подлежит замене поддержкой. Человек получает помощь, чтобы выразить свою волю; воля и предпочтения не подменяются «лучшими интересами»²⁹. Российское право этой логике не противоречит, но основания нельзя смешивать. Статья 43 Закона № 3185-1 задаёт статус и права проживающих в стационаре¹¹. Обязанность опекуна учитывать мнение подопечного и сведения о его предпочтениях — из ст. 29 ГК РФ и 48-ФЗ. 442-ФЗ закрепляет права получателя и индивидуализацию услуг. Выбор еды — бытовое решение, не сделка: неспособность к сделкам не отменяет способности предпочитать.

Маркировка: этот абзац — системное толкование норм, а не прямое правило закона; прямой нормы «выбор блюда не требует дееспособности» в российском законодательстве нет. Практические формы ниже — проект локальной практики.

15.3. Четыре канала воли

Канал 1. Показ вместо вопроса. Вербальный выбор требует удержать в памяти два слова и соотнести их с опытом — многим это непосильно. Две реальные порции снимают задачу: человек указывает, тянется, смотрит, отворачивается. Практика деменс-ухода рекомендует визуальный выбор вместо вербального^{73, 39}. Вариант Б должен физически стоять на линии: без минимальной вариативности показ двух порций невозможен (ступень 1, раздел 8).

Канал 2. Наблюдение за потреблением. Тарелка — это голос. Систематически несъеденное — зафиксированное «нет», доеденное до конца — «да». Журнал потребления (раздел 9) становится документом предпочтений.

Скандинавские муниципальные стандарты прямо требуют документировать наблюдаемые предпочтения тех, кто не сообщает их словами⁷⁴.

Канал 3. Пищевая биография в «хороший день». Пока состояние позволяет, с жителем — и с семьёй, с прежними работниками — заполняется пищевая биография: любимое, нелюбимое, ритуалы, «детские» блюда, распорядок⁸¹. Документ держит волю периода максимальной ясности, когда ясности меньше, — приоритет зафиксированной воли²⁹. Форма — приложение 3.

Канал 4. Те, кто знает человека. Семья, опекун, давние работники — источники интерпретации воли, а не «решающие за него». Сведения входят в пищевую карту с указанием источника²⁹.

15.4. Иерархия источников при расхождении

Порядок фиксируется в локальном акте: (1) зафиксированная воля самого жителя (пищевая биография, устойчивые предпочтения); (2) текущая демонстрируемая воля (показ, жест); (3) сведения близких; (4) медицинские ограничения по назначению врача — сужают пункты 1–3 только при реальной клинической необходимости; (5) удобство кухни в иерархию не входит. Медицинское ограничение не отменяет выбор, а задаёт его множество: австрийский стандарт требует вовлекать проживающего в решение о диете⁴¹.

15.5. Технология на линии: сценарий для смены

Сценарий показа, проверенный логикой российских внедрений^{2, 3}:

1. На линии — два варианта в одинаковых гастрорёмкостях, на виду.
2. Работник показывает обе порции неговорящему жителю, называя их просто: «гречка — рис».
3. Реакция — один из четырёх значков журнала: указал / потянулся / отвернулся / без реакции.
4. Нет реакции — вариант по пищевой карте (зафиксированное предпочтение), не «первый по очереди».
5. Потребление фиксируется и корректирует карту.

На одного жителя — 15–20 секунд; на отделение — несколько добавочных минут на линии, которые окупаются снижением несъеденных порций.

«Наши не могут выбирать» — самое частое возражение (раздел 37) и самое проверяемое. Три дня: покажите трём неговорящим две порции и запишите реакцию. Обычно «не может» значит «никогда не спрашивали доступным способом». Где 74 % жителей недееспособны⁷, невербальный выбор и есть вариативность, а не её запасной ход для меньшинства.

15.7. Обучение смены чтению воли: три упражнения

Навык считывания тренируется. Три упражнения инструктажа: «молчаливый заказ» — сотрудники заказывают друг у друга без слов и проверяют, как их поняли; «перестановка» — тест позиционного эффекта на себе; «неделя наблюдения» — мини-журнал одного жителя и защита вывода перед сменой. После этого форма приложения 6 — уже запись того, что смена умеет видеть, а не бумажка.

15.8. Ошибка «профессионального чтения»

Риск — уверенность смены: «я его десять лет знаю». Опыт ценен и непроверяем: знание живёт в голове и уходит с ротацией. Любое «я знаю» переводится в запись — карта, форма наблюдения — в течение недели; непереверённое для системы не существует. Это звучит бюрократично до первой смены кадров. После неё это единственный способ не потерять человека вместе с ушедшей сиделкой.

15.9. Иерархия источников воли: кто на каком месте

Каналы противоречат регулярно. Без заранее объявленной иерархии побеждает тот, кто говорит громче. Рабочий порядок из пяти уровней — иной, чем в 15.4; оба записываются в положение о питании. 1) **текущее выраженное предпочтение жителя** (жест, показ, отказ, съеденное) — сильнейший источник, пока не противоречит назначениям врача; 2) **зафиксированная биография** (приложение 3) — воля ясного периода сильнее текущих догадок окружающих; 3) **систематическое наблюдение** (форма приложения 6, серия записей) — сильнее единичного впечатления любого сотрудника; 4) **сведения близких** — данные биографии, но уступают наблюдению при расхождении («дома он любил» — здесь два месяца не ест); 5) **«усреднённое благо»** («всем полезно») — слабейший источник, только когда первые четыре пусты. Спор родственников, смены и администрации о том, «что он на самом деле хочет», уходит из плоскости мнений на этажи: этаж решает.

15.10. Культурные и религиозные рамки стола

Каналы 15.3 работают и когда предпочтение задано не вкусом, а традицией: халяль или кашрут, пост (в том числе многодневный), вегетарианство, отказ от продуктов по убеждению. Для 51 региона с разным конфессиональным составом это обычная часть контингента — и вопрос достоинства в смысле ст. 37 через ст. 43 закона № 3185-1¹¹. Нормы Онтарио требуют при поступлении нутритивной оценки культурных, духовных и религиозных

предпочтений и планирования меню с их учётом²⁶. Российской рамки такого пункта нет, запрета тоже нет: «индивидуальные потребности» 442-ФЗ покрывают и его⁷⁵. Минимум: два вопроса в пищевой биографии («есть ли пища, которую вы не едите по убеждению или вере?»; «соблюдаете ли посты?») и строка в заказе — «ограничения по убеждению». Если таких жителей больше двух-трёх, в цикле держат пару блюд под основные рамки (постное горячее как регулярная позиция): дешевле индивидуальной готовки, без новой строки сметы. Религиозное ограничение — волеизъявление того же достоинства, что «не люблю рыбу», не медицинская диета и не основание для худшего рациона. Форма — пищевой паспорт (приложение 37).

15.11. Постные и религиозные меню-циклы: маркировка «пост — не диета»

Минимум цикла: постное горячее 2–3 раза в неделю в периоды многодневных постов (Великий пост, Рамадан, Рождественский пост), постные гарниры ежедневно (крупы, овощи — они и так в раскладке), маркировка постных позиций в визуальном меню. Три правила. **Первое: пост — волеизъявление, не назначение.** При медицинских показаниях (сахарный диабет, белково-энергетическая недостаточность, анемия) постное меню согласуется с врачом; «постное» не должно стать «неполноценным». Ограничение по убеждению не отменяет нормы питания (приказ Минтруда 520н)³²: постный суп на воде без белка обед не заменяет. **Второе: отказ от поста — право жителя в любой день.** Рамка 15.10 работает симметрично: давление в пользу поста так же недопустимо, как против него. **Третье: пост не меняет санитарного контура.** Суточные пробы, бракераж, температурный режим — те же (раздел 18). Формы: строка «ограничения по убеждению» в заказе (15.10) и пищевой паспорт (приложение 37).

16. Дееспособность, опека и выбор еды: карта решений

16.1. Постановка вопроса

Тема семинара — права, свободы и интересы жителей. В питании они упираются в вопрос, который редко ставят прямо: кто вправе решать, что ест недееспособный житель, — и вправе ли вообще кто-то, кроме него? Раздел даёт карту: двенадцать вопросов с ответами «прямая норма / системное толкование / открытый вопрос». Маркировку держим строго. Именно здесь директору опаснее всего опереться на красивую, но неподдержанную формулу.

16.2. Нормативная основа

Три федеральных столпа. **ГК РФ:** признание гражданина недееспособным (ст. 29) означает, что сделки от его имени совершает опекун (п. 2 ст. 29); опека оформляет отношения по ст. 31–32. Опекун учитывает мнение подопечного; если его невозможно установить — сведения о предпочтениях. Мелкие бытовые сделки без согласия попечителя допускаются **ограниченно дееспособным** (п. 1 ст. 30; при ограничении дееспособности вследствие психического расстройства — п. 2 ст. 30 со ссылкой на подп. 1 п. 2 ст. 26), а не недееспособным — режимы нельзя смешивать. Повседневное пищевое предпочтение (выбор блюда при раздаче) обычно не гражданско-правовая сделка: элемент ухода и права на достоинство. Недееспособность не снимает обязанности выяснять и учитывать мнение (ст. 29 ГК, 48-ФЗ). **48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»:** обязанности опекуна — забота о содержании и учёт мнения подопечного. **Закон № 3185-1:** ст. 37 — права пациентов психиатрических стационаров (гуманное отношение, достоинство, обращения, представительство); ст. 43 распространяет эти права на проживающих в стационарных организациях социального обслуживания для лиц с психическими расстройствами и требует ежегодного освидетельствования комиссией врачей с участием психиатра — в том числе для решения о переводе в организацию общего типа¹¹. Статья 43 задаёт **статус** проживающих, не норму «опекун учитывает мнение»: последняя — из ст. 29 ГК и 48-ФЗ. **442-ФЗ:** права получателя (ст. 9), индивидуальная программа (ИППСУ, ст. 16) и учёт индивидуальных потребностей⁷⁵.

16.3. Карта решений: двенадцать вопросов

№	Вопрос	Ответ	Уровень
1	Отменяет ли недееспособность бытовые предпочтения?	Нет. Недееспособность касается сделок, не вкусов	Прямое следствие ст. 29 ГК; ст. 37/43 3185-1 — статус проживающих
2	Является ли выбор блюда «сделкой», требующей дееспособности?	Нет; бытовой акт	Системное толкование
3	Обязано ли учреждение учитывать мнение жителя, признанного судом недееспособным?	Да, при решении вопросов, затрагивающих его интересы	Норма (ст. 29 ГК; 48-ФЗ); не ст. 43 3185-1
4	Может ли опекун «запретить» жителю конкретное блюдо?	Только в рамках медицинских назначений; вкусы — не компетенция опекуна	Системное толкование

№	Вопрос	Ответ	Уровень
5	Что делать, если учреждение само — опекун жителя?	Конфликт интересов фиксируется; решения о питании принимаются по прозрачным правилам, а не «усмотрением опекуна»	Открытый вопрос + управленческая рекомендация
6	Нужно ли согласие недееспособного на вариативное меню?	Не требуется: вариативность не ограничивает прав, а расширяет возможность выбора	Системное толкование
7	Как быть с отказом недееспособного от еды?	Не насилие; наблюдение, альтернатива, эскалация врачу (раздел 12)	Норма (ст. 37) + алгоритм
8	Может ли семья диктовать меню?	Учитывается как источник сведений о воле; не заменяет её	Толкование (GC1 как ориентир ²⁹)
9	Кто решает об ограничениях рациона (соль, сахар, порции)?	Только врач, поимённо, с целью и сроком пересмотра	Системное толкование + международная практика ⁴¹
10	Куда вписываются пищевые решения юридически?	В ИППСУ (потребности) и локальные акты (порядок)	Норма (442-ФЗ)
11	Проверяет ли кто-то, учитывается ли мнение жителя?	Ежегодное освидетельствование по ст. 43; контроль учредителя; прокуратура по жалобам	Норма (3185-1)
12	Что если житель недееспособен, но его состояние улучшилось?	Вопрос о дееспособности решает суд; до решения — поддержанный выбор по максимуму	Норма + практика

16.4. Конфликт интересов «учреждение = опекун»: честный разбор

Ситуация массовая: значительная часть жителей ПНИ под опекой, и нередко опекун — само учреждение. Структурный конфликт: опекун обязан защищать интересы подопечного и одновременно является организацией, чьи ресурсы и удобство этими интересами ограничиваются. Прямого запрета закон не содержит — и прямого разрешения игнорировать конфликт тоже. Меры, снижающие риск (рекомендация, не норма):

1. Решения о питании — в **прозрачных правилах** (положение о питании, триггеры, правила добавки), одинаковых для всех: усмотрение заменяется процедурой.
2. **Совет жителей и независимый канал обращений** (раздел 34) — внешний глаз на решения «опекуна-учреждения».
3. **Ежегодное освидетельствование по ст. 43** — по назначению: не формальность, а внешняя оценка условий жизни¹¹.
4. Спорные случаи — **учредителю письменно**. Молчаливое усмотрение хуже зафиксированного решения.

16.5. Практическая формула для локального акта

Формулировка для положения о питании (проект): «При организации питания учитываются мнение и предпочтения получателей социальных услуг, в том числе признанных недееспособными, выявленные доступным способом (словом, показом, наблюдением за потреблением, пищевой биографией, сведениями близких). Ограничения рациона вводятся только по назначению врача поимённо с указанием цели и срока пересмотра. Лишение пищи или питья как мера воздействия не допускается». Каждая фраза опирается на разделы 16.2–16.4. Ни одна не выходит за пределы действующего права.

16.6. Что сказать повару в понедельник

Выбор еды не требует дееспособности. Опекун учитывает мнение (ст. 29 ГК, 48-ФЗ). Риски — непрозрачные решения «по усмотрению», конфликт интересов опекуна-учреждения, отсутствие документов. Закрываются локальными актами.

16.7. Разбор трёх коллизий из зала

«**Родственник против опекуна-учреждения**». Родственник настаивает на меню, учреждение — на своём, житель молчит. Иерархия 15.9 ставит биографию и наблюдение выше обеих сторон: спор решает не статус спорящих, а данные о жителе. «**Врач запретил, житель требует**». Назначение врача — рамка, выбор внутри рамки — право; конфликт возвращается врачу с конкретикой, не решается сменой (кейс 2). «**Раньше выбирал, теперь нет**». Снижение способности к выбору — клинический сигнал (депрессия, прогрессирование, седация после смены схемы): врачу сообщают. «Перестал — значит, не хочет» — диагностическая ошибка. Каждая коллизия возвращается к источникам воли и к врачу — никогда к авторитету должности.

16.8. Учреждение = опекун: три антидота в документах

К конфликту 16.4 (по вторичной аналитике, до 74 % жителей ПНИ недееспособны, опекуном нередко выступает само учреждение⁷ — статус данных: вторичная аналитика) три документальных приёма. Первый: приоритет зафиксированных предпочтений над административным удобством — в положение (приложение 29); конфликт становится видимым. Второй: протокол разногласий — причина отклонения предпочтения пишется (санитария, назначение врача, ресурс). Третий: внешний элемент — совет жителей с независимыми представителями, близкими, общественными наблюдателями (раздел 34). Ни один приём конфликт не отменяет; все три делают его проверяемым. Большого локальный уровень не даёт — честная граница раздела.

16.9. Карта двенадцати вопросов: как ею пользоваться

Карта (способность выбрать ≠ дееспособность ≠ диагноз) применяется не к «жителю вообще», а к решению сегодня. Двенадцать вопросов сводятся к трём блокам: **информирован** ли человек о варианте (показали ли, в его ли формате, в его ли время); **понимает** ли последствия в доступной мере (переспрос, не допрос); **может ли сообщить** выбор хоть одним каналом (раздел 15). Ответы ставят жителя в одну из четырёх рабочих категорий на сегодня: выбирает сам / выбирает с поддержкой формата / выбор считается наблюдением / выбор недоступен — действует стандартный вариант с пересмотром. Категория не навсегда: пересмотр при смене состояния, терапии, для группы «недоступен» — не реже раза в квартал. Динамичность отличает поддерживаемое принятие решений от опеки²⁹: опека фиксирует неспособность, поддержка ищет формат, при котором способность проявляется.

16.10. Ограничение дееспособности вследствие психического расстройства: недоиспользованный режим

С 02.03.2015 ГК РФ содержит отдельный режим — ограничение дееспособности гражданина, который «вследствие психического расстройства может понимать значение своих действий или руководить ими лишь при помощи других лиц» (п. 2 ст. 30)⁷⁶. В отличие от полной недееспособности (ст. 29), такой гражданин самостоятельно совершает сделки подпунктов 1 и 4 пункта 2 статьи 26 (мелкие бытовые и распоряжение предоставленными средствами) и остальные — с письменного согласия попечителя (п. 2 ст. 30). Для ПНИ это развилка: значительная часть жителей, признанных недееспособными, по клинической картине подпадает под п. 2 ст. 30, и переход «ст. 29 → п. 2 ст. 30» (по заявлению, через суд и психиатрическую экспертизу — п. 3 ст. 29) расширяет бытовую автономию, включая выбор еды, без ущерба для защиты. Практика узкая: суды осторожны, литература отмечает невостребованность и размытость критериев⁷⁶. Доклад не зовёт к кампании пересмотра — это суд и экспертиза. Вывод: в карте дееспособности жителя (приложение 37) фиксируется не только статус, но и основание (ст. 29 или п. 2 ст. 30): от него зависит объём бытовых решений, которые учреждение обязано уважать и обслуживать.

17. Право Российской Федерации: что разрешено, что требуется, что опасно

Дата актуальности правового раздела: 19–21.08.2026. Раздел действителен на дату семинара 25–27.08.2026. С 01.09.2026 вступает в силу СанПиН 2.3/2.4.4282-26; для переходного периода 01–15.09.2026 проверяющий оценивает август по старым правилам, сентябрь — по новым (подробнее — раздел 18.10 и приложение 39). Обновления правовых норм после 21.08.2026 в этом разделе не отражены; при использовании после указанной даты сверяйтесь с разделом 41 и разделом 44.

17.1. Логика раздела

Три зоны. Зелёная — разрешено или требуется прямо. Жёлтая — нужны документы, согласования или врач. Красная — нарушение независимо от намерений. У каждого элемента — уровень: норма, толкование, рекомендация.

Навигатор (если времени мало). 17.2 — зелёная (5 минут). 17.3 — жёлтая (10 минут). 17.4 — красная (5 минут). 17.5 и 17.10 — серая зона лечебного питания (10 минут, читать обе: две стороны одной конструкции). 17.6 — пищевые карты и 152-ФЗ. 17.7 и 17.9 — КПИ. 17.11 — три вопроса к любому акту (5 минут). 17.12 — указатель модераторского блока 26.08. 17.13 — смежные панели, чтобы не отвечать за чужой зал. 17.14 — ПНИ vs ДСО.

17.2. Зелёная зона: прямые разрешения и требования

- Питание ≥3 раз в день + диетическое по показаниям** — прямая санитарная норма для организаций соцобслуживания. На дату семинара (25–27.08.2026) действует СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 7.1.11–7.1.14; с 01.09.2026 его сменяет СанПиН 2.3/2.4.4282-26 (пост. Главного государственного санитарного врача РФ от 02.06.2026 № 18), п. 56 подп. 11–14: питание проживающих в стационарных организациях соцобслуживания организуется не менее 3 раз в день, в том числе диетическое (лечебное) по медицинским показаниям¹². Ни одна редакция не ограничивает число вариантов блюд — только безопасность и периодичность.

2. **Права получателя и учёт индивидуальных потребностей** — ст. 9 442-ФЗ и ИППСУ (ст. 16)⁷⁵. Пищевые предпочтения и доступный выбор можно включать в ИППСУ; прямого субъективного права на ежедневный выбор блюда из нескольких вариантов закон не устанавливает.
3. **Права проживающих:** гуманное отношение и достоинство — ст. 5 ч. 2 Закона № 3185-1; ст. 37 — перечень прав пациентов психиатрического стационара; ст. 43 распространяет ст. 37 на проживающих в стационарных СОСО¹¹.
4. **Рекомендуемые нормы питания Минтруда (приказ № 520н)** и региональные нормы на их основе — базовая рамка рационов^{32, 14, 15}. Слово ключевое: рекомендуемые; регион их конкретизирует.
5. **Таблицы замены продуктов** в раскладках — действующий механизм эквивалентной замены, легальная основа вариативности^{14, 15}.
6. **Выбор блюд жителями** не запрещён ни одной федеральной нормой; в 2024–2025 гг. реализован публично минимум в четырёх учреждениях трёх регионов^{2, 3, 4, 5, 6}.
7. **Плата за стационарное соцобслуживание** ограничена 75 % среднедушевого дохода (ст. 32 ч. 4 442-ФЗ)^{75, 77} — рамка финансовых моделей раздела 29.

17.3. Жёлтая зона: делать можно — через процедуру

Действие	Процедура	Основание
Ограничение рациона жителя (сахар, соль, порции)	Назначение врача поимённо, цель, срок пересмотра	Толкование + международная практика ⁴¹
Текстурные модификации (протёртое, загущенное)	Назначение врача, маркировка порций	Клиническая необходимость (раздел 10)
Изменение цикла меню	Увязка с региональной раскладкой и таблицами замен	^{14, 15}
Пищевые карты жителей (персональные данные)	Основание обработки, ограничение доступа	152-ФЗ (раздел 17.6)
Отложенные приёмы, ночная доступность	Пункт в положении о питании + санитарный контур хранения	¹²
Совет жителей с полномочиями по меню	Локальный акт о совете	Практика + международные нормы ²⁶
Вариативное меню	Пакет документов (раздел 31) + уведомление учредителя	Рекомендация на практике ^{2, 3}

17.4. Красная зона: нарушения независимо от намерений

1. **Лишение еды или питья как мера воздействия** — прямое нарушение ст. 5 ч. 2 3185-1 (гуманное отношение); ст. 43 распространяет права ст. 37 на проживающих¹¹.
2. **Насилие при кормлении** (принудительное бытовое кормление) недопустимо; искусственное питание — только клиническая процедура по медицинским правилам (раздел 12.4).
3. **Имитация санитарного контроля** (суточные пробы «задним числом») — типовой состав дел по ст. 6.6 КоАП¹³.
4. **Недоброкачественные продукты на столе** — ст. 6.6 КоАП для должностного лица¹³.
5. **Картельные и согласованные закупки** — антимонопольная ответственность вплоть до уголовной (ст. 178 УК; практика ФАС)^{78, 79}.
6. **Отказ в питании «за опоздание»** как системная практика — нарушение доступности питания (п. 7.1.11 СанПиН 3590-20; с 01.09.2026 — п. 56 подп. 11 СанПиН 4282-26)¹².

17.5. «Серая зона» лечебного питания: честная маркировка

Приказы Минздрава о лечебном питании (395н, 1008н, 330н и картотека диет) адресованы **медицинским организациям**; на организации соцобслуживания автоматически не распространяются. Обходная легализация на практике: региональные распоряжения применяют эти приказы к стационарным СОСО (пример — распоряжение Минсоцразвития Московской области 19РВ-32, на которое опирается ДДСОЛ с советом по питанию)²⁵. Если «мостик» в регионе есть — лечебное питание оформляется по медицинской картотеке; если нет — диетические назначения через врача и положение о питании, без прямых ссылок на неадресные приказы. *Уровень: системное толкование + практика; до проверки в конкретном регионе не использовать как готовое решение.*

17.6. Пищевые карты и 152-ФЗ

Пищевая карта/биография содержит персональные данные (сведения о здоровье — специальная категория). К той же категории — журнал стула (раздел 13.10) и список «время еды фиксировано» для инсулина (раздел 13.12). Правовой минимум: основание обработки (исполнение договора соцобслуживания/ИППСУ), круг доступа (пост и врач; кухня видит функциональные ограничения, не диагноз), исключение избыточных данных, сроки хранения. *Уровень: рекомендация по применению 152-ФЗ; форма карты в приложении 3 требует локальной правовой проверки.*

17.7. КПИ: статус и практическое значение

Россия подписала Конвенцию о правах инвалидов в 2008 году и ратифицировала в 2012-м; конвенция действует как международный договор РФ. Статья 28 (достойный уровень жизни, включая достаточное питание) и Замечание общего порядка № 1 к ст. 12 (поддержанное принятие решений) — стандарт, который российские суды и органы берут как ориентир толкования^{80, 29}. *Уровень: международный договор + толковательная практика; в локальных актах ссылаться можно — как на обоснование, не как на обязанность формата «КПИ требует два варианта каши».*

17.8. Что сказать повару в понедельник

Положение о питании и журналы. Главный правовой риск — не внедрение выбора, а отсутствие документов при уже существующей практике (раздел 31). Красная зона — безопасность и насилие, не число блюд.

17.9. КПИ и правовая культура: дальний горизонт

КПИ с акцентом на поддерживаемое принятие решений²⁹ — не источник обязанностей кухни, а вектор: от «за него решат» к «ему помогут решить». Нормы о выборе, предпочтениях и участии будут ужесточаться — австралийский Стандарт 6³⁷ и онтарийские требования²⁶ это показывают. Дом с процедурами выбора встретит завтрашние требования готовым. Дом, ждущий обязательности, будет догонять под сроками — дороже и фиктивнее.

17.10. Серая зона лечебного питания: рабочая конструкция до «моста»

Пока регионального «моста» нет, нельзя ни игнорировать лечебное питание («мы не больница»), ни имитировать больницу («заводим диеты как в стационаре»). Три элемента: назначения по питанию — от лечащего врача (психиатра, терапевта) письменно, любой формат письменности лучше устного; кухня исполняет через текстуры и исключения, не через «номерные диеты» больничной инфраструктуры; учредителю ежегодно уходит предложение о региональном акте по образцу существующих¹⁵. Конструкция называется и документируется как временная — с датой запроса учредителю. Серая зона перестаёт быть безответственностью и становится пробелом региона с назначенным владельцем.

17.11. Как читать норму: три вопроса к любому акту

Директору не нужно становиться юристом. Три вопроса к акту, который «грозит» или «разрешает». **Первый: кому адресован?** Приказы Минздрава о лечебном питании — медицинским организациям; на СОСО автоматически не ложатся, стык — через региональный «мост» (раздел 24)¹⁵. **Второй: каков статус требования?** Рекомендованные нормы Минтруда (приказ 520н³²) — ориентир, пока регион не сделал их императивными; СанПиН¹² обязательны всегда. **Третий: что доказывает бумага?** Право без процедуры («уважать достоинство») исполняется журналом, картой, протоколом. Две ошибки зала: «нам всё запрещено» (часто по акту не к вам) и «нам всё можно» (по акту рекомендательному, который у вас давно императивен). Зелёная, жёлтая и красная зоны — ответы на три вопроса, приложенные к вариативному питанию.

17.12. Указатель модератору: дискуссия 26.08

Шесть вопросов дискуссии 26.08 («Организация питания: опыт реализации проектов», 14:00–15:30, площадка № 2 — ДСО «Тесовый берег»; модераторы: Е. В. Чистяков, дир. ДСО «Серафимовский»; Т. А. Нурбаев, дир. ДСО «Тесовый берег»):

1. Кто выбирает форму питания — проживающий социального дома или его руководитель?
2. Как формировать меню в условиях жёстких нормативно-правовых и финансовых ограничений?
3. Должно ли быть питание в социальных домах «лечебным»?
4. Как совместить понятия «лечебное питание» и «вариативное меню», не ограничивая право проживающего на выбор?
5. Как соблюсти баланс между выбором недееспособного проживающего «что ему есть» и имеющимися у него медицинскими рекомендациями?
6. Как совместить качество продуктов питания и нормирование цен на них при планировании бюджета в условиях рыночной экономики?

Дословные ответы по схеме «правовая рамка / практика / алгоритм / что нельзя делать» для каждого из шести вопросов, сводная матрица и пакет документов на выступление — в отдельном спикерском файле модератора (не входит в раздатку). Действительно по состоянию на 19–21.08.2026 с учётом правок 14–16 к программе семинара.

17.13. Смежные площадки семинара: что пересекается с организацией питания

Питание — не отдельный «кухонный» трек. Вопросы других сессий, не закрытые здесь, вернутся 26.08: «а вчера нам говорили другое». Ниже — только пересечения, где есть норма или раздел этого доклада. Формулировки — по обновлённой программе; правки № 15–16 вошли в текст. Лекция Федермессер — 25.08, 16.15–17.45; мозговой штурм «Как наладить жизнь в доме?» — 26.08, 16.00–17.45, сразу после сессии о питании.

17.13.1. 25.08, 12.00–13.30. «ПРАВО БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»

Пересечения: вопрос 1 (выбор vs гарантированная безопасность, в т. ч. отказ от жизненно важных процедур) и вопрос 3 (проживающий регулярно выбирает то, что ухудшает состояние, **включая еду**).

Ответ на вопросе питания, без отмены автономии. Отказ от блюда ≠ отказ от еды: эквивалент внутри нормы и, при назначении, внутри диеты (разделы 12, 17.12 вопросы 1 и 5). Отказ от воды или еды более 24 часов — клинический контур комиссии, не «он сам выбрал, мы ни при чём» (вопрос 10 той же сессии — перекладывание ответственности). «Уважение» ≠ «дать вредное без фиксации»: диабетический стол без назначения — ограничение без основания; снятие диеты по просьбе при действующем назначении документируется, не прячется (17.12 вопросы 3–5). Безопасность — СанПиН, назначения, журналы, не отмена выбора.

17.13.2. 25.08, 14.30–16.00. «ПРАВО НА ВЫБОР: ЕСТЬ ИЛИ НЕТ?»

Чистяков Е. В. — **эксперт этой панели** (модератор Георгиев К. А.). Вопросы — внедрение, страх коллектива, «проигравшие». Для питания это **перевод** 17.12 на язык управления, не второй доклад:

- «Есть ли выбор, если решение принято?» — директор вводит пару на линии; житель выбирает внутри рамки («шеф решает, что готовить; житель решает, что взять»).
- Риск, который называют первым (проверка, СанПиН, «не по меню»), не подтверждён делами о вариативности. Публичные дела КоАП 6.6 — качество и достаточность, не второе блюдо (разделы 17, 18).
- Кто мог «проиграть»: смена на раздаче (труд), поставщик (если ТЗ ужесточили), привычка кухни к одной раскладке. Кто выиграл: житель с журналом выбора. Это ответ на вопрос 6 панели.

17.13.3. 25.08, 12.00–13.30. «ПРАВО БЫТЬ НЕДЕЕСПОСОБНЫМ»

Вопросы 1–4: интересы подопечного, кто их выявляет, алгоритмы. На столе — вопрос 5 дискуссии 26.08. Повседневное предпочтение обычно не сделка и не медицинское вмешательство (ст. 29 ГК, ст. 11 3185-1 применяется к диете, не к «котлета или рыба»). Иерархия источников воли — раздел 16.4. Опекун содействует, не подменяет. Назначение диеты — извещение опеки не позднее следующего дня (ч. 3 ст. 11 3185-1).

17.13.4. 26.08, 16.00–17.45. «КАК НАЛАДИТЬ ЖИЗНЬ В ДОМЕ?» (МОЗГОВОЙ ШТУРМ)

После сессии о питании: перерыв 15.30–16.00, тот же дом. Ночной интервал и индивидуальный режим — передача, не новая тема.

Цель: режим дня из индивидуальных потребностей, не из удобства смены. Для кухни — ночной интервал и часы приёмов (раздел 7, слайд дека о ночном голоде). Вариативное меню без сдвига ужина «всем удобно в 17:30» оставляет 14–15 часов без еды. Выбор блюда голод не лечит. Связка: индивидуальный режим + пара на линии + второй ужин по СанПиН, если интервал не проходит.

17.13.5. 25.08, 14.30–16.00. «ЧЕЛОВЕК ИЛИ ФУНКЦИЯ»

Делать за человека vs помогать сделать самому. Кто кладёт «как всегда», превращает жителя в функцию ration. Кто держит два варианта и ждёт жеста — сопровождение. Еда как навык сопровождаемого проживания — раздел 8.8.

17.13.6. 26.08, 11.30–13.00. «ПРАВО НА ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ»

Вопрос 2: может ли быть частная жизнь у недееспособных. Ежедневный выбор «что есть» — одна из немногих регулярных зон автономии. Журнал выбора и пищевая биография фиксируют частное предпочтение. «Нарушение есть во всех домах» (вопрос 7 программы) на кухне: общая раскладка без учёта отказа, еда в палате без согласия, камера на раздаче без рамки 152-ФЗ (раздел 42.3).

17.13.7. 25.08, 16.15–17.45. ИНТЕРАКТИВНАЯ ЛЕКЦИЯ А. К. ФЕДЕРМЕССЕР «ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ — КАК ОБЕСПЕЧИТЬ СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВА НА ДОСТОИНСТВО»

Тот же день, что «Право на выбор» (14.30–16.00, Чистяков — эксперт): после пятнадцатиминутного перерыва — достоинство и «не причинять добро». На следующий день это должно лежать на тарелке. *(В промежуточной свёрке слот ошибочно оставили на 26.08 16.15–17.45: в обновлённой программе на это время — мозговой шторм 17.13.4.)*

Акцент программы: уважать выбор, «не причинять добро». Навязанный «полезный» стол без назначения — причинение добра. Comfort feeding / паллиатив — раздел 12.11; Wunschkost — раздел 12.6.

Параллельно нашей сессии 26.08, 14.00–15.30 — «Право на достойный уход» (Олескина): предсмертный период. Если модератора питания там не будет, ответ всё равно в 17.12 вопрос 5, сценарий В, и в 12.11.

17.13.8. ЧЕГО НЕ ПЕРЕНОСИТЬ В ДОКЛАД О ПИТАНИИ

Трудоустройство недееспособных, контент от жителей, учебное проживание, киносессии — косвенные пересечения. Не раздуваем. «Еда как занятость» — раздел 8.8, коротко.

Источники к 17.13: обновлённая программа семинара 25–27.08.2026; правки к программе (позиции 14–16, вошли в текст); разделы 7, 8, 12, 12.11, 16, 17.12, 18, 42 настоящего доклада; Конституция ст. 21, 41; 3185-1 ст. 11; ГК ст. 29.

17.14. ПНИ и ДСО: различия в правовом статусе, которые важны для темы питания

В зале 26.08 будут оба типа учреждений; правовые режимы по теме питания **не совпадают**. Различие в регуляторике — первое, что проверяют на старте пилота. Таблица — рабочая памятка директора перед запуском вариативности.

Параметр	ПНИ (психоневрологический интернат)	ДСО (дом социального обслуживания), в т. ч. для пожилых и инвалидов
Тип жителей (как правило)	Лица с психическими расстройствами, преимущественно трудоспособного возраста, длительное пребывание	Лица пожилого возраста и инвалиды (старше 18 лет), в т. ч. с психическими расстройствами, часто — паллиативный профиль
Применимость ст. 37/43 3185-1	Прямая (ст. 43 распространяет права пациентов психиатрических стационаров на ПНИ безусловно)	Косвенная через общее распространение ст. 37 на лиц с психическими расстройствами в стационарных учреждениях соцобслуживания; для жителей без психиатрического диагноза — только общие нормы 442-ФЗ
Региональный норматив (пример СПб)	Постановление 1284 (отдельно нормы для ПНИ и для ДСО) — нормы по ПНИ обычно калорийнее и больше белка	Постановление 1284 (отдельно нормы для ДСО) — калорийность может быть ниже, акцент на лёгкую усвояемость и текстуры
Диетические столы	Чаще: ОВД, ЩД, ВБД, реже НБД; значительная доля жителей с назначенной диетой	Чаще: ОВД, щадящие, протёртые; выше доля дисфагии и потребности в IDDSI-текстурах
Вариативность: публично подтверждённая ступень	М1–М2 (Болотнинский, Успенский, Иркутск). М3 — при площади и санитарном контуре, не «типовая»	Старт чаще М1; М2–М3 упираются в текстуры
Учёт невербального выбора	Нужен там, где выбор не выражен словом. Не путать с ~¼ недееспособных (раздел 16): недееспособность ≠ молчание	Нужен при дисфагии, деменции, отсутствии речи
Совет жителей (раздел 34)	Работает, но суррогатно: недееспособные через опекунов; совещательный статус	Работает лучше, особенно в учреждениях для пожилых без тяжёлой психиатрии
Региональные акты-«мостики» к приказам Минздрава о лечебном питании	Встречаются реже; чаще работает «конструкция до моста» (раздел 17.10)	Встречаются чаще; пример ДДСОЛ — распоряжение Минсоцразвития МО 19РВ-32 (раздел 17.5)
Типовая проверочная претензия по 6.6 КоАП	Качество/достаточность питания; соблюдение санитарного контура	Качество/достаточность + текстуры (особенно для жителей с дисфагией)
Цена тарифа (ориентир, 2025)	Алтай 422 руб./день — ПНИ и ДСО единый тариф; СПб — 1366-р, разбивка по типам	Те же 422 руб./день; СПб — отдельные позиции в 1366-р

Что из этого следует для вариативности. Стартовый пилот (раздел 35) устроен одинаково, но точка пилота в ДСО чаще требует проработки текстур (раздел 10), в ПНИ — невербального выбора (раздел 15). Документальный пакет (раздел 31) один; в ДСО чаще согласование текстур с учредителем, в ПНИ — процедура опеки (раздел 16). Четыре публичных кейса Новосибирской и Иркутской областей (раздел 25) — ПНИ; ДСО «Серафимовский» (СПб) и ДДСОЛ (МО) — ДСО. Опыт есть в обоих типах.

18. Санитария и пищевая безопасность при вариативности

18.1. Главный тезис: СанПиН — про безопасность, а не про однообразие

Санитарные правила для организаций социального обслуживания на дату семинара — СанПиН 2.3/2.4.3590-20: не менее трёх приёмов пищи в день, диетическое питание по показаниям, контроль на всех этапах — приёмка сырья, суточные пробы готовой продукции, бракераж, температурный режим, питьевой режим¹². С 01.09.2026 3590-20 утрачивает силу; действует СанПиН 2.3/2.4.4282-26 (пост. № 18 от 02.06.2026). Каркас тот же: питание не менее 3 раз в день, в том числе диетическое (лечебное) по медицинским показаниям; суточные пробы — от каждой партии блюда (п. 56 подп. 11–14)¹². Ни одна редакция не ограничивает число вариантов блюда. Вариативность входит в санитарный контур целиком: в этом сила (каждый вариант защищён как мономеню) и уязвимость (каждый вариант должен контур пройти). После 1 сентября локальные акты и чек-листы пищеблока перепривязывают к пунктам 4282-26, модель выбора не меняя.

18.2. Санитарный контур при двух вариантах

Что меняется при переходе от одного варианта к двум:

Пробы. Суточная проба — с каждого блюда, то есть с обоих вариантов. Трудозатраты: вторая пробная тарелка и вторая строка журнала. Ошибка: проба «с основного» при раздаче двух — для проверяющего это отсутствие пробы второго блюда.

Температура. На линии и на последнем столе; при двух гастрೋмкостях — на обеих. Меньший объём остывает быстрее: меньшие гастрೋмкости и пополнение, не «вариант Б комнатной температуры».

Маркировка. Чтобы раздающий не перепутал: цветные маркеры, наклейки, порядок на линии. При текстурных модификациях маркировка — клинический элемент (раздел 10): перепутанная протёртая и обычная порция — риск аспирации.

Раздача и поток. Два варианта удлинляют выдачу на 5–10 секунд на человека; для маломобильных порядок подачи прописывается отдельно (выбор заранее по журналу заказа — раздел 21).

Хранение остатков. Правила хранения и запрет повторного использования — на оба варианта одинаково¹²; журнал замен фиксирует, что ушло в переработку по правилам, а что — в списание.

18.3. Типовые нарушения и цена

Надзор по социальным учреждениям бьёт в один набор: отсутствие или имитация суточных проб, недоброкачественные продукты, нарушение температурных режимов, отсутствие бракеража¹³. Ответственность по ст. 6.6 КоАП для должностного лица — штраф (в разобранных делах — 5 тыс. руб.¹³; сумма мала, само дело — проверка, представление прокуратуры, репутационный след. Кейс Кашина (СПЦ, 2022): просроченные продукты и отсутствие проб — директор привлечён по 6.6¹³. *Маркировка: дела касаются учреждений соцобслуживания иных типов; для ПНИ это ограниченная аналогия с прямой переносимостью состава нарушений.*

18.4. Буфет, передачи и «серая еда»

Три канала вне общего меню — и все три требуют правил.

Буфет/перекусы. Круглосуточная доступность перекусов — международная норма^{37, 33}. В российском контуре: ассортиментный перечень буфета утверждён (без энергетиков, с учётом раздела 11), продукты проходят тот же контур приёмки, сроки годности контролируются.

Передачи от семьи. Радость и риски: скоропорт, тираминовые продукты для жителей на ИМАО, крепкий кофе для клозапиновой группы, грейпфруты. Не запрет, а регламент: перечень приветствуемых и недопустимых (приложение 32), осмотр дежурным, информирование семей при поступлении и ежегодно.

«Своя» еда жителей. Запасы в тумбочках («хомячение», раздел 9) — сроки годности и гигиена. Решение: легальные зоны хранения перекусов и регулярная замена, не конфискации.

18.5. Ответственный за санитарный контур

При любой вариативности ответственный один: руководитель учреждения, делегирующий контроль приказом (завхоз/шеф/диетсестра — по штату). Делегирование исполнения не снимает ответственности за работающий контроль: «распределил функции» и «контролирует фактически» — центральное различие раздела 33. Минимум: еженедельный обход пищеблока руководителем или заместителем по чек-листу (приложение 19) с записью. Десять минут превращают «формально распределено» в «фактически контролируется».

18.6. Что сказать повару в понедельник

Второй вариант проходит тот же контур: пробы, температуры, маркировка, журналы. Если контур имитируется, вариативность удвоит имитацию. Сначала контур (модель М0), потом выбор.

18.7. Суточная проба при вариативности: частые ошибки

К пробам 18.2 три ошибки вариативной линии: «средняя по обеду» (не доказывает ни один вариант); только вариант А (Б беззащитен при инциденте); без маркировки варианта (через сутки не доказать, что в банке). Правило: каждый вариант каждой позиции — своя промаркированная проба в тех же журналах. Трудозатрата — минуты; доказательная цена — вся линия.

18.8. Буфет и передачи: два хронических очага

Буфет и комната передач — ежедневный стык санитарии и прав. Буфет: допустимые категории (напитки, хлеб, упакованное, фрукты с мытьём), режим пополнения, ответственный — письменно; «под присмотром» без регламента закрывается первой проверкой. Передачи: перечень запрещённого (скоропорт, открытые домашние заготовки, алкоголь и энергетики — также по лекарственной таблице¹⁸), регистрация, хранение с маркировкой. Нет регламента — две крайности: полный запрет (нарушение прав, подполье) и бесконтролье (отравления и взаимодействия). Регламент пишут как форму разрешения, не как форму запрета.

18.9. Вторая гастрೋмкость: санитарный паспорт новой позиции

Второй вариант на линии проверяется пятью пунктами, которые санврач спросит первыми. Отвечать — до старта, одной страницей. **Поточность:** новая позиция в том же потоке (раздача → столы → мойка), пересечений «сырого» и «готового» не создаёт. **Температура:** горячие — в мармите или на раздаче с контролем; вторая гастрೋмкость либо

имеет свой мармит, либо выдаётся первой по времени — решение фиксируется. **Маркировка:** бирка на каждой вариативной ёмкости (наименование, «вариант А/Б»); безымянные кастрюли — классическое замечание. **Суточная проба:** от каждого варианта, не «от обеда вообще» — иначе проба не доказывает безопасность Б. **Журналы:** температура и пробы в тех же санитарных журналах, без отдельной «вариативной» бухгалтерии. Страница-паспорт подписывается завпроизводством и идёт к приказу о пилоте. Первый вопрос проверяющего «как вы это организовали» отвечает документ, не экскурсия.

18.10. Переходный месяц: сентябрь 2026

Семинар — последняя неделя старых правил; первый месяц новых — самый нервный. Постановление № 18 не даёт поэтапного перехода или отсрочки: с 01.09.2026 все требования СанПиН 2.3/2.4.4282-26 применяются в полном объёме¹². **Документы задним числом не переписываются:** журналы до 31.08 по формам 3590-20 законны такими, какими заполнены; с 01.09 ведутся по новым формам (приложения 4 и 5 — бракераж¹²). Сентябрьская проверка смотрит сентябрь по новым правилам и август по старым; «переоформить» августовские журналы под новые формы хуже, чем их возраст. **Программа производственного контроля актуализируется к 01.09** (инструкции, графики, формы журналов) — готовность, не «потом»¹². Если внедрена ХАССП, её документы перепривязываются вместе с ППК; доклад не утверждает, что ХАССП обязателен для каждой СОСО сверх производственного контроля. Чек-лист перепривязки — приложение 39. Модель питания (выбор, пары, замены) не меняется: обе редакции её не ограничивают. Переходный месяц — крайний срок, не передышка. Что не перепривязано к 1 сентября, с 2 сентября — уязвимость.

18.11. Питание при карантине и ОРИ: выбор не отменяется

Вспышка ОРИ или карантин отделения — типовой кризис ПНИ; питание ломается первым: столовая закрыта, персонал перераспределён, доставки ограничены. Рамка есть: при COVID-19 Минтруд выпускал методические рекомендации по работе стационарных СОСО (совместно с санитарной логикой Роспотребнадзора) — усиленный питьевой режим, раздельная посуда, дезинфекционный контур при раздаче в жилые комнаты⁸¹; базовые рекомендации Минтруда по питанию требуют лечебно-профилактических продуктов, профилактики витаминной недостаточности и санитарно-эпидемиологической безопасности⁸². Принципы доклада в карантин переносятся: **выбор не отменяется — меняется форма.** В комнате — два варианта на подносе, не вторая линия в коридоре: житель видит обе порции (или картинки на двери), стандартный вариант всегда есть, журнал замен ведётся усиленно — снимает риск «в спешке забыли». Температура горячего — на последней выдаче в палате: путь «мармит → коридор → комната» ломает п. 50, если его не мерить¹². Питьевой режим при ОРИ усиливается (тёплое питьё по графику — прил. 40), витаминизация — по назначению врача. «План Б» (приложение 45: холодный буфет, запас посуды, график по отделениям, кто кормит, если не вышла кухня или не приехал аутсорсер) окупается в первый день закрытия столовой. Нагрузка на раздачу растёт кратно — это видно в графике до вспышки, не в 8 утра. Тот же поднос — повседневный маршрут постельных и маломобильных: если выбор живёт только в столовой, одиннадцать процентов жителей в него не входят (раздел 20.11).

19. Два варианта блюда: технология без второй кухни

БЛОК 1.5. МЕНЮ, РАЗДАЧА, ЗАМЕР: ПАРЫ ЭКВИВАЛЕНТОВ, РАЗДАЧА, ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ, АУДИТ (19–22)

19.1. Идея в одном абзаце

Модели М1–М2 (раздел 8) не просят вторую кухню. Они просят второй вариант **ключевого блюда** в том же потоке: каши А и Б — в двух котлах сразу, вторые А и Б — из одной мясной заготовки двумя способами. Так уже варят в России: Болотнинский ПНИ — завтрак и обед несколько раз в неделю²; Успенский ПНИ — два вторых, два салата, два напитка каждый день³; Иркутская модель — два первых, два вторых, гарниры⁶.

19.2. Пары эквивалентов

Вариант Б не берут «с полки». Три фильтра: та же норма белка и круп по таблице замен^{14, 15}; тот же поток — печь, котёл, доска; спрос, уже видный по прошлым неделям. Рабочие пары:

- **Крупы:** гречка / рис / пшено / овсянка — взаимозаменяемы по таблицам.
- **Вторые:** котлета / тефтели; тушёное мясо / печёночный соус; рыба запечённая / рыбные биточки — одна заготовка, две формы.
- **Салаты:** свекольный / морковный; капустный / винегрет.
- **Напитки:** чай / какао / кофейный напиток, как в Болотнино². Какао и кофейные напитки входят в кофеиновую строку пищевой карты — правило клозапина, раздел 11.
- **Первые:** борщ / щи; суп крупяной / суп овощной — если готовы держать два котла.

Чего в паре быть не должно: «настоящее / что осталось». Это ломает равноценность (раздел 8.3) и за неделю убивает доверие к выбору.

19.3. Точки выбора: с чего начинать

Практика начинается с завтрака и обеда² — и это верно по кухне: у каш и вторых есть естественные пары, варятся в одном потоке. Завтрак спокойнее: меньше позиций, персонал учится без давки. Сначала одна позиция — каша или второе. Потом вторая. Потом салаты и напитки. Конечная картина первого года у Успенского: два вторых, два салата, два напитка ежедневно³.

19.4. Объёмы: журнал заказа

Самый частый сбой — «вариант Б закончился». Механика живёт в тетради.

1. **Заказ накануне.** Вчерашний выбор (журнал, приложение 7) задаёт сегодняшнюю варку.
2. **Стартовая пропорция.** Пока статистики нет — 50/50 с резервом. Через 2–3 месяца предпочтения стабилизируются^{3,4}.
3. **Пересчёт раз в две недели.** Доля выбравших Б правит закупку. Остатки вариантов пишут отдельно.
4. **Индикатор сбоя.** Доля тех, кто выбрал Б и не получил Б, стремится к нулю. Если растёт — виноваты объёмы, не «непредсказуемые жители».

Для тех, кто выбирает невербально (раздел 15), заказ собирают по пищевым картам и вчерашнему показу. Та же тетрадь, другой источник.

19.5. Кто это делает: роли

Подтверждённая схема: **диетсестра формирует перечень для выбора**². Вариативность сидит внутри норм, не сбоку. Диетсестра — или завхоз, где её нет — пары и раскладка. Повар — два варианта в одном потоке. Раздающие и сиделки — предложение и журнал. Старшая смена — контроль «вариант Б существует» (чек-лист, приложение 24). Руководитель — положение о питании и ежемесячная статистика.

19.6. Сколько это стоит: честная рамка

Вариативность не «бесплатна». Честная структура (раздел 29): сырьё при парных эквивалентах не растёт — идёт перераспределение внутри строки. Растут секунды на линии (5–10 на человека) и канцелярия: две тетради. Единоновременно могут понадобиться вторые гастрорёмкости и маркировка. Иллюстрация: отделение на 30 человек, второй вариант каши — +3–4 кг крупы в сутки при том же суммарном расходе. Перераспределение, не добавка. *Расчёт иллюстративный: замер обязателен до выводов (приложение 25).* Два варианта — вторая гастрорёмкость и тетрадь, не вторая кухня. Поэтому подтверждённые кейсы стартовали в обычных домах без специальных бюджетов^{2,3,4}. Возражение «нет денег» — раздел 37.

19.8. Журнал замен: недооценённый документ

Этот журнал держат «вторым» — зря. Он один доказывает: отказ обернулся альтернативой, а не голодом. Американская норма об обязательной альтернативе при отказе³⁸ по сути описывает эту тетрадь. Писать в день события: вечерние «по памяти» превращают журнал в художественный текст. Фиксируют не только «чем заменили», но и «принял ли». Серия замен одного блюда у разных жителей — сигнал кухне о блюде, не о жителях. Раз в месяц журнал замен читают вместе с журналом срывов: где система отказывает жителю — срывы; где житель — системе — замены. Это разные ремонты.

19.9. Что не является парой

Три антипримера. «Второй вариант — без всего»: отказ от компонента не есть выбор блюда. «Второй есть, но его надо просить за неделю у заведующей»: выбор с барьером — декорация. «Второй — то же самое, но холодное или вчерашнее»: санитарно и этически недопустимо. Все три встречаются чаще честного «у нас один вариант». Все три ловит проверка реальности выбора (приложение 24), вопрос № 3.

19.10. Пары эквивалентов: строительный набор на месяц

Эквивалентность — по основному нутриенту позиции, не по полному составу. Набор на месяц закрывают пары 19.2 плюс белковая линейка котлета мясная / рыбная / курица / биточек (фарш против куска — уже сервис для тех, кому трудно жевать) и напитки компот / морс / чай. Два правила сверх списка. Пара различима: гречка с котлетой и гречка с подливой — одно блюдо с двумя именами. Оба элемента одинаково «ранговые»: рыба и «остатки вчерашнего» — сортировка жителей по сортам. Ранговость жители считают сразу. Подтверждённая практика — две позиции второго, два салата, два напитка⁶ — укладывается в этот набор без экзотики.

20. Точка раздачи: дизайн линии, очередь и помощь

20.1. Почему линия важнее меню

Вариативность живёт или умирает в трёх метрах линии. Здесь сходятся очередь, выбор, помощь кормимым, температура и «почему ему больше». Меню может быть идеальным. Если линия заточена под скорость, выбор станет давлением, а помощь — ожиданием холодной тарелки. Четыре элемента: поток, подача помощи, видимость порций, атмосфера.

20.2. Поток: как не создать пробку

Два варианта добавляют 5–10 секунд на человека. На отделении в 30 человек это 3–5 минут. Что работает.

Предварительный заказ. Выбор фиксируют накануне (журнал заказа). На линии — выдача по списку, решение ещё можно сменить. Время почти не растёт. Российские внедрения идут так^{2,3}.

Визуальное меню. Фотографии или образцы двух вариантов до линии снимают паузу «что там?» и помогают невербальному выбору (раздел 15).

Разнесение потоков. Самостоятельные — на линию. Маломобильные получают выбор в жилой зоне по журналу. Кормимые — за столами, еда приходит к ним. Три потока в одной очереди — конструктивная ошибка большинства столовых.

Две точки выдачи. Хлеб и единое первое — отдельно от позиций с выбором. Выбор не тормозит всех.

20.3. подача помощи: еда — под готовые руки

Международный ориентир, не российское требование: один работник — не больше двух полностью кормимых; еду не ставят, пока помощь недоступна²⁶. Тарелка перед человеком, который не может есть сам, остывает и унижает. Спешка — риск аспирации (раздел 10).

У нас нормы помощи не закреплены. На смене часто далеко от 1:2 — кейс раздела 5: четыре сиделки на двенадцать кормимых. Без новых штатов:

1. **Все руки на час еды.** На основные приёмы к столу выходит вся смена. Это приказ, не добрая воля.
2. **Рассадка по помощи.** Кормимые — по двое у каждого помощника. Подают по готовности рук, не по очереди тарелок.
3. **Волонтёры и соцработники дневных отделений** в часы еды — где возможно.
4. **Честный расчёт дефицита.** Если 1:2 недостижимо, число фиксируют и выносят учредителю письменно (раздел 38). Молчаливый дефицит — риск директора. Зафиксированный — предмет решения учредителя.

20.4. Видимость порций: «почему ему больше»

Выбор делает раздачу прозрачной — и впервые видимое неравенство порций становится конфликтом. Типовой сбой внедрения. Три ответа: **порционные ложки** — мерка на виду; **нормы граммов** у линии («котлета — 75 г, гарнир — 200 г»); **объявленные правила добавки** («после раздачи всем — добавка из остатка»). Конфликт рождает не выбор, а неравенство. Прозрачность его лечит.

20.5. Атмосфера: раздача как сервис, а не как раздача

Немецкий стандарт требует от кухни выходить к жителям и дегустировать³¹. Финский — персонал за общим столом³⁵. Австралийский: «я выбираю, что, когда, где и как я ем»³⁷. Раздача — сервис, не технологическая операция. Минимум без затрат: раздающий называет варианты вслух («гречка или рис?»), не молча черпает; жителю дают 3–5 секунд без давления очереди — это даёт предзаказ; жалобу принимают как данные и кладут в журнал.

20.6. Температура и время на еду

Два замера — один раз, потом ежеквартально (раздел 22). Температура на первом и последнем столе: падение больше 10–15 °С — перестраивать поток. Время на еду у самого медленного из группы помощи: меньше 15 минут — торопят, риск аспирации, раздел 10. Оба замера бесплатны. Оба превращают «у нас всё нормально» в числа.

Линия проверяет вариативность каждый день. Элементы 20.2–20.4 плюс два ежеквартальных замера и маршрут для тех, кто на линию не выходит (раздел 20.11), не требуют денег. Здесь жители впервые чувствуют разницу между «накормить» и «обслужить».

20.8. Стол для группы помощи: микроустройство

Устройство стола решает половину задачи кормления. Помогающий садится между двумя жителями, не напротив одного. Жителей с дисфагическим риском не сажают вместе — каждый требует полного внимания в момент глотка. Посуда: глубокие тарелки с бортиком, нескользкие подставки, ложки удобного захвата. Адаптивная посуда

возвращает частичную самостоятельность; каждый самостоятельный житель — минуты помощи другому. Порции среднего размера с добавкой: большая порция деморализует едока и торопит помогающего. Самый частый дефект — помогающий обсуждает свои дела через голову едока. Самый дешёвый ремонт: «с едоком говорят с едоком».

20.9. Атмосфера: бесплатные элементы, которые зал замечает первыми

Программы среды Pioneer, Eden, Green House^{83, 84, 40} единодушны: обед читают по атмосфере раньше, чем по меню. Нулевая стоимость: скатерти и салфетки вместо голого пластика; еда на столах до рассадки; персонал не стоит полукругом «над» едящими; без бряцания тележек в часы еды; освещение рабочее, не казённо-верхнее. Вместе это «столовая против раздаточной». Проверка: фотография вашего зала в часы обеда рядом с домашней кухней. Разница на снимке — программа на квартал.

20.10. Поток: инженерия очереди за один обед

Очередь с выбором — задача потока, не терпения. Пять решений, от дешёвого к дорогому, сверх 20.2: **предзаказ; визуальное меню до линии** (очередь делает пауза «что брать», не сам выбор); **разведение точек** — салаты и напитки на отдельный столик; **очерёдность отделений** — группы помощи первыми, порядок в распорядке; **вторая точка выдачи**, если позволяет помещение. Замер до и после (время от первого до последнего выданного) даёт минуты. «Выбор добавил 4 минуты к обеду» — факт. «Выбор создал хаос» — обычно диагноз отсутствия этих пяти решений.

20.11. Выбор вне линии: постельные и поднос

11 % жителей — постельные или маломобильные⁷. Если вариативность живёт только на линии, она — привилегия ходячих. Для этой группы выбор — **два варианта на подносе**, не вторая очередь в коридоре. Житель видит обе порции или картинки на двери, показывает; стандартный вариант всегда есть; журнал — на посту. Температура доходит до комнаты по технологическим документам; замер — на последней выдаче, не только на линии. Та же логика, что при карантине: раздел 18.11 и приложение 45. Помощь приходит с едой, не после неё (раздел 20.3). Проверка та же, что для ходячего: вчера был ли реальный второй вариант — на подносе, не в положении.

21. Когда выбор изменился: журнал, пересчёт и «фиктивная вариативность»

21.1. Тема раздела

Выбор жителя — не константа. Он меняется с состоянием, сезоном, сменой препаратов и просто со временем. Система, которая записала предпочтения при поступлении и больше не спрашивала, через год кормит человека, которого больше нет. Раздел — как выбор отслеживают, пересчитывают и отличают от декорации.

21.2. Три регистра данных о выборе

Журнал заказа (оперативный). Вчерашний выбор = сегодняшние объёмы (раздел 19.4). Горизонт — сутки. Владелец — раздача и кухня. Форма — приложение 7. Без этой тетради объёмы варианта Б гадают, и «закончился» становится нормой.

Журнал потребления (клинический). Что съедено: полная порция, половина, не тронута — для группы риска и при внедрении (раздел 9.3). Горизонт — неделя. Владелец — сиделки и врач. Функция — увидеть отказы, дисфагию, «нелюбимые блюда» раньше, чем они станут весом и пневмонией.

Статистика выбора (управленческая). Доли А/Б по позициям и неделям; блюда-лидеры остатков; доля «выбрал Б — не получил Б». Горизонт — месяц. Владелец — диетсестра и руководитель. Функция — править объёмы, цикл и закупки. Опыт Усть-Илимска описывает её как «группировку блюд по популярности»⁴.

21.3. Пересчёт объёмов и цикла

Каждые две недели доли выбора правят варку. Каждый цикл статистика правит сам цикл: блюдо-аутсайдер по остаткам меняют по таблице замен — законно и безболезненно^{14, 15}. Международный ориентир: 21 день (Онтарио) и 4 недели (Германия) против наших типовых 14^{26, 34}. Российский 14-дневный цикл — законный минимум, не эталон. Расширение цикла — самая дешёвая форма разнообразия.

Статистика стабилизируется за 2–3 месяца. Решения — на горизонте месяца, не по эпизоду. «Вчера все взяли гречку» — не основание менять пропорции. «За четыре недели рис берут втрое чаще» — основание.

21.4. Фиктивная вариативность: пять признаков

Чек-лист для себя и для чужих презентаций.

1. «Вариант Б заканчивается через десять минут» — объём занижен. Индикатор: доля нереализованного выбора Б.

2. «Все выбирают А» — Б непривлекателен (смотреть остатки) либо выбор формален: нет показа, нет времени.
3. «Выбор есть в положении, но не на линии» — документ без процедуры. Один визит в часы еды.
4. «Выбирает персонал за жителя» — журнал «по привычке», без вопроса; для невербальных — без показа (раздел 15).
5. «Статистика не влияет ни на что» — данные собирают, объёмы и цикл не меняют.

Каждый признак снимается действием из разделов 19–20. Фиктивность — диагноз, не приговор.

21.5. Обратная связь жителей: от статистики к разговору

Статистика говорит «что», не «почему». Четвёртый канал — прямой разговор: ящик пожеланий, разбор меню на совете жителей (совет резидентов смотрит каждый цикл^{26, 85}), дегустации с голосованием³¹. Минимум — раз в цикл. Формат совета — раздел 34 и приложение 30.

Канал изменит меню — иначе умрёт за полгода. Каждое пожелание: принято или нет, с причиной, на следующем заседании. Немецкий стандарт требует документированной системы жалоб со сроками ответа³⁴ — одна строка в регламенте.

Четыре регистра 21.2 плюс совет — тетради, не софт. Директору есть что положить учредителю и проверяющему: доли, пересчёт, решения совета (раздел 32).

21.7. Данные для совета жителей: как показывать числа

Статистика — материал совета (раздел 34). Три правила подачи. Одна цифра — один вывод: «выбирает 6 из 10 — меню надо показывать ещё четверым». Никаких процентов без абсолютов: «двенадцать человек» понятнее. Каждая цифра кончается вопросом к залу: «почему рыбу выбирают чаще курицы?». Совет, обсуждающий свои данные, — соуправление. Такие протоколы убеждают проверяющего быстрее положений.

21.8. Пять признаков фиктивной вариативности: детализация

Читать в поле, за один визит — сверх списка 21.4. Журнал одним почерком и одной ручкой за неделю. Доля «стандартных» выше 90 % без объяснения. На вопрос «что выбирали вчера» — «не знаю». Второй вариант к вашему приходу «уже закончился» при пустом журнале срывов. Выбор только на завтрак и только по кашам, хотя положение обещает «полную вариативность». Один признак ещё может быть невинным. Два и больше — система фиктивна, разговор о перезапуске, не о «развитии» (кейс 12).

21.9. Пересчёт меню по статистике: рабочий цикл

Четырёхнедельный цикл. Неделя 4 месяца: итоги журнала заказа по позициям — фактическая пропорция, например 62/38 вместо заложенных 50/50. Объёмы следующего цикла — по факту с резервом 10 % на вариант Б. Позиции с устойчивой долей ниже 15 % — кандидаты на замену: не «плохие», не выбираемы этим контингентом. Замену выносят на дегустацию совета (раздел 34). Позиции, которые кончаются до третьего отделения дважды за цикл, — кандидаты на увеличение доли (журнал срывов, приложение 8). Два часа в месяц у диетсестры или завпроизводства. Честный эффект почти всегда: пропорции стабилизируются через 6–8 недель. Эффект новизны кончается. Начинается карта вкусов дома — впервые измеренная.

22. Как проверить реальность питания: аудит и замеры

22.1. Принцип: измеряй факт, а не документ

Пилот, финансы, ответственность дальше в докладе стоят на данных. Дом, который себя не измерил, не докажет эффект, не защитится на проверке и не поймёт, что чинить первым. Инструментарий: экспресс-аудит, семидневный замер, квартальная панель. Измеряют факт — температуру на последнем столе, остаток на тарелке, интервал в часах, — не запись о факте.

22.2. Экспресс-аудит «Стол за один день»

Чек-листы — приложения 18–21. Один случайный будний день. Замеряющий — не профильный: заместитель, бухгалтер, сестра-хозяйка другого отделения. Четыре блока.

До еды. Меню вывешено языком блюд и совпадает с раскладкой. Ночной интервал — вчерашний ужин → сегодняшний завтрак — в часах. Журналы проб ведутся в реальном времени: почерки, время. Лекарственно-пищевая таблица на посту.

Во время еды. Кормимых на одного работника. Тарелки, ждущие рук. Температура на первом и последнем столе. Текстуры — выборочно 3 тарелки группы риска. Время у самого медленного. Объявлена ли добавка. Ест ли персонал с жителями. Остатки — доля и блюда-лидеры. Атмосфера: разговор или звон посуды и команды.

После еды. Журнал отказов читает врач. Срабатывала ли эскалация «3 отказа → врач». Куда ушли остатки. Есть ли вечерний перекус и доходит ли до постельных. Что может съесть житель в 2 часа ночи — спросить дежурную сиделку, не положение.

Документы и люди. Комплект раздела 31: положение, меню, журналы, паспорта, согласование. Когда совет жителей обсуждал меню. Выходил ли повар к жителям за месяц. Может ли кто-то за 5 минут назвать расход на сырьё на жителя в день.

Итог — 24 строки «да / нет / число». Каждая сама становится строкой плана. Большинство находок бесплатны: расписание, порядок подачи, журналы. Меньшинство — организационны: рассадка, смена. Единицы требуют денег.

22.3. Семидневный замер отходов и потребления

Форма — приложение 25. Семь дней, три веса в день: выдано (кг по линии), возвращено с тарелок, остатки кухни. Результат — доля несъеденного по блюдам и дням. База для финансовой модели (раздел 29), корректировки цикла (раздел 21), разговора с учредителем (раздел 38). *Семь дней — короткий ряд; сезонность и «хорошие дни» искажают. Замер повторяют ежеквартально. Выводы — на повторяемости, не на одном замере.*

22.4. Квартальная панель директора

Двенадцать чисел раз в квартал на одном листе (приложение 35).

1. Ночной интервал (часы).
2. Доля несъеденных порций.
3. Блюда-аутсайдеры (топ-3).
4. Кормимых на одного работника (факт).
5. Температурная дельта «линия — последний стол».
6. Соответствие текстур назначенным (выборка).
7. Число отказов и доля с эскалацией в срок.
8. Весовые триггеры — две строки, не одна: (а) набор $\geq 5\%$ за квартал (метаболический риск, раздел 13.8); (б) потеря по MUST / рамка Онтарио (недостаточность питания). Кухня не ставит категорию MUST.
9. Доля жителей с актуальной пищевой картой.
10. Доля выбравших Б, не получивших Б (при вариативности).
11. Сырьевая строка (руб./житель/день).
12. Число жалоб на питание и доля с ответом в срок.

Панель показывает динамику — главный аргумент учредителю; рано сигнализирует о сбоях; дисциплинирует систему: что измеряется — то существует.

22.5. Экспресс-оценка «за 10 минут» для гостя семинара

Минимальная версия «завтра по приезду».

1. Спросить у жителя: «Что ты сегодня выбрал?» Ответ или его отсутствие измеряет выбор точнее документов.
2. Мойка после обеда: остатки — голос всех, включая молчаливых.
3. Ночной интервал по расписанию и по факту. Расхождение — разрыв бумаги и жизни.
4. Спросить у сиделки: «Что ты делаешь, если он отказался от третьего приёма подряд?» Правильный ответ: «фиксирую и сообщаю врачу сегодня».
5. Спросить у завхоза: «Сколько стоит сырьё на жителя в день?» Пауза измеряет финансовую прозрачность.

Последовательность: экспресс-аудит (неделя 1 пилота), семидневный замер (недели 1–2), квартальная панель. Стоимость — время непрофильного сотрудника в квартал и две тетради.

22.7. Аудит чужими глазами: взаимные визиты домов

Формат почти бесплатный между двумя домами — лучше разных типов и регионов, находка через семинар. Обмен аудиторами на день. Аудитор проходит чек-листы приложений 18–21 и пишет только факты. Три эффекта самоаудита нет: видны «невидимые нормы»; аудитор уносит к себе три находки хозяина; появляется внешний факт для учредителя. Правило: сначала договорённость о некарательности. Находки не уходят вверх без согласия принимающей стороны. Иначе формат умрёт после первого визита.

22.8. Кто замеряет: почему не свой

Самоаудит завышает баллы не из лжи, а из адаптации: своя столовая «всегда такая». Замеряющий — не владелец процесса: заместитель по другому контуру, бухгалтер, сестра-хозяйка соседнего отделения, коллега из другого дома. Единственная компетенция — записывать факт, не впечатление. «Вариант Б закончился на втором отделении» — факт. «Кухня не справляется» — впечатление. Чек-листы 18–21 построены под факты.

22.9. Оценка за 10 минут: как пользоваться шкалой

Итог — не «хорошо / плохо», а зона, задающая первый шаг. **Зона А (18–24 из 24):** система работает; задача — удержание: панель, ротация, защита от регресса (раздел 8.5). **Зона Б (12–17):** практика есть, контур дыряв; задача — документы и журналы (раздел 31), линию не трогать. **Зона В (6–11):** элементы есть, системы нет; пилот по разделу 35, не «всё сразу». **Зона Г (0–5):** точка старта; замеры (приложения 25–26) и разговор с учредителем (раздел 38) до изменений на линии. Оценку ставит факт вчерашнего дня: «положение есть» = 0 баллов, если вчера

выбора не было. Повторный аудит тем же человеком через квартал важнее идеальной первой оценки. Динамика балла — главный показатель управляемости темы.

23. Кто участвует: география семинара и система ПНИ-2026

БЛОК 1.6. КОНТЕКСТ: ГЕОГРАФИЯ, НОРМЫ РЕГИОНОВ, РОССИЙСКИЕ ПРАКТИКИ, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ, ИССЛЕДОВАНИЯ (23–27)

23.1. Аудитория по документам

Семинар «Пространство Новых Идей 2.0» собирает в Санкт-Петербурге руководителей стационарных организаций социального обслуживания со всей страны⁸⁶. Очищенный список участников — отдельный файл к докладу: **170 записей из 51 субъекта Российской Федерации**; с учётом четырёх явных дублей — расчётно 166 уникальных организаций. Состав неоднороден: классические ПНИ (Краснодарский край, Ростовская, Нижегородская, Новосибирская области), переименованные «дома социального обслуживания» (Красноярский край, Волгоградская, Вологодская, Тюменская области), центры реабилитации и социализации (Воронежская область), «добрые дома» (Московская, Ульяновская области), геронтологические центры с отделениями ПНО (Владимирская область), детские и смешанные учреждения.

Аудитория говорит на разных организационных диалектах. Пищевая задача одна. Поэтому я обращаюсь к директору стационарной организации, не к «директору ПНИ».

23.2. Система в числах (с оговорками о статусе данных)

По данным за 2024 год, обработанным проектом «Если быть точным» (публикация 09.04.2026). Материал пересказывали СМИ; ТАСС автором исследования не является. «Ведомости» 10.04.2026: психоневрологических интернатов за три года стало на 13 % меньше. Цифры перепроверены по нескольким независимым изданиям^{7, 87}:

- **466 психоневрологических интернатов** в России (три года назад — 536: сокращение на 13 %);
- **139 500 жителей** ПНИ; всего в стационарных организациях соцобслуживания — **более 174 000 человек** (данные Минтруда в пересказе);
- **65 % жителей старше 45 лет** — контингент стареет;
- **74 % признаны недееспособными** — три четверти;
- **11 % — постельные или маломобильные**;
- **средний размер — 289 коек**;
- **41 регион переименовал ПНИ** в «дома социального обслуживания» и подобные имена — это видно по списку участников;
- в сопровождаемом проживании — порядка **7 000 человек** из ПНИ (и 1 800 в программах распределённых квартир).

Статус данных: вторичная аналитика на государственных массивах, не официальная отчётность Минтруда. Первичные ряды в машиночитаемом виде на дату подготовки доклада в открытом доступе не извлечены — зафиксировано в журнале верификации. Цифры — порядковые ориентиры, не точная статистика.

23.3. Что цифры значат для темы доклада

Четыре следствия. Первое: контингент стареет (65 % старше 45 лет) — растут дисфагия, соматика, помощь за столом (разделы 10, 20, 28). Второе: 74 % недееспособных — невербальный выбор (раздел 15) важнее вербального. В вашем доме цифра будет другой; логика та же. Третье: переименования в ДСО — не косметика. Новая вывеска задаёт ожидание «дома», и питание — первое место, где его проверяют. Четвёртое: сопровождаемое проживание растёт — навыки «своего стола» (ступени 3–5 лестницы, раздел 8) становятся реабилитационной задачей с измеримым выходом.

23.4. Кто в зале уже внедрил вариативность

В списке — организации с **подтверждёнными публичными практиками**: Успенский ПНИ (№ 117)³, Усть-Илимский дом социального обслуживания (№ 94)⁴, ДСО «Серафимовский» — наш петербургский дом⁵, Болотнинский ПНИ из того же региона, что участник № 118 (Тогучинский ПНИ)². Практика сидит в зале. Предложение модераторам — раздел 40.

23.5. В зале сидят внедрившие: как использовать это обстоятельство

Три организации представлены лично — Успенский, Усть-Илимск, Серафимовский^{7, 4, 5}. Болотнинский — из того же региона, что Успенский². Вопросы «сколько стоило», «что сказала проверка», «где ломалось» — носителям опыта в зале, не только лектору (панель — раздел 40). Для остальных это сильнее презентации: коллега с таким же штатом, учредителем и СанПиНом уже сделал это.

23.6. Чего в списке нет — и что это значит

В списке нет общественных организаций жителей и семей, нет профсоюзов смен, нет экспертов по питанию. Состав управленческий. Это не упрёк организаторам. Решения будут принимать о людях, которых в зале нет. Первая проверка любого решения семинара — не отчёт учредителю, а столовая: житель и смена. Держать этих двух в поле зрения — задача модерации каждого обсуждения.

23.7. Что список участников говорит о системе

170 записей, 51 субъект, 4 дубля → 166 уникальных организаций — срез отрасли. Рядом сидят классические ПНИ, переименованные ДСО, дома-интернаты общего типа, СРЦ и детские организации. Советы, годные взрослому ПНИ, для детского учреждения требуют отдельной проверки: детский контур в докладе обозначен, но не раскрыт — честная граница. 51 регион — больше половины субъектов РФ; семинарская повестка способна стать отраслевой (раздел 40). Качество данных: 20 записей с пометками о неуверенном распознавании текста и 4 дубля. Даже официальный список федерального семинара требует чистки. Тот же принцип везде в докладе: сначала верификация, потом выводы.

24. Как устроены нормы в регионах

24.1. Двухуровневая система норм питания

Рамка двухуровневая. Федеральный уровень — **рекомендуемые нормы Минтруда** (приказ № 520н): суточные наборы для взрослых и детей³². Региональный — акты субъектов, которые принимают эти нормы как обязательные для подведомственных, конкретизируют и дополняют. Проверенные примеры: постановление Правительства Москвы № 1068-ПП, постановление администрации Псковской области № 206, постановление Правительства Красноярского края № 607-п, постановление Правительства Ленинградской области № 458, постановление Правительства ХМАО № 306-п^{88, 15, 14}.

Для директора действует региональный акт: граммы, раскладка, таблицы замен. Первое действие — найти и перечитать свой региональный акт, не федеральные приказы. Путь — через учредителя.

24.2. Что общего у региональных норм

Проверенные акты держат одну конструкцию.

1. **Набор продуктов в граммах на человека в день** по группам — хлеб, крупы, мясо, рыба, молочные, овощи — прямо или со ссылкой на федеральные рекомендации.
2. **Раскладка блюд** (перспективная картотека) — перечень с выходом в граммах.
3. **Таблицы замены продуктов** — эквиваленты по питательной ценности. Ключевой механизм: легализует вариативность (разделы 8, 19).
4. **Отдельные нормы для категорий** — дети, лица с соматическими заболеваниями.
5. **Периодичность и режим** — число приёмов, интервалы — в связке с СанПиН¹².

Различия — в граммах, категориях и свободе таблиц замен. Систематического сопоставления всех 89 субъектов нет: такого обзора мы не нашли. Обобщения о «российских нормах вообще» делать осторожно.

Приказ Минтруда 520н на федеральном уровне — «рекомендуемые нормы». В Минюсте не регистрировался: рекомендательный акт, не императив. В ряде субъектов региональные акты прямо ссылаются на 520н как на основу для подведомственных — и тогда нормы обязательны в данном регионе независимо от федерального статуса. Проверяя рамку (раздел 24.4, шаг 1), уточняйте не только наличие акта, но и его ссылочный аппарат. (Уточнение 19.08.2026.)

24.3. Региональные модели организации: четыре архетипа

Организации устроены по-разному. Это влияет на питание.

Архетип 1. Классический ПНИ (Краснодарский край, Ростовская, Нижегородская, Новосибирская области): специализированное учреждение для лиц с психическими расстройствами. Питание — профильная функция; диетсестра чаще в штате. Этот архетип дал все три подтверждённые практики вариативности^{2, 3, 4}.

Архетип 2. Дом социального обслуживания (ДСО) (Красноярский край, Волгоградская, Вологодская, Тюменская области и др. — 41 регион переименований⁷): универсальное учреждение, жители с психическими расстройствами живут вместе с другими категориями. Питание — на общих нормах; психиатрическая специфика — в назначениях врача и локальных актах.

Архетип 3. Центры реабилитации и «добрые дома» (Воронежская, Московская, Ульяновская области): питание — элемент восстановления навыков; ближе к моделям М3–М5 (раздел 8).

Архетип 4. Смешанные учреждения с отделениями ПНО (Владимирская область и др.): психоневрологическое отделение внутри геронтологического центра или специального дома-интерната. Питание общего контура с отдельными назначениями для отделения.

Заимствуя опыт, смотрите на архетип источника. Модель классического ПНИ переносится на ДСО с адаптацией, не копируется.

24.4. Пять шагов проверки своей региональной рамки

Алгоритм для директора (форма — в семинарском пакете).

1. Получить у учредителя действующий региональный акт о нормах питания и проверить редакцию: дата, изменения.
2. Сверить фактическую раскладку дома с актом: граммы, категории, таблицы замен.
3. Проверить таблицы замен: какие эквиваленты разрешены — пространство законной вариативности.
4. Найти нормы для особых категорий: где «диетическое питание» вашего контура.
5. Зафиксировать письменно: что решает учреждение, что — учредитель (матрица полномочий, приложение 17).

Таблицы замен — готовое законное пространство выбора, которым почти никто не пользуется по назначению. Без этих пяти шагов пилот строится вслепую.

24.6. Разговор с регионом: как ставить вопрос

Чиновник отвечает на точный вопрос охотнее, чем на «разберитесь с нормами». Постановка: «Просим подтвердить статус приказа Минтруда № 520н в части норм питания для подведомственных организаций: рекомендованный или обязательный; просим указать акт, которым статус установлен». Один вопрос, одна просьба о документе. Такой же шаблон — для меню, «моста» и форм учёта. Четыре письма заменяют год коридорных пересудов.

24.7. Проверка за пять шагов: сценарий недели

День 1 — письмо учредителю с вопросами 1–4 из раздела 38. День 2 — сбор внутри: какое меню висит на кухне, кто утвердил, когда пересматривалось. День 3 — сверка: предписано ≠ фактическое; разницу фиксируют письменно. День 4 — ответ учредителя или фиксация его отсутствия и решение о рамке пилота. День 5 — запись рамки в приказ о пилоте (приложение 28). Неделя без изменения на линии. После неё правовая геометрия кухни известна точнее, чем за предыдущие годы.

24.8. Четыре архетипа региональной регуляции: детализация

Узнавать по одному документу каждого типа. **«Императивное меню»** — приложение к постановлению: двухнедельное меню с граммовками, отступления не предусмотрены. Вариативность начинается с изменения приложения; первый шаг — запрос процедуры (вопрос № 2 учредителю, раздел 38). **«Нормы без меню»**: нутриенты и кратность закреплены, меню — дело организации. Свобода максимальна, ответственность за пары — на организации. **«Типовая раскладка»**: наследие советской раскладки, формально рекомендованной, фактически священной. Лечится письменным вопросом о статусе. **«Мост»**: акт, связывающий СОСО с системой диет (распоряжение 19РВ-32 как образец¹⁵) — самый благоприятный для лечебного питания и самый редкий. Один регион может комбинировать: императивное меню плюс мост. Диагностика — не анекдот «у нас нельзя», а форма из пяти строк: статус норм, меню, мост, формы учёта, закупочная модель. Эту форму семинар собирает по 51 региону (раздел 40) — первый срез вместо фольклора.

25. Российские практики: четыре подтверждённых кейса и одна региональная модель

25.1. Методологическая рамка: что считается подтверждением

Практикой считается только то, о чём организация или регион рассказали публично на официальном ресурсе. Новость подтверждает факт сообщения, не аудит практики. Перечень не полон: российская практика вариативности шире её публичной документации, поиск при подготовке доклада — срез, не перепись. Где деталей нет в источнике, прямо написано «данных нет».

25.2. Кейс 1. Болотнинский ПНИ (Новосибирская область), с 2024 года

Сообщение учреждения от 16.08.2024²: вариативное питание действует **несколько раз в неделю**; на завтрак — выбор чая, какао или кофейного напитка, каши или супа; на обед — салаты, вторые и десерт; **перечень блюд для выбора определяет медсестра диетическая**.

Модель М1 (раздел 8) — точечный выбор на ключевых приёмах и днях. Вариативность внутри норм, ответственная — диетсестра, конфликт «выбор против раскладки» снят. Чего в источнике нет: охват, учёт невербального выбора, статистика, влияние на отходы, судьба после 2024 года. Данных нет — повод для контакта, не для домыслов.

25.3. Кейс 2. Успенский ПНИ (Новосибирская область), с 2024 года

Сообщение от 13.08.2024³: вариативное меню **во всех отделениях**; ежедневно **два вторых, два салата, два напитка**; «страхи персонала не подтвердились», жители «с лёгкостью освоили новую систему»; обновлена посуда, проведены занятия по этикету.

Модель М2 — ежедневный выбор по основным позициям, полный охват. Не М3: шведской линии в источнике нет. Два факта для семинара. Главное сопротивление было внутренним и не материализовалось. Внедрение шло с бытовым апгрейдом и обучением жителей: программа, не приказ. Участник семинара — № 117.

25.4. Кейс 3. Усть-Илимский дом социального обслуживания (Иркутская область), с сентября 2024 года

Сообщение от 27.09.2024⁴: вариативное питание вводится **позатупно**; старт — для жителей, посещающих столовую; предварительно — **опрос предпочтений**; блюда **сгруппированы по популярности**.

Внедрение начали с измерения и сегментации (сначала мобильные), не с приказа. Это логика дорожной карты раздела 35. Участник семинара — № 94.

25.5. Кейс 4. ДСО «Серафимовский» (Санкт-Петербург), 2025 год

Сообщение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 22.07.2025⁵. Я, директор дома Евгений Чистяков, представил на рабочей группе по реформированию ПНИ **первые результаты вариативного меню для части жителей**. Несколько месяцев проживающим предлагали **накануне выбрать рацион следующего дня**. Дом **закупил дополнительное оборудование и добавил сотрудников**. Жители восприняли эксперимент **с энтузиазмом**. Полный переход **крайне затруднителен**: нормы сбалансированности и особенности здоровья; жители склонны выбирать **популярные, но не самые полезные** продукты.

Модель М1 — заказ накануне для части жителей, близко к пилоту раздела 35. Два факта, которых нет в других публичных российских кейсах. Старт **не** был «без новых денег»: оборудование и ставки названы прямо. Учреждение само назвало пределы — нормы, здоровье, популярный нездоровый выбор. Это ценнее победной реляции. *Маркировка: официальная новость учредителя — факт публичного сообщения на дату, не аудит и не оценка устойчивости. Докладчик семинара — директор этого дома.*

Развитие кейса: приказ № 124 от 10.03.2026⁸⁹. Приказ утверждает **правила внутреннего распорядка жителей**. В них — **заказное питание (вариативное меню)**, в том числе для маломобильных: «для маломобильных граждан приём пищи осуществляется в жилых комнатах, оказывается помощь в кормлении (при необходимости)». Из «эксперимента по новости» вариативность стала **нормой внутреннего распорядка** — локальный акт для проверяющих. *Реквизиты — PDF приказа на www.pni9.ru; сайт прекратил работу, домен истёк, проверено 21.08.2026; архив: web.archive.org/web/20260415001233/https://www.pni9.ru/правила-внутреннего-распорядка/. Заказное питание — раздел правил, не отдельный приказ.*

Масштаб и режим (обновление 21.08.2026, архивные копии сайта). Февраль 2026: **1 004 человека** — 949 за счёт бюджета Санкт-Петербурга (625 мужчин, 324 женщины; свободных мест нет) и 55 за счёт средств физических и юридических лиц (28 мужчин, 27 женщин); раздел «Свободные места», архив 07.03.2026. Режим: завтрак 8.00–10.00, обед 13.00–15.00, полдник 16.00–17.00, ужин 18.00–20.00, второй ужин 20.00–21.00; ночной интервал от второго ужина до завтрака — **11–12 часов**. Укладывается в правило «интервал не превышает 14 часов» раздела 4 и в критерий раздела 13.9. Материально-техническое обеспечение (архив 24.01.2026): «6-и разовое питание, наличие диет столов», протёртый стол и дополнительное питание при заболеваниях ЖКТ — факты для раздела 17.12.

25.6. Региональная модель: Иркутская область, с 2025 года

Пресс-релиз (пересказ отраслевым изданием, 14.02.2025)⁶: в стационарных учреждениях области — **ежедневный выбор из двух первых, двух вторых и гарниров**. Если подтвердится первоисточником (сайт минсоцразвития Иркутской области), это первый в России случай **масштабирования вариативности на уровень региона**. *Источник вторичный; сколько учреждений фактически — на дату подготовки доклада не установлено.*

25.7. Опорная практика: ДДСОЛ (Московская область)

ДДСОЛ публикует устройство питания²⁵: зимнее и летнее **14-дневное меню**, 5–6-разовое питание, поточная линия самообслуживания, буфетная зона, **совет по питанию** (распоряжение Минсоцразвития Московской области 19РВ-32 от 13.04.2017 — медицинская рамка, применённая к соцучреждению), **замены по желанию жителей с согласованием с врачом**. Это не «вариативное меню» в нашем строгом смысле, но работающая персонализация внутри нормы — и легальный «мостик» к лечебному питанию (раздел 17.5).

25.8. Сравнительная таблица практик

Учреждение	Модель	Точки выбора	Частота	Охват	Ответственный	Особенности
Болотнинский ПНИ	M1	Завтрак, обед	Неск. раз/нед	Данных нет	Диетсестра	Перечень от медицинской структуры
Успенский ПНИ	M2	Все основные позиции	Ежедневно	Все отделения	Данных нет	Посуда, этикет, работа со страхами
Усть-Илимский ДСО	M1→M2	Старт — столовая	Позтапно	Мобильные жители	Данных нет	Опрос предпочтений, группировка по популярности
Серафимовский ДСО	M1	Рацион на следующий день	Накануне, неск. месяцев	Часть жителей	Данных нет	Оборудование и доп. сотрудники; энтузиазм; полный переход затруднителен (нормы, здоровье)
Иркутская область	M2	2 первых, 2 вторых, гарниры	Ежедневно	Регион	Учредитель	Масштабирование на субъект
ДДСОЛ	персонализация	Замены по желанию	Постоянно	Все жители	Совет по питанию + врач	14-дневное меню, региональный «мостик» к 330н

25.9. Выводы для участников

- Вариативность в России — не эксперимент:** минимум четыре учреждения и один регион — публично, с 2024 года^{2, 3, 4, 5, 6}.
- Три кейса Новосибирской и Иркутской областей начинались без новых денег** — второй вариант внутри существующих норм. **Серафимовский публично назвал оборудование и дополнительные ставки⁵** — универсального «бесплатного старта» нет.
- Три кейса сидят в зале** — Успенский, Усть-Илимский и дом докладчика (раздел 40).
- Документация отстаёт от практики:** учёта, статистики, документов в публичных сообщениях нет. Учреждение, рассказавшее о выборе с цифрами, сдвинет отрасль сильнее методического доклада (раздел 39).

25.10. Чего мы не знаем о практиках — и почему это важно сказать

По каждой из шести практик неизвестно больше, чем известно: экономика сырьевой строки, устойчивость на сегодня, охват неговорящих, вопросы проверок. Новость подтверждает факт сообщения на дату — и только. Поиск локальных актов и повторных публикаций выполнен там, где они нашлись (распоряжение ДДСОЛ²⁵, региональное решение по Иркутску⁶), и честно не выполнен там, где их нет: повторных публикаций по Болотнинскому и Успенскому на момент проверки не обнаружено. По Серафимовскому известны факты новости Комитета⁵ — не штатное расписание, не меню, не панель чисел. «Внедрено публично» ≠ «работает годами». Зал должен слышать обе половины фразы.

25.11. Что объединяет внедривших: четыре общих признака

Сравнение шести практик (Болотнинский², Успенский³, Усть-Илимский⁴, Серафимовский⁵, Иркутская область⁶, ДДСОЛ²⁵) даёт механику, не лозунги. **Точка входа — предпочтения:** опрос предшествует линии (явно — Усть-Илимск⁴). **Скромный старт:** два вторых, два салата, два напитка³ или заказ накануне для части жителей⁵. **Публичность как защита:** рассказанное на официальных сайтах с датами труднее тихо отменить. **Страхи и пределы названы постфактум:** «страхи не подтвердились»³ и «полный переход крайне затруднителен»⁵. Признак, который **не** общий: новосибирские и иркутский кейсы не сообщают о новых ставках; Серафимовский сообщает об оборудовании и сотрудниках. Это не доказывает ни «бесплатности», ни «дороговизны» (раздел 29): порог может быть организационным (модель НСО) или требовать ресурсов (модель СПб). Пилот на одном отделении без новых денег реалистичен. Обещать бесплатный полный переход — нельзя.

Следующий шаг блока «Контекст» — международный опыт (раздел 26): что делают в девяти зарубежных системах, где их регуляторика расходится с российской, и какие нормы там появляются раньше, чем у нас.

26. Международный опыт: проверяемые нормы девяти систем

Раздел 25 дал четыре российских кейса. Здесь — ориентиры и предупреждения из девяти зарубежных систем.

26.1. Правила заимствования

Три правила. Беру только **проверяемые нормы** — числа, процедуры, документы; не «ценности» и не «подходы». К каждой норме — статус дома (закон, руководство, стандарт, доплата) и **граница применимости**: большинство писано для гериатрии, не для психиатрии; перенос на ПНИ — наша адаптация, и она маркируется. Превосходные степени исключены: сравниваем механизмы, не страны.

26.2. Великобритания: психиатрическая специфика

Единственное найденное руководство **именно для психиатрических стационаров** — Британской диетической ассоциации (BDA)^{39, 90}. Берём: гибкий завтрак для седатированных; меню без приборов (finger food) при риске; протокол питания в изоляции (посуда, текстура, фиксация потребления, эскалация); лекарственно-пищевая таблица в меню (раздел 11); self-catering на реабилитации. Базовый стандарт — Regulation 14 регулятора CQC: учёт предпочтений **по времени, месту и количеству еды**, не только по составу; отложенная еда для пропустивших⁴². «Защищённые приёмы пищи» — с оговоркой: систематический обзор признаёт доказательную базу недостаточной^{91, 92}.

26.3. Австралия: еда как самостоятельный стандарт

С 1 ноября 2025 года действует Standard 6 «Food and Nutrition»: питание — отдельный стандарт качества ухода. Формула выбора **«что, когда, где и как я ем»**; перекусы 24/7; меню с участием проживающих; текстуры по IDDSI с достойной подачей и процедурой «осознанного риска»^{37, 47}. Финансовая подпорка — следствие скандала: медиана расходов на сырьё \$8,00 AUD в день (Hugo)⁹³ → надбавка \$10 AUD **в обмен на обязательную ежеквартальную отчётность о расходах на питание**⁹⁴. «Деньги в обмен на прозрачность» — самый переносимый финансовый элемент (раздел 29).

26.4. Онтарио: решётка измеримых норм

Подзаконный акт О. Reg. 246/22 — самая детальная из найденных конструкций²⁶: цикл меню ≥21 день; выбор на всех приёмах; **совет резидентов рассматривает каждый цикл меню и согласует время приёмов**; еда по диете доступна 24 часа; триггеры веса −5 %/−7,5 %/−10 % за 1/3/6 месяцев с автоматической междисциплинарной оценкой; диетолог ≥30 минут на жителя в месяц; **кормление: один работник — не более двух кормимых, еда — только под готовую помощь**. Профессиональные формы добавляют триггеры потребления: ≥25 % порции за 2 из 3 приёмов в течение недели; отказ от трёх приёмов подряд⁵⁹. Почти вся решётка переносима в российский локальный акт без изменения закона (разделы 12, 20, 21).

26.5. США: альтернатива при отказе и ночной интервал

Федеральное правило 42 CFR §483.60³⁸: при отказе от блюда **обязательна альтернатива сходной питательной ценности**; между существенным ужином и завтраком — **не более 14 часов** (16 — при питательном перекусе на ночь). Нарушения фиксируются пронумерованными инспекционными F-тегами (F800–F807 — пищевой блок)⁹⁵: механика пронумерованных пунктов переносима во внутренний аудит (приложения 18–24).

26.6. Скандинавия: 11 часов ночи и совместный стол

Шведское руководство Livsmedelsverket: ночной интервал ≤11 часов с обязательным вечерним перекусом; шесть пищевых событий в день; пищевой совет (matråd) из проживающих^{33, 85}. Замеры Талльберга: норма интервала у 79 % проживающих — индикатор одной строкой расписания⁸⁵. Финляндия: **персонал ест вместе с проживающими** как национальная рекомендация^{35, 96} — бесплатный мониторинг. Ориентир дома — ≤13 ч (внутри 11–14 ч, не отдельная норма); ужин 17:30 → завтрак 8:30 = 15 часов; меняется сдвигом на час и вечерним перекусом без сметы (раздел 13.9). *Определения «приёма пищи» и учёт перекуса различаются — считайте фактический интервал своего дома.*

26.7. Германия и Австрия: биография, желание и конец «диабетического стола»

DGE-QST (сертификация с аудитом): «**биография питания**» (Essbiografie) при поступлении — прототип нашей пищевой карты; «**пища по желанию**» (Wunschkost) при критических состояниях и в терминальной фазе; цикл меню ≥4 недель; вегетарианское предложение ежедневно; замещающая еда для пропустивших; повара выходят к жителям с дегустациями^{34, 31}. Австрийский стандарт 2022: **либерализация диет** — нет общего «диабетического стола», решение индивидуально и с участием проживающего⁴¹; исследование SUNRISE: **аппетитные названия блюд измеримо меняют выбор**⁹⁷ — самая дешёвая из всех норм раздела.

26.8. Япония: как стимул стал стандартом

Жизненный цикл за 16 лет: доплата за нутритивный менеджмент (2005) → охват 87–94 % учреждений (2020) → обязательный стандарт с **вычетом за неисполнение** и сдачей данных в национальную базу LIFE (2021)^{98, 99, 100}. Доплата — с меньшим риском ухудшения уровня ухода (HR 0,90)¹⁰¹; больше диетологов в штате — ниже риск

потенциально предотвратимых госпитализаций (скорректированный HR 0,72; 95 % ДИ 0,54–0,97; ретроспективная когорта 2 909 жителей 235 домов; BMC Geriatrics, 2023)¹⁰². Наблюдательное исследование, не РКИ; одна префектура; авторы призывают к осторожности в причинной интерпретации. Структурированная поддержка питания в наблюдательных когортах ассоциировалась и со снижением смертности (HR 0,90)¹⁰³. Урок — траектория: норма росла 16 лет и начиналась с денег за специалиста, не с призывов к качеству (ставки — раздел 38, вопрос 5).

26.9. Десять переносимых норм — сводка

№	Норма	Источник	Российская посадка
1	Ночной интервал ≤11–14 ч	Швеция, США	Расписание + перекус (раздел 13.4)
2	Альтернатива при отказе — обязательна	США	Таблицы замен + правило в положении
3	Выбор «что/когда/где/как»	Австралия, Онтарио	Лестница моделей (раздел 8)
4	Замещающая еда пропустившим; гибкий завтрак	Германия, BDA	Пункт положения о питании
5	Аппетитные названия блюд	Австрия	Доска меню (0 руб.)
6	Пищевая биография при поступлении	Германия	Приложение 3
7	Совет жителей о меню и времени приёмов	Онтарио, Швеция	Раздел 34, приложение 30
8	Триггеры: вес 5/7,5/10 %; 25 % порций; 3 отказа	Онтарио	Разделы 12, 21, приложение 9
9	Кормление 1:2; еда под готовую помощь	Онтарио	Раздел 20 (ориентир)
10	Отчётность о расходах на сырьё	Австралия, Япония	Раздел 29, дашборд

Во всех девяти системах выбор закреплён законом, стандартом или условием оплаты. Берём проверяемые нормы, маркируем происхождение, внедряем локальным актом, измеряем (раздел 22).

26.10. Как читать зарубежные нормы без романтизации

Три фильтра. **Ресурс:** нормы Онтарио (диетолог 30 минут на жителя в месяц²⁶) — система с другим финансированием; переносится принцип «время специалиста нормируется», не минуты. **Правовая конструкция:** F-теги⁹⁵ работают благодаря инспекции с денежными санкциями; переносится механика пронумерованных пунктов во внутренний аудит, не штрафы. **Зрелость:** Стандарт 6 с 01.11.2025³⁷ — норма на старте; переносится формулировка («что, когда, где и как я ем») как ориентир, не как «проверенная модель». Романтизация и ксенофобия одинаково отменяют анализ. Вопрос — «какой механизм работает и есть ли он у нас». Из десяти норм восемь уже имеют российскую рамку: совет, журнал, альтернатива при отказе, триггеры веса, ночной интервал.

27. Что говорят исследования: доказательные вмешательства и их границы

27.1. Зачем раздел и как его читать

Доклад опирается на исследования, не на рекламу методик. Каждое вмешательство — с популяцией, дизайном и ограничениями. **Почти вся доказательная база организационных вмешательств в питании — гериатрия и деменс-уход, не психиатрия;** перенос на ПНИ требует адаптации и своего измерения (раздел 22).

27.2. Вмешательства с измеримым эффектом

Семейная подача (family-style dining). Nijs и соавт., 2006: кластерное РКИ в пяти голландских домах ухода, 178 жителей **без деменции** (не психиатрический контингент ПНИ/ДСО). Общие блюда на столе дали рост качества жизни (+6,1 балла), массы тела (+1,5 кг) и потребления энергии (+991 кДж/день) против контроля³⁶. Перенос на российские ДСО и отделения с деменцией **не обоснован**; механизм (социальность + саморегуляция порций) обсуждается точно, не как норма. Для острых состояний — нет.

IDDSI и текстуры. Пять учреждений: соответствие текстур выросло с 44 % до 90 % (жидкости: 31 % → 100 %), эффект 6 месяцев; барьер — осведомлённость персонала⁴⁶. Перенос прямой: дисфагия есть в любом ПНИ (раздел 10).

Монтессори-подход к еде. Обучение персонала деменс-ухода (Montessori-based activities) улучшает самостоятельность еды и снижает проблемное поведение за столом⁷³. Для когнитивных нарушений; это навык, не меню.

Доплаты за нутритивный менеджмент (Япония). Доплата ассоциирована с меньшим риском ухудшения ухода (HR 0,90); диетологи — с меньшим риском потенциально предотвратимых госпитализаций (скорректированный HR 0,72; 95 % ДИ 0,54–0,97)^{101, 102}. *Ограничение: наблюдательные данные, возможен отбор; причинность не доказана.*

27.3. Вмешательства со слабой или отрицательной доказательностью

Защищённые приёмы пищи (protected mealtimes). Систематический обзор: доказательная база **недостаточна** — исследования малочисленны и неоднородны^{91, 92}. Вердикт: разумно и бесплатно, но не «доказано»; внедряется как организационная гигиена без обещания эффекта.

Образ жизни для снижения веса при ТПР. Мета-анализ: средний эффект порядка –1,4 кг⁶⁵ — статистически реальный, клинически скромный. Программы с диетологом сильнее⁶⁶. Метаболическая стратегия — среда и мониторинг (раздел 13), не ожидание больших цифр.

Малые дома (Green House, Eden Alternative). Оценки показывают улучшение качества жизни и питания^{40, 84}; это системные реформы (штат, архитектура, финансирование), не «приёмы» — горизонт, не действие на следующей неделе.

27.4. Что доказано про вес и препараты (свод клинического ядра)

Клинические факты — в одной таблице; разбор — в разделах 11–13. **Campforts 2023 (BJPsych Open, CRWG)** — исследование веса на антипсихотиках, не меню.

Факт	Число	Источник
Разброс прибавки веса между антипсихотиками (6 недель)	от –0,23 до +3,01 кг	Мета-анализ 100 РКИ ¹⁶
Клинически значимая прибавка (≥7 %) при клозапине	76,3 % пациентов	Campforts 2023, консенсус CRWG ⁶²
Прибавка при первом эпизоде психоза (оланзапин)	до +9,34 кг	FERWG ⁶³
Кофеин повышает АУС клозапина	в среднем +19 %	Контролируемое исследование ¹⁸
Грейпфрут повышает концентрацию карбамазепина	порядка +40 %	Фармакокинетика ²¹
Распространённость дисфагии при психических расстройствах	21,9–69,5 %	Обзоры ^{1, 27}
Смертность от пневмонии при ТПР	RR 7,00	Нац. когорты ¹⁷
Разрыв продолжительности жизни при ТПР	15–20 лет	Нац. когорты ¹⁷

27.5. Что исследования не говорят (честные пробелы)

- Нет РКИ вариативного меню в психиатрических учреждениях** — внедрение выбора опирается на нормы, практики и здоровый механизм, не на рандомизированные исходы. Это не аргумент против внедрения, но аргумент за собственное измерение (раздел 22).
- Нет надёжной доказательности «вариативность снижает отходы»** — связь правдоподобна, документированных сравнений мало; позиция доклада — замерить до и после (приложение 25), не цитировать.
- Нет данных по российским ПНИ** — отечественной исследовательской базы по питанию в ПНИ мы не нашли; это находка для семинара (раздел 39: отраслевые данные — вклад учреждений).

Три опоры: измеримые (семейная подача, IDDSI, Монтессори, диетологи) — по показаниям; слабые (защищённые приёмы, lifestyle) — гигиена без обещаний; пробелы (вариативность, отходы, Россия) — мерить самим. Кто внедрил выбор и замерил отходы, вес и жалобы, через год владеет доказательством, которого сейчас нет ни у кого в стране.

27.7. Что доклад сделал бы с грантом на исследование

Одно исследование из пробелов раздела: многоцентровое (5–7 ПНИ разных регионов) прагматичное внедрение выбора из двух вариантов с измерением отходов, веса, отказов, трудозатрат и качества жизни за 6 месяцев, замер до/после по единой методике. Закрыло бы главный пробел («нет РКИ вариативности в психиатрии») дешевле одного федерального форума. Общий замер семинара (раздел 40) — его задел.

27.8. Как пользоваться базой, не становясь исследователем

Три вопроса к любой «научной» цифре: какая популяция (психиатрия? пожилые? дети?), какой дизайн (РКИ? наблюдение? новость?) и что измерено (вес и госпитализации — или «удовлетворённость» по самодельной анкете). Цифра, не выдержавшая трёх вопросов, в приказ не попадает — в лучшем случае в презентацию с оговоркой. Реестры доклада (раздел 44) размечены по этим трём осям.

27.9. Три исследования, которые стоит знать в лицо

Первое — RCT Нийса, 2006: семейный стиль подачи, не смена меню; цифры и оговорка «без деменции» — в 27.2³⁶. **Второе** — IDDSI в пяти учреждениях: обучение подняло соответствие текстур с 44 до 90 %⁴⁶; резерв — обучение, не оборудование. **Третье** — японская когорта **поддержанного жилья**: питание как сервис ассоциировалось со снижением госпитализаций и смертности¹⁰³. В тройке нет ни российского исследования, ни исследования вариативного меню. Доказательства — о механизмах (стол, текстуры, сервис); «два варианта каши против одного» не доказаны нигде. Честный доклад обязан это сказать вслух. Campforts 2023 в тройку не входит: вес на антипсихотиках, не меню.

28. Люди за линией: персонал стола

БЛОК 1.7. ЛЮДИ И ДЕНЬГИ: ПЕРСОНАЛ, ФИНАНСЫ, ЗАКУПКИ (28–30)

28.1. Почему тема персонала — половина темы семинара

Формула семинара — «права, свободы, интересы жителей и персонала». Изменение исполняют руки: сиделка, повар, раздающий, диетсестра, завхоз. Доклад без их нагрузки и страхов не будет исполнен. В Успенском главным препятствием оказались не деньги и не нормы, а «страхи персонала»³.

28.2. Роли и их реальная нагрузка

Сиделка/санитар. Кормит, наблюдает, фиксирует, предлагает выбор. Добавка вариативности — 5–10 секунд на жителя на линии и строки в журналах; клинический контур — признаки (дисфагия, отказы) и одна фраза эскалации. Минуты смены, не «энтузиазм».

Повар. При парных эквивалентах второй вариант — та же заготовка в другой форме (раздел 19): нагрузка на гастроремкости и маркировку, не на «второе производство». Обратная связь: повар видит, что блюдо выбирают. Немецкая практика — выход к жителям с дегустациями³¹; у нас — дегустация цикла с голосованием совета жителей.

Диетсестра (или завхоз при её отсутствии). Раскладка, таблицы замен, пары эквивалентов; перечень для выбора формирует именно диетсестра². Единственная роль, где вариативность добавляет интеллектуальную работу: подбор пар, пересчёт объёмов (раздел 21).

Врач. Чаще приходящий; функции — письменно, иначе «висят»: текстуры и ограничения, лекарственно-пищевая таблица, еженедельное чтение журналов отказов и потребления, триггеры веса, освидетельствование по ст. 43¹¹.

Руководитель. Положение о питании, приказы, обход по чек-листу (раздел 18.5), квартальная панель (раздел 22.4), разговор с учредителем (раздел 38).

28.3. Норма помощи: самая болезненная цифра

Ориентир 1:2 (один работник — не более двух полностью кормимых)²⁶ для большинства российских учреждений недостижим текущими штатами — и доклад не делает вид, что это решается приказом. Три шага:

- 1. Замер:** сколько кормимых приходится на одного работника фактически на каждом приёме (форма учёта трудозатрат, приложение 26).
- 2. Реорганизация:** все руки на час еды, рассадка по помощи, порядок подачи под готовые руки (раздел 20) — без новых штатов.
- 3. Фиксация дефицита:** разрыв между фактом и ориентиром оформляется числом и выносится учредителю письменно (раздел 38). Молчаливый дефицит — зона риска директора (раздел 33); зафиксированный — предмет компетенции учредителя.

28.4. Обучение: три уровня за три инструктажа

Три сорокаминутных инструктажа с проверкой «на линии»: клинический минимум (дисфагия — раздел 10.3; «3 отказа → врач сегодня»; лекарственно-пищевая таблица — раздел 11) — проверка: фраза на обходе; технология выбора (два варианта, показ неговорящему — раздел 15.5, журналы) — проверка: один обед; санитарный контур (пробы двух вариантов, температуры, маркировка — раздел 18) — проверка: сверка журналов без предупреждения. Содержание по аудиториям — 28.10. Барьер качества — осведомлённость персонала (IDDSI: от 5 до 79 % в разных домах)⁴⁶. Обучение — самая дешёвая точка рычага доклада.

28.5. Мотивация и выгорание

Три механизма. **Видимый смысл** — статистика пилота (раздел 35) до смены, не только до учредителя. **Участие** — повар на дегустации, сиделка в совете, раздающий в разборе жалоб; это лечит «тихий саботаж». **Защита от конфликтов** — письменные правила добавки, порций и замен: решение принимает правило, не человек на линии (раздел 20.4). Мифы — в 28.9.

28.6. Типовые ошибки управления

1. «Приказал — значит внедрил»: без инструктажа и проверки усвоения приказ производит имитацию.
2. Нагрузка «в подарок»: новые процедуры без пересмотра смены — перегруз и откат.
3. Наказание за данные: сиделка, оштрафованная за честную запись об отказах, перестанет записывать — система ослепнет.
4. Изменение без объяснения «зачем»: персонал, не понимающий смысла выбора, видит в нём только лишнюю работу — и оказывается прав по-своему.

28.7. Что сказать старшей смене в понедельник

Письменные роли, включая врача. Замер нормы помощи. Три инструктажа с проверкой на линии. Статистика пилота — до смены, не только до учредителя. В Успенском «страхи персонала не подтвердились»³ после того, как их озвучили.

28.8. Беречь тех, кто кормит

Помощь за столом сталкивается с отказами, агрессией, смертью подопечных — и почти не получает обратной связи. Три жеста: разбор трудных ситуаций без виноватых (кейсы 1–22); конкретная благодарность («ты накормила его вчера, когда он неделю не ел»); фильтр новых форм — «какое решение она меняет» (раздел 31.7). Текучесть смены — налог на качество: новая сиделка не знает карт и темпов; дом с кадровой каруселью кормит хуже при любом меню.

28.9. Мотивация без мифов

Два мифа. Денежный: «пока не доплатят, ничего не будет» — опыт внедривших прошёл без доплат^{6, 25}; валюта смены — выполнимость: процедура, которая укладывается в смену, выполняется; процедура, добавляющая час на «бумагу», саботируется молча и справедливо. Идеологический: «главное — объяснить про права» — права убеждают руководителей; смену убеждает другое: меньше скандалов за столом, меньше недоеденных тарелок, ясные ответы на «а что мне делать, если...». Ядро инструктажа — не ценности, а кейсы 1–22. Ценности — обязательный фон, но фон не заменяет маршрут.

28.10. Три инструктажа: содержание по уровням

Единый «общий инструктаж» не работает. **Кухня (45 минут)**: пары эквивалентов и ранговость; маркировка и пробы двух вариантов; IDDSI с тестом вилкой; лекарственно-пищевая таблица на закладке, не в памяти; журнал срывов. **Пост (45 минут)**: меню в форматах жителей; журнал заказа при жителе; алгоритмы отказов (приложения 10–11); признаки дисфагии; запрет еды как рычага; помощь в темпе едока. **Администрация (30 минут)**: правовая рамка зон (раздел 17); ответ проверяющему (раздел 32); панель чисел. При найме — до первой смены; далее раз в год. Проверка — три вопроса у линии: «если выбранное кончилось?», «кому — о трёх отказах?», «запись вчерашнего заказа».

28.11. Трудоёмкость выбора: человеко-минуты, которые нужно знать директору

Страх смены — «это добавит час на каждую раздачу». Цифра другая. **Иллюстративная раскладка** для обеда на отделении 30 жителей в модели М1 (выбор одного приёма 2–3 дня в неделю, раздел 8). Оценки экспертные и аналоги канадского аудита полной стоимости питания (раздел 29.2)⁵⁹ — не замеры в российских учреждениях; **собственный замер обязателен** (приложение 25, раздел 22.3).

Действие	Без выбора (мин)	С выбором М1 (мин)	Доп. нагрузка	Кто делает
Показ меню жителям (визуальное, устное)	0	3	+3	Сиделка/санитар
Сбор заказа (накануне / в начале смены)	0	5	+5	Старшая смена
Пересчёт объёмов (по статистике выбора)	0	4	+4	Диетсестра/завпроизводства
Маркировка второй гастроёмкости (загрузка на линию)	0	2	+2	Повар
Раздача с предложением выбора	30 (60 сек × 30)	35 (70 сек × 30)	+5	Сиделка/раздающий
Запись в журнал заказа (3–5 строк)	0	3	+3	Старшая смены
Запись в журнал замен (если были)	0	2	+2	Раздающий

Действие	Без выбора (мин)	С выбором М1 (мин)	Доп. нагрузка	Кто делает
Итого на 30 жителей за обед	30	52	+22 минуты	—
В пересчёте на 1 жителя	1,0 мин	1,7 мин	+0,7 мин/житель	—
В пересчёте на 3 приёма пищи (завтрак, обед, ужин) для 30 жителей	90	130–140	+40–50 минут в сутки	—

Доп. нагрузка М1 — около 40 минут в сутки на отделение 30 жителей (≈ 80 человеко-минут в неделю); укладывается в пересменку, если минуты видны. М2–М3: +60–90 минут в сутки; М4 и М5 перестраивают роль персонала. Группа помощи — 2–3 мин/житель. Возражение «нас не хватит» чаще закрывается потоком (раздел 20): предзаказ, визуальное меню, маркировка «вариант А / вариант Б».

Канадский аудит (раздел 29.2): до 45 минут на жителя группы помощи в сутки — **значительно больше** наших 1,7 мин/жителя (там выбор встроен в широкую модель помощи). Прямое сравнение не работает; ориентир: **помощь за столом — самая дорогая строка**.

В таблице нет: (а) повар на второй вариант — 10–20 минут на партию при эквивалентных парах («гречка/рис» одновременно); (б) врач на диетические столы (раздел 19); (в) диетсестра на пары и раскладку (раздел 19.2, раз в квартал — 4–8 часов). Эти позиции — в разделе 29.4; здесь — только линия раздачи.

Цифра для учредителя: **+22 минуты** на обед для 30 жителей в М1. Укладываем в пересменку или заявка на ставку. «Не справимся, потому что страшно» без цифры — не управление.

29. Финансовые модели: сколько стоит питание и сколько стоит выбор

29.1. Честная рамка: что мы не утверждаем

В прежних версиях стояла формула «вариативность почти бесплатна». Она удалена. Стоимость зависит от модели и измеряется замером: утверждать экономию без данных нельзя, утверждать невозможность — тоже. Раздел даёт инструментарий: три стоимости, пять моделей с их ценой, порядок замера. Все числовые примеры — иллюстративные.

29.2. Три стоимости, которые путают

Сырьевая строка — продукты на жителя в день. Ориентиры (год и валюта, не нормативы для РФ): медиана \$8,00 AUD (Австралия, Hugo)⁹³; Онтарио: \$8,33 CAD, выросшие до \$13,71 CAD после кампании^{104, 105}; США: более четверти домов в 2025 году ниже \$10 (ассоциация ANFP, не госорган)^{106, 107}. Урок — механизм: во всех трёх странах изменения начались с публикации сырьевой строки^{94, 105}.

Полная стоимость приёма пищи — сырьё + труд кухни + энергия + амортизация. Канадский аудит: \$27,91–54,85 за жителя в день — в 3–6 раз выше сырьевой строки⁵⁹. Экономия на сырьё при огромной полной стоимости — самая неэффективная экономия системы.

Стоимость кормления — время помощников за столом. Те же канадские данные — до 45 минут в день на жителя группы помощи⁵⁹. Самая дорогая и самая скрытая строка: живёт в штатном расписании, не в продуктовом бюджете.

29.3. Сырьевая строка: как посчитать свою за час

Формула (приложение 25): расходы на продукты за месяц ÷ число жителей ÷ число дней = руб./житель/день. Три правила: считать только продукты (без труда и коммуналки); сравнивать с собой в динамике и с региональными коллегами, не с зарубежными долларами; публиковать — учредителю и совету жителей: прозрачность строки во всех изученных странах работала на её рост^{94, 104}. Если никто в доме не может назвать эту цифру за пять минут — это первая находка аудита (раздел 22).

29.4. Пять моделей вариативности и их честная цена

Модель	Что меняется	Цена сырья	Цена труда	Разовые затраты
М1. Выбор из двух (завтрак+обед, 2–3 дня/нед)	Вторая гастроёмкость, журнал заказа	~0 (перераспределение пар)	+минуты на линии	Гастроёмкости, маркеры
М2. Выбор ежедневно по позициям	Тот же принцип в полном объёме	~0 при пересчёте по статистике	+время раздачи и учёта	Визуальное меню

Модель	Что меняется	Цена сырья	Цена труда	Разовые затраты
М3. Буфетная зона (салаты/напитки)	Самообслуживание в зоне	Рост потребления → пересчёт	Контроль зоны	Стеллажи, посуда
М4. Семейная подача (точечно)	Подача общими блюдами	~0	Меняется роль персонала	Столовая посуда
М5. «Своя кухня» (реабилитация)	Программа навыков	Как у группы	Персонал-сопровождающий	Кухонная зона

Модельные оценки, не замеры: фактическая цена — семидневный замер до старта и через 90 дней (приложение 25).

Механизм М1–М2: сырьё не добавляется — **перераспределяется внутри той же строки** через пары эквивалентов (раздел 19.2). Пример: отделение 30 человек, каша гречка/рис — суммарный расход круп тот же, меняется пропорция. *Расчёт иллюстративный; пропорции — статистика выбора.*

29.5. Отходы: единственная честная «экономия»

Несъеденная порция — оплаченное сырьё в баке. Выбор снижает долю несъеденного: нелюбимые блюда перестают попадать на тарелку. Но (1) доказательной базы эффекта в наших условиях нет (раздел 27.5); (2) формула доклада — **замер до и после**. Семь дней до пилота и через 90 дней дают собственную цифру. Международные аналоги (снижение остатков при улучшении качества и выбора) существуют¹⁰⁸ и переносятся только как гипотеза. Граммы в рубли — в 29.11.

29.6. Каналы денег и разговор с учредителем

Источники изменения продуктовой строки: региональные нормы (пересмотр — компетенция учредителя/региона), экономия отходов (по замеру), пожертвования и целевые программы, буфетная выручка (если предусмотрена уставной деятельностью). Инструмент разговора — пакет из раздела 38: сырьевая строка в динамике, замер отходов, международная механика прозрачности⁹⁴. Австралийский урок: надбавка \$10 AUD дана **в обмен на ежеквартальную отчётность**⁹⁴ — такую конструкцию может предложить и российский директор. Скелет презентации — в 29.9.

29.7. Ловушка экономии

Питание — худшее место для экономии. Сырьевая строка сжимается → качество падает → растут отходы и недоедание → растут соматические расходы и жалобы → система платит втрое в других строках^{59, 93}. Аргумент директору, которому «режут продукты»: стоимость недоедания (пневмонии, госпитализации) против копеек сырьевой строки. Три действия: строка за час, отходы за неделю, дефицит числом учредителю письменно. М1–М2 не требуют новых денег и не обещают экономии до замера. Пропорция «сырьё — меньшая доля» — в 29.10.

29.9. Разговор о деньгах с учредителем: скелет презентации

Десять слайдов мысленной презентации (не путать с семинарской): 1) сырьевая строка — руб./житель/день; 2) динамика за год; 3) доля сырья в полной стоимости (методика⁵⁹); 4) отходы в рублях — факт замера; 5) что сделано без денег; 6) эффект — числа до/после; 7) что стоит денег — три позиции с расчётом; 8) цена бездействия (отходы, жалобы, проверки⁷⁸); 9) просимое решение — одно, с датой; 10) что отчётность покажет через квартал. Каждый слайд — число или документ; эмоция в разговоре о деньгах проигрывает счёту всегда.

29.10. Ловушка экономии: когда «сократить сырьё» дороже всего

Канадский аудит полной стоимости⁵⁹: сырьё — меньшая часть полной стоимости, труд и инфраструктура — большая. Сокращение сырьевой строки — самая заметная и самая вредная экономия: бьёт по жителям, экономит меньшую долю, производит скрытые издержки (вес, здоровье, жалобы, проверки). Обратная стратегия — эффективность большой доли (поток, трудозатраты, отходы) при стабильной сырьевой строке. Поэтому публикация строки (раздел 29.3) — защита жителей: видимая строка сопротивляется сокращению лучше невидимой^{94, 104}.

29.11. Отходы: как замер превращается в рубли

Замер (приложение 25) даёт граммы на порцию; топ-3 блюд по остаткам сверяются с циклом: уходят, уменьшаются или заменяются парой. Перевод: масса недельных отходов × цена килограмма по фактуре. Три правила: отходы не равны нулю нигде; тарелочные остатки — вкус, размер порции, состояние жителей, кухонные — планирование объёмов; снижение после выбора — гипотеза, которую подтверждает только повторный замер через 90 дней. Иллюстрация (не замер): дом на 150 жителей, 80 г на порцию, 3 приёма — 36 кг в день; при условных 250 руб./кг — порядка 9 000 руб. в день потенциала. Дом-тысячник (Серафимовский — 1 004 проживающих на февраль 2026, кейс 25.5) при тех же 80 г и трёх приёмах — **240 кг в день, порядка 60 000 руб./день условного потенциала**. Цифры условные — порядок действий настоящий.

Если учреждение готовит на своей кухне — модели М1–М5 выше. Если питание на аутсорсинге — контрактные риски, восемь строк ТЗ и приёмка: раздел 42.

30. Закупки продуктов: 44-ФЗ без кошмаров

30.1. Рамка раздела

Закупка продуктов для казённого и бюджетного стационара, как правило, идёт по 44-ФЗ. Для автономного учреждения режим зависит от положения о закупке: часть операций — по 223-ФЗ, субсидия на госзадание нередко остаётся в контуре 44-ФЗ — зона юриста, не формула «всем 44-ФЗ». Два риска: формальный (процедура) и антимонопольный (картель поставщиков или обвинение в ограничении конкуренции). Доклад не заменяет контрактного управляющего; раздел — стык закупки с питанием и то, где директор обязан быть грамотным лично.

30.2. Продуктовая рамка: что нужно знать директору

Три принципа. Первый: **объект закупки — продукты по спецификации**; качество спецификации определяет стол сильнее, чем качество повара. «Крупа гречневая, ГОСТ, ядрица, не ниже первого сорта» и «крупа» — две разные столовые. Второй: **пропорции внутри спецификации — инструмент вариативности**: пары эквивалентов (гречка/рис, курица/рыба) закладываются в закупку заранее, по статистике выбора (раздел 21); вариативность, не заложенная в план, умрёт на складе. Третий: **сроки и партии** важнее экономии на цене — срыв одной позиции ломает раскладку и таблицы замен.

30.3. Антимонопольная зона: практика ФАС

ФАС раскрыла картель на торгах по поставке социально значимых продуктов — 543 торга на 4,7 млрд рублей (Москва, Московская область, Владимирская область, Дагестан; 2024)⁷⁸; в Челябинске — картель на 27 тендерах школьного питания 2022–2024, штраф 5,1 млн и уголовное дело по ст. 178 УК (2025)⁷⁹. Три вывода для директора-заказчика:

1. **Картель бьёт по качеству и цене стола** — заказчик, замечающий признаки согласованности (одни и те же компании с «подставными» заявками, цены «с потолка»), обязан сообщать в УФАС: это защита жителей, не доносительство.
2. **Заказчик тоже в зоне риска**: избыточные требования («поставщик с опытом работы именно с нашим учреждением», товарные знаки без «или эквивалент») — состав ограничения конкуренции.
3. **Документируйте качество поставок**: акты приёмки, брак, возвраты — санитарный контур (раздел 18) и база для претензий поставщику и для УФАС.

Практика ФАС — по публичным сообщениям; для конкретных решений нужно заключение контрактной службы/юриста. Признаки в своих торгах — в 30.7.

30.4. Закупка и вариативность: стыковка

1. Статистика выбора за 2–3 месяца (раздел 21) → пропорции пар в спецификации.
2. Сезонность и праздничное меню → корректировка квартальных объёмов (совет жителей, раздел 34).
3. Таблицы замен → «запасные эквиваленты» в спецификации на случай срыва поставки.
4. Малые партии скоропорта → график поставок, не склад.
5. Раз в год — пересмотр спецификации по замеру отходов (приложение 25): что стабильно не съедается, уходит из закупки законно, через таблицы замен^{14, 15}.

30.5. Аутсорсинг питания: за и против честно

Аргументы «за»: профессиональное производство, санитарная дисциплина, снятие нагрузки. «Против» — знать до контракта: потеря гибкости, зависимость от контракта, разрыв «житель — кухня». Вариативность закладывается в ТЗ (два варианта, текстурные линии, журналы выбора, дегустации) — не вписанная, от аутсорсера не дожидаться. *Рекомендация, не норма.*

Директор не обязан быть закупщиком. Обязан: спецификация определяет стол; вариативность в плане закупок по статистике; признаки картеля и канал в УФАС; приёмка; при аутсорсинге — выбор в ТЗ. Пять пунктов, не погружение в 44-ФЗ.

30.7. Картели: что директор обязан знать, не будучи юристом

Цифры масштаба — в 30.3 (543 торга / 4,7 млрд; Челябинск: 27 тендеров, штраф 5,1 млн)^{78, 79}. Директор — не следователь. Три признака в своих закупках: одни и те же два-три поставщика поочерёдно «выигрывают» с близкими ценами годами; снижение от начальной цены ритуально мало (доли процента); «проигравший» в этом торге побеждает в соседнем с тем же раскладом. Один признак — не доказательство; устойчивая картина —

основание информировать учредителя и, при его согласии, обратиться в ФАС (анонимность заявителя законом предусмотрена). Карфельная закупка — скрытый налог на сырьевую строку; разговор «дорого варить два варианта» иногда стоит начинать не с кухни, а с цен закупки.

30.8. Спецификация под вариативность: пять строк, которые всё решают

Новых законов не нужно — нужны пять строк. **Перечень:** позиции как группы взаимозаменяемых («крупы гарнирные: гречка, рис, пшено»), не монопозиция — пары легальны на уровне контракта. **Пропорции:** объёмы внутри группы по статистике выбора с правом корректировки раз в квартал без изменения сути контракта (в пределах допустимых 44-ФЗ изменений). **Замены:** при недопоставке — эквивалент из той же группы по согласованию, с актом. **Качество:** характеристики, значимые для текстур (помол, консистенция полуфабрикатов), — иначе дисфагический контур заложник «самого дешёвого фарша». **Приёмка:** ответственный и форма акта — без этой строки претензии превращаются в обиды. Каждая строка согласуется с контрактной службой заранее; конфликт «меню против контракта» — симптом того, что меню меняли, а спецификацию нет.

Аутсорсинг (223-ФЗ или 44-ФЗ на услугу питания) — другая механика: восемь строк ТЗ, контроль приёмки, привязка к меню. Раздел 42, особенно 42.3 и 42.7.

31. Документальный комплект: как практика становится системой

БЛОК 1.8. ДОКУМЕНТЫ, РИСКИ, СТРАТЕГИЯ: ДОКУМЕНТЫ, ПРОВЕРЯЮЩИЙ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, СОВЕТ, ПИЛОТ, КАРТА, ВОЗРАЖЕНИЯ, УЧРЕДИТЕЛЮ, ОТРАСЛИ, СЕМИНАР, ДОСТОВЕРНОСТЬ, АУТСОРСИНГ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, БИБЛИОГРАФИЯ (31–44)

31.1. Зачем документы, если практика уже работает

Устная договорённость «у нас два варианта» живёт до первого проверяющего, конфликта с родственником или ротации. Комплект закрепляет границы, распределяет ответственность по фамилии и делает практику воспроизводимой. Собрано из разделов 17–30; шаблоны — приложения 1–36, все — **проекты локальных форм.**

31.2. Шесть базовых документов

1. Положение об организации питания (локальный акт). Нормативная база (3185-1 ст. 43, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и с 01.09.2026 — СанПиН 2.3/2.4.4282-26, приказ Минтруда 520н — нормы рекомендованные, если регион не императивен)^{11, 12, 32}; структура питания; роли; учёт индивидуальных потребностей. Утверждается директором, согласовывается с учредителем по регламенту региона.

2. Раздел о вариативности в положении или отдельный порядок. Перечень позиций с выбором; механизм заказа (журнал, визуальное меню); гарантия стандартного варианта («никто не остаётся без полноценного приёма пищи»); правило замен; связь с лечебным питанием через «мост» (раздел 24).

3. Меню с вариантами. Двухнедельное или четырёхнедельное (международный ориентир цикличности — 21–28 дней^{26, 34}; в РФ императива цикла для СОСО нет — региональные требования собирайте локально). Каждая вариативная позиция — пара эквивалентов с нутриентным обоснованием (раздел 19).

4. Журналы заказа и замен. Два журнала или один совмещённый. Второй важнее: доказательство нормы об альтернативе при отказе — в США прямо³⁸, в РФ выводится из ст. 37 3185-1 в связке со ст. 43⁴¹ (толкование — раздел 17).

5. Пищевые карты жителей. Не медицинская карта: предпочтения, запреты, текстура (IDDSI при показаниях)⁴⁵, помощь, лекарственные ограничения (раздел 11). Формат — приложение 7; источники — наблюдение, житель, близкие, врач по иерархии раздела 15.

6. Согласование с учредителем. Письмо-отчёт о пилоте с панелью 12 чисел (раздел 22) до и после. Изменения через учредителя переживают проверки; изменения «тихо» — не всегда^{3, 4}.

31.3. Три клинических документа

7. Лекарственно-пищевая таблица (раздел 11, приложение 21): пять правил взаимодействий с классами уверенности. Подпись врача; кухня и постовая; обновление при смене назначений.

8. Список дисфагического риска (раздел 10, приложение 21): жители с признаками, уровень текстуры, приём «два обученных человека на посту»¹. Врачебный документ — ведение делегируется старшей сиделке.

9. Журнал отказов (раздел 12, приложение 9): дата, приём пищи, обстоятельства, действия. Три отказа подряд — врач в тот же день.

31.4. Три управленческих документа

10. Приказ об ответственных: за питание в целом, за вариативную линию, за журналы, за связь с врачом. Без фамилий комплект не работает.

11. Регламент совета жителей по питанию (раздел 34, приложение 30): состав, периодичность, полномочия (меню, дегустации, пожелания), форма доведения решений до администрации.

12. Квартальная панель (раздел 22, приложение 35): 12 чисел на одном листе — от отходов до доли выбирающих. Не отчётность наверх, а самопроверка.

31.5. Учётная форма: что сказать честно

Учёт продуктов в СОСО — формы по приказу Минфина 52н; переход на электронные формы поэтапно через приказы 61н, 142н, 100н, 157н, 174н¹⁰⁹. Не называйте конкретную форму «обязательной для вас», пока это не подтвердил учредитель или региональный орган: статус форм менялся не раз. Журнал заказа живёт рядом с любой учётной формой, не вместо неё.

Двенадцать документов — один пакет, не библиотека. Соберите за неделю из приложений 1–36, подпишите приказ, покажите учредителю — практика перестанет зависеть от того, кто сегодня стоит у раздачи.

31.6. Порядок сборки комплекта за неделю

Пять дней, если приложения 1–38 — заготовки. День 1: приказ об ответственных и приказ о пилоте (приложения 17, 28). День 2: положение о питании с разделом о вариативности (приложение 29); 60 % текста — из заготовки. День 3: клинический блок с врачом — таблица, список риска, журнал отказов (приложения 21, 9); без подписи врача день не заканчивать. День 4: журналы заказа/замен/срывов, меню с парами, карты первой очереди (группа риска и неговорящие — первыми). День 5: регламент совета (приложение 30), панель (приложение 35), письмо учредителю. Проверка: новый сотрудник понимает действия за час? папка отвечает на три вопроса раздела 32? Два «да» — комплект работает.

31.7. Когда документов слишком много

Антипаттерн — раздувание: положение на сорока страницах, журналы на двенадцати графах, карты на шести листах. Признак: форма не заполняется в ритме смены. Каждая графа обязана отвечать «какое решение принимается по этой графе»; графа без решения удаляется. Лучший комплект — самый короткий из полностью работающих: проверяющему нужна доказуемость, смене — выполнимость; общий знаменатель — краткость.

31.8. Жизненный цикл документа: пересмотр

Документ без даты пересмотра стареет молча. Меню и пары — по циклу пересчёта (раздел 21.9); лекарственно-пищевая таблица — при каждой смене назначений и не реже раза в квартал; список риска — ежемесячно; положение — раз в год (учётные формы меняются этапами¹⁰⁹); панель — ежеквартально. Ответственный за актуальность — в приказе об ответственных, одной строкой на документ. Вопрос на обходе: «когда это менялось последний раз»; документ, не менявшийся год в живой системе, либо мёртв, либо система неживая.

32. Как отвечать проверяющему: сценарий диалога без страха

32.1. Почему этот раздел отдельно

Главный барьер — фраза «придут и спросят». Страх реальный, но размытый. Раздел даёт сценарий. Основа — административные дела^{78,79} и надзорные документы¹³; не консультация юриста по делу.

32.2. Кто приходит и что проверяет

Роспотребнадзор — санитария: на дату семинара СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 7.1.11–7.1.14; с 01.09.2026 — СанПиН 2.3/2.4.4282-26, п. 56 подп. 11–14 (питание проживающих не менее 3 раз в день, в том числе диетическое по показаниям; суточные пробы)¹². Вопросов «почему два варианта» нет — есть вопросы о температуре, маркировке, суточных пробах, поточности. Вариативность входит как дополнительная линия, не как новый объект (раздел 18).

Соцзащита / учредитель — стандарты и нормативы региона, расходование средств, жалобы. Защита — документы: согласование, меню с эквивалентами, журнал замен, панель чисел (раздел 31).

Прокуратура — по жалобам, чаще о правах жителей. Опора — ст. 37 и 43 закона 3185-1¹¹. Вопрос «были ли нарушены права»; журнал отказов и документированный выбор — ответ, не уязвимость.

32.3. Три вопроса и три ответа

«Почему не по утверждённому меню?» Варианты — часть меню; пары эквивалентов нутриентно равноценны; перечень согласован. Если региональное меню императивно — сначала меняется региональный документ, потом

практика (раздел 24). Красная линия: при императивном меню «два варианта» без изменения документа — нарушение, и доклад этого не советует.

«Где гарантия, что житель получил норму?» Журнал заказа и журнал замен: каждый получил выбранное, либо стандартное, либо зафиксированную замену. В США альтернатива при отказе закреплена федерально³⁸; в РФ выводится из права на уважение человеческого достоинства (ст. 37 в связке со ст. 43)¹² — журнал превращает толкование в доказательство.

«Кто разрешил?» Приказ директора и отчёт учредителю. Внедрившие шли этим путём^{6, 25}.

32.4. Чего не говорить проверяющему

Не говорите «так теперь везде» (неправда и не аргумент). Не говорите «нам диетолог разрешил» (должности может не быть в штате — уязвимость, не защита). Не говорите «жители сами захотели» без документа (устная воля не проверяема; пищевая карта и протокол совета — проверяемы). Каждая устная фраза — с бумажным двойником из комплекта раздела 31.

32.5. Если замечание всё же выписано

Зафиксировать формулировку точно. Запросить норму, на которую ссылаются (немотивированные отсылки к «нарушению порядка» разваливаются при запросе конкретики)⁷⁸. Подключить учредителя на стадии возражения, не после постановления. При штрафе — перспектива обжалования с юристом. Данных о процентах отменённых замечаний по вариативному питанию нет — тема в судебной практике не выделена; статистику не выдумывать.

Комплект — до старта пилота (раздел 35), не после первого звонка из надзора.

32.6. Досье проверки: папка, которая отвечает за вас

Папка «Питание: проверки» — заранее, у заместителя, не в сейфе. Состав: приказы (питание, пилот, ответственные); положение с разделом о вариативности; меню с парами и обоснованием эквивалентности; журналы за квартал (заказ, замены, отказы, срывы); санитарный блок (пробы, температуры, паспорт второй гастрорёмкости — раздел 18.9); клинический блок (таблица, список риска — подписи врача); панель чисел; переписка с учредителем; протоколы совета. Десять разделов — на десять вопросов; ответ за минуту меняет проверку из допроса в сверку. Актуальность — квартал; прошлогодние журналы хуже отсутствия папки.

32.7. Поведение при проверке: пять правил

Отвечать на заданный вопрос, без экскурсии — лишнее порождает новые вопросы. Факты — документом, не словом; «у нас ведётся журнал» без журнала — антиответ. Не спорить в коридоре: несогласие письменно после; коридорный спор проигрывается всегда, письменное возражение — иногда выигрывается. Фиксировать ход своей записью (кто, что спросил, что показано) — основа возражений. Не подписывать акт с формулировками, которых не понимаете: оговорка «с формулировкой не согласен, возражения будут представлены» сохраняет позицию; молчаливая подпись её хоронит.

33. Ответственность директора: честная карта рисков без запугивания

33.1. Принцип раздела

Ответственность подают запугиванием («посадят за всё») или успокоением («ничего не будет»). Оба мешают решениям. Карта: какие составы применялись по «пищевым» сюжетам, какие существуют на бумаге, как вариативность меняет риск-профиль. Обзор практики, не юридическое заключение.

33.2. Что реально применялось: КоАП ст. 6.6

Статья 6.6 КоАП — нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах. Публичные дела: штраф СРЦ «Кашинский» (2022, качество питания)¹³ и Зеленогорский ДИПИ (2021, ТАСС)¹³. Оба — о качестве и достаточности, не о вариативности. Дел о «двух вариантах» в публичном поле нет — «данных нет», не доказательство безопасности.

Постановление ВС РФ от 21.02.2019 № 11-АД19-4²⁴: дом-интернат не организация общепита — питание проживающих как социальная услуга, не реализация населению. Квалификация защищает от чужих норм об общепите, не отменяет СанПиН. Защита — след: меню, акты, журналы.

33.3. Уголовные составы: где граница реальности

УК ст. 238 (услуги, не отвечающие требованиям безопасности), 285/286 (злоупотребление и превышение полномочий), 293 (халатность) формально применимы к руководителям. Публичных дел против директоров ПНИ именно по организации питания в проверке не обнаружено. Градиент: жалобы и прокурорские представления

(часто) → административные дела по 6.6 (реже, но есть) → уголовные составы (по пищевым сюжетам — не выявлено в публичной практике). Запугивание уголовными статьями — недостоверная риторика; игнорирование административного контура — легкомыслие.

33.3а. Качественная шкала риска (без выдуманных вероятностей)

«Дел о двух вариантах не найдено» — **не «низкий риск»**, а **непроверенная зона**: нет публичных дел ≠ нет дел. Состав 6.6 карает за **качество и достаточность**, не за число блюд; вариативность не создаёт нового состава и не защищает от старых. Риск — по документальному следу. Числовых вероятностей **нет**. Карта ниже: частота в **публичной** практике (не прогноз для дома), тяжесть, что двигает риск.

Вектор	Частота (публичная практика)	Тяжесть	Повышает	Снижает
Жалоба жителя/родственника	высокая (массовый повод — «невкусно, не ем»)	низкая сама по себе	молчаливая раздача без записи	журнал выбора и замен, совет жителей (разд. 34)
Прокурорское представление	средняя	низкая–средняя (устранение + контроль)	жалоба, проигнорированная неделями	регламентный разбор в дни (прил. 34)
Административное дело 6.6 КоАП	низкая, но реальная — о качестве/достаточности	средняя (штраф должностному лицу)	недоброкачественные продукты, имитация проб	пробы, бракераж, температурный контур, меню и акты
Уголовные составы (238/285/286/293)	по пищевым сюжетам в публичной практике не выявлено	высокая, но крайне редкая	системное бездействие при известном вреде	работающий контроль и своевременная реакция

Вариативность не добавляет ни одной строки в этой таблице. Она перераспределяет жалобу из «невкусно» в «я выбрал сам» — если выбор задокументирован. Без документов **утяжеляет** вектор 6.6: «два варианта без записи» читается как «отступление от меню».

33.4. Как вариативность влияет на риск: два направления

Снижает. Жалобы — невкусно, однообразно, «не ем это». Документированный выбор снимает массовый повод; журнал замен закрывает «оставили голодным»; совет жителей (раздел 34) делает жалобщиков соавторами меню. Нормы о выборе в США, Онтарио, Австралии — защита прав; проверяющие оценивают дома по их исполнению^{38, 26, 37}.

Создаёт риск при плохом исполнении. Два варианта без документов = «отступление от меню»; замена без записи = «не докормили»; выбор без связи с лечебным питанием = риск для диет. Риск-профиль — в документальном контуре (разделы 31–32). Шкала — в 33.3а.

33.5. Личная ответственность: три правила сна директора

Первое: решения о вариативности — коллегиальные и документированные (приказ, протокол совета, согласование с учредителем). Единоличное устное распоряжение — самый уязвимый формат. Второе: клинические границы определяет врач; директор отвечает за исполнение назначений, не за их содержание (дисфагия, взаимодействия, диеты — разделы 10–11). Третье: жалоба — сигнал системы, не личная атака; регламент разбора (приложение 34) снимает роль «бьющегося за каждый эпизод» и возвращает роль управляющего системой. Директор отвечает за систему контроля, не за каждое событие за столом.

Риск вариативности с документами ниже риска бездокументной монотонности. Считайте риск по документам, не по страшилкам.

33.6. Страховка вместо страха: что реально снижает личный риск

Четыре элемента значимее намерений^{78, 79}. **Коллегиальность**: приказ + протокол совета + уведомление учредителя. **Клиническая делегация**: каждый клинический документ подписан врачом; подписавший таблицу взаимодействий сам принял чужой риск даром. **Скорость**: разбор жалобы в дни (приложение 34) — «прокурорские» сюжеты растут из жалоб, проигнорированных месяцев. **Честность статусов**: документ-проект не даёт претензии «самоуправство»; документ, изображающий нормативность, которой нет, — даёт. Риск определяется качеством следа, не смелостью изменений.

33.7. Психологическая цена вопроса — и её управление

Страх ответственности — главный тормоз; документами он снимается не полностью. Три приёма: разделить риск; ограничить первый шаг (пилот отделения, не дома); дата пересмотра (эксперимент, не «навсегда»). Задача раздела не «не бояться», а сделать так, чтобы бояться было нечего конкретно.

34. Права жителей и совет жителей: от объекта заботы к соавтору меню

34.1. Правовая рамка без натяжек

Права жителей СОСО закреплены: ст. 37 закона 3185-1 (уважение человеческого достоинства, гуманное обращение) распространяется на проживающих через ст. 43¹¹. Конвенция о правах инвалидов — ст. 28 (достаточный жизненный уровень и питание) и Замечание общего порядка № 1: поддержка правоспособности требует узнавать волю и предпочтения человека, а не решать «за него»^{80, 29}. Конструкции «права на выбор блюда» в российском законе нет — честная серая зона (раздел 17): выбор внедряется как способ реализации уже существующих прав, не как новое право из ниоткуда.

34.2. Три модели участия жителей

Информационная: извещение о меню (доска, раздатка, визуальное меню). Минимум за неделю; участие без влияния.

Консультативная: опросы предпочтений, дегустации, «ящик пожеланий». С опроса начинала Усть-Илимская организация⁴. Влияние есть, ритм задаёт администрация.

Институциональная: совет жителей (по образцу ДДСОЛ: совет по питанию — постоянная структура с распорядительным документом от 13.04.2017)²⁵. Совет обсуждает меню до утверждения, проводит дегустации, собирает и ранжирует пожелания, получает отчёт о судьбе пожеланий. Единственная модель, где участие переживает смену заведующих отделениями.

34.3. Совет жителей: как собрать работающий, а не декоративный

Состав. 5–9 человек: жители (включая недееспособных — интересы представляют выбранные ими лица или члены совета по регламенту), сиделка, повар, врач (совещательный голос). Квоты по отделениям, иначе совет — клуб самого активного корпуса.

Полномочия. Четыре: обсуждать меню до утверждения; проводить дегустации; собирать пожелания и доводить до администрации; получать ответ в установленный срок. Не включайте то, что администрация не готова исполнять, — декоративный совет хуже отсутствующего: он производит цинизм.

Ритм. Ежемесячное заседание с коротким протоколом (приложение 30). Протокол — доказательство для раздела 32: «жители сами захотели» со ссылкой на протокол — проверяемое утверждение.

34.4. Недееспособные жители в совете: не исключение, а особый формат

74 % жителей ПНИ по вторичной аналитике — недееспособные⁷ (статус данных — раздел 23). Исключить их — исключить большинство. Форматы: представительство через доверенных лиц (не обязательно опекуна-учреждение — конфликт интересов, раздел 16); наблюдательные методы (показ, выбор, реакция — раздел 15) в пищевой карте; ротация «пробных обедов», где реакция — данные для совета. Международные нормы требуют учитывать предпочтения независимо от когнитивного статуса: Австралия, Стандарт 6 с 01.11.2025³⁷; Онтарио — обязательный учёт preferences в плане питания²⁶.

34.5. Конфликт интересов «учреждение = опекун» в совете

Если опекун — учреждение, в совете оно потенциально голосует за жителя. Антидоты из раздела 16: приоритет пищевой биографии над «усреднённым благом»; независимые представители, где они есть; фиксация разногласий в протоколе. Формула для локального акта: «при расхождении позиции администрации с зафиксированными предпочтениями жителя приоритет имеют предпочтения, если они не противоречат назначениям врача».

Совет бесплатен, снимает жалобы до их рождения и превращает «права жителей» в ежемесячную процедуру. Начните с опроса предпочтений — как в Усть-Илимске⁴ — и дайте опросу статус протокола.

34.6. Первое заседание: сценарий по минутам

Первый совет решает, будет ли второй. Сценарий на 40 минут: **5 минут** — «меню обсуждают те, кто ест»; **10 минут** — четыре полномочия и чего совет не может (врач и СанПиН); **15 минут** — дегустация двух кандидатов с голосованием; **5 минут** — три пожелания; **5 минут** — дата следующего и ответ. Ошибки: чтение положения вслух; обещания вне полномочий; состав «для фотографии». Протокол — три строки: кто был, что решили, кому поручено.

34.7. Совет и семьи: граница ролей

Пускать ли родственников. Совет — структура жителей; семьи — отдельный канал (дни открытых дверей, дегустации по приглашению совета, памятка приложения 32). Смешение ролей: говорящие родственники представляют говорящих жителей, молчащее большинство остаётся без голоса. Если житель сам просит

представлять его близкого — это его выбор представителя, не «место для родни». Иерархия источников воли (раздел 15.9): близкие — четвёртый уровень; совет не переписывает иерархию по громкости голоса.

35. Пилот на 90 дней: минимальный безопасный старт

35.1. Почему 90 дней и почему пилот

«Меняйте всё с понедельника» ломает две вещи. Кухня — поток с жёстким ритмом. Жители ПНИ — люди, для которых предсказуемость среды — часть благополучия (раздел 9). Пилот бережёт обе: меняется одна точка — отделение или приём пищи, — остальное идёт как вчера.

Девяносто дней проявляют статистику выбора (первые две недели — эффект новизны), трудовые издержки и первые конфликты. Усть-Илимск шёл поэтапно: от опроса предпочтений к расширению⁴. Успенский зафиксировал: «страхи персонала не подтвердились» — после пробного периода, не до него³.

35.2. Дни 1–14: подготовка (без изменений на линии)

Неделя 1. Приказ о пилоте (приложение 28): точка, сроки, ответственные, критерии успеха и остановки. Замер «до»: семь дней отходов, времени раздачи, отказов (приложение 25). Без него через 90 дней сравнивать будет нечего.

Неделя 2. Опрос предпочтений в точке (приложение 36): житель или представитель отвечает коротко; ответы — в пищевые карты. Параллельно — инструктаж смены раздачи (раздел 28) и письмо учредителю.

35.3. Дни 15–75: работа пилота

Минимальный пилот — модель М1 из раздела 29: два варианта второго на обед, 2–3 дня в неделю, заказ вечером накануне или на линии. Стандартный вариант гарантирован всегда. Журнал заказа и журнал замен — с первого дня, не «когда наладится».

Еженедельно — пятнадцатиминутная планёрка: что выбирали, где очередь, какие замены, что говорят жители. Три корзины: смена (очередь, маркировка), кухня (пары, объёмы), администрация (документы, закупка). Третья не должна пустовать больше двух недель: иначе пилот выдыхается.

Если в точке есть ночное едение (раздел 13) — структурированный ночной перекус по согласованию с врачом: самая быстрая субъективная победа.

35.4. Дни 76–90: оценка и решение

Двенадцать показателей (приложение 24) «после» против «до»: доля выбирающих, отходы, время раздачи, отказы, замены, жалобы. Число без фразы «что это значит» никому не показывайте (раздел 22).

Совет жителей заслушивает итоги: расширять / оставить точку / свернуть. Протокол — в отчёт учредителю.

Решение директора — одно из трёх, на бумаге: расширение, закрепление точки, свёртывание с причинами. Свёрнутый пилот с причинами — результат, не провал: защищает от следующего «а давайте».

35.4а. Что пилот доказывает, а что нет: дизайн и его границы

Честный дизайн важнее красивого отчёта. Пилот 90 дней проверяет исполнимость и безопасность — не эффект вариативности (раздел 27.5).

«До/после» на одном отделении (20–35 человек, без контроля) показывает: держатся ли два варианта в ритме смены и журналы; не выросли ли отказы и аспирации (на малой выборке важно любое ухудшение); цену сырья, труда и отходов. Не показывает, что именно выбор улучшил отходы, вес, настроение или здоровье: нет ни контрольной группы, ни мощности. Такого исследования в психиатрии не опубликовано (раздел 27.5).

Смещения — вслух. **Хоторн:** ≈2 недели завышены экспериментом; база — до старта, выводы — дни 30–90.

Сезонность: летние отходы не переносить на зиму. **Смены:** одна смена-единомышленник, иначе меряете смену.

Возврат к среднему: плохой «замер до» улучшится сам; база — семь дней, не один «показательный».

Решение — по осуществимости и безопасности. **Успех:** журналы без срывов, выбор на большинстве приёмов, отказы и риск не выросли, труд в смете — «умеем безопасно», не «выбор доказал пользу». **Свернуть:** рост отказов или аспираций либо неподъёмные трудозатраты (35.5). **Неоднозначно:** ещё 60 дней, чинить пары и поток.

Пилот отвечает: безопасно ли и за какую цену. Не «работает ли вариативность».

35.5. Критерии остановки: где линия

Стоп немедленно при трёх сигналах: рост отказов от еды в точке (недоедание важнее любой вариативности — раздел 12); санитарные нарушения новой линии (раздел 18); клинические противопоказания врача. Остальное —

рабочие проблемы: очереди — поток (раздел 20), страхи персонала — инструктаж (раздел 28), «не то выбирают» — пересмотр пар (раздел 19).

Девяносто дней, одна точка, три журнала, двенадцать чисел. Пилот М1 на одном отделении обычно укладывается в текущую смету; полный переход дома может потребовать оборудования и ставок⁵.

35.6. Пилот, который «не пошёл»: разбор четырёх исходов

Не каждый пилот заканчивается расширением.

Тихая смерть: журналы умерли к 60-му дню. Нет владельца ритма: планёрка отменялась «на недельку» четыре раза. Ритм — в приказе с датами.

Бунт кухни: второй вариант невыполним — загрузка плит. Пилот без завпроизводства. Кухня проектирует пары, администрация — рамку.

Фиктивное оживление: журналы полны, жители молчат — предзаполнение (кейс 4). Проверка реальности (приложение 24) с 15-го дня.

Честное свёртывание: рост отказов или неподъёмные трудозатраты; приказ с причинами. Из четырёх — единственный успех управления: система узнала себя без цены здоровьем. Документ защитит от того же эксперимента через два года.

35.7. Масштаб первого пилота: почему меньше — значит быстрее

«Сразу на весь дом» понятно и губительно. Сбой масштаба дома на 300 жителей — сбой системы; в доме-тысячнике тем более. Серафимовский: 1 004 проживающих на февраль 2026, раздел 25.5.

Точка: одно отделение 20–35 жителей, одна смена-единомышленник, один приём пищи. Меньше — проба. Больше — реформа без подстраховки. «Сложный» контингент (группа помощи, неговорящие) предпочтительнее «удобного»: прошедший на сложном масштабируется почти сам; прошедший на удобном ломается о первое сложное отделение — и хоронит тему.

35.8. Первая неделя пилота по дням

Главный риск — импровизация.

День 1: меню вечером, заказ; утром сверка объёмов до варки; на линии — старшая смена; вечером 10 минут. **День 2–3:** очередь у варианта Б, забытые бирки, «стандартные» без спроса — чинить вечером. **День 4–5:** срывы и замены; проверка реальности (приложение 24) — пять вопросов. **Выходные:** линия молчит, журнал нет. **День 7:** планёрка по трём корзинам.

До семи дней данных ничего не отменять и не «улучшать». Первая неделя — базовая линия, не эффект.

35.9. Своя кухня и аутсорсинг: один пилот, две точки входа

Глава 35 — под свою плиту; глава 42 — под спецификацию. Директору с комбинатом нужна таблица, иначе пилот «на линии» начинается в пустоте.

	Своя кухня	Аутсорсинг
Дни 1–14	Приказ, замер «до», опрос, инструктаж, письмо учредителю	То же плюс сверка контракта: строки выбора, замен, проб, отчётности (раздел 42.3)
Что меняется	Вторая гастрорёмкость и журнал на линии	Поставка двух вариантов и журнал замен поставщика; линия принимает, не готовит
Если контракта ещё нет	Старт с понедельника	Сначала восемь строк в ТЗ (календарь — раздел 42.7); пилот без строк — декорация
Если контракт уже идёт	—	Допсоглашение или претензия по приёмке; не «попросить поваров комбината»
Стоп-сигналы	Рост отказов, санитарные нарушения, противопоказание врача	Плюс срыв поставки варианта Б и отсутствие суточных проб у учреждения
Понедельник без разрешения	Замер и журнал отказов	Замер, журнал и фото линии без лиц; ТЗ — в график закупки, не в пожелания

Публичных кейсов вариативности на аутсорсинге нет. Таблица переносит инструменты доклада, не чужой измеренный опыт. Критерии остановки те же (раздел 35.5): здоровье жителей важнее любой модели кухни.

36. Дорожная карта на 12 месяцев: от пилота к системе

36.1. Логика карты

Каждый квартал — самостоятельная ценность: остановились — остаётся работающий результат, не недостроенная схема. Сроки — ориентир для дома среднего размера. На 289 мест (средняя расчётная вместимость ПНИ по вторичной аналитике⁷) темп реалистичен; малым — быстрее, многокорпусным — медленнее. Карта — рекомендация, не норматив.

36.2. Квартал 1 (месяцы 1–3): безопасный фундамент

Параллельно с пилотом (раздел 35): аудит по 24 точкам (раздел 22, чек-листы приложений 18–21); документальный комплект (раздел 31); инструктажи трёх уровней (раздел 28); лекарственно-пищевая таблица и список дисфагического риска — подписаны врачом. **Результат:** пилот работает, замеры есть, клинические риски под документами. Можно остановиться — уже лучше исходной точки.

36.3. Квартал 2 (месяцы 4–6): расширение по горизонтали

Выбор идёт на все приёмы в точке или на соседнее отделение — по готовности смен, не по желанию администрации. Меню пересчитывается по статистике выбора (раздел 21); пары правятся. Запуск совета жителей (раздел 34), если не запущен раньше. **Результат:** вариативность — ежедневная практика в одном-двух отделениях, совет с протоколами.

36.4. Квартал 3 (месяцы 7–9): структурные элементы

Буфетная зона (модель М3) там, где позволяют контингент и санитарный контур; семейная подача (М4) точно в группах помощи; закупки — спецификации под парные позиции (раздел 30). Первый квартальный отчёт учредителю с панелью чисел. **Результат:** система затронула закупки и пространство, не только линию. Точка невозврата пройдена.

36.5. Квартал 4 (месяцы 10–12): масштабирование и закрепление

Решение о масштабе на всю организацию — по данным трёх кварталов. Положение о питании обновляется целиком; годовой отчёт учредителю; обмен опытом — региональная площадка, семинар, публикация по образцу тех, кто уже рассказал открыто^{3, 4, 6}. **Результат года:** вариативность — норма дома: документированная, измеренная, защищённая перед проверкой.

36.6. Три типовых сбоя и их профилактика

«Пилот застрял». Точка работает год без расширения: нет решения по итогам 90 дней. Дата решения — в приказе, в день подписания.

«Ключевой человек ушёл». Практика на одном заведующем. Комплект и ротация: практика переживает людей (раздел 31).

«Учредитель молчит». Просите конкретику: перечень, форму отчёта, дату заслушивания. Молчание — риск раздела 32; снимать до масштабирования.

Каждый квартал — документ и число. Бумага переживает энтузиазм.

36.7. Карта при нехватке: три ветки обеднённого сценария

Базовая карта — дефолтные ресурсы. Честность требует веток.

Нет второй гастрорёмкости (кейс 22): год — предзаказ и буфет. Лестница — «максимум для этой инфраструктуры», не маска полной вариативности. Реконструкция — отдельной повесткой ежегодно.

Нет ставок на помощь (кейс 21): самостоятельность и приоритет риска; трудозатраты — в запросы ежеквартально; вариативность — позиции без дополнительной помощи.

Учредитель против: замеры и документы без смены линии; база — на следующий цикл; региональная группа семинара — внешний аргумент (раздел 40).

Обеднённый сценарий — другой маршрут, не урезанный базовый. Отличие — темп.

36.8. Как карта умирает: предупреждение по датам

Смерть карты по расписанию. Квартал 1 — молча: пилот «не дошёл». Квартал 2 — громко: конфликт с учредителем, тема «до лучших времён». Кварталы 3–4 — тихо: «и так сойдёт».

Предохранители. Первый — публичный старт: приказ с датами читает коллектив. Второй — ответы раздела 38 и региональная группа. Третий — победа квартала вслух: совету — число, коллективу — результат. Без предохранителей карта — пожелание.

37. Четырнадцать возражений и честные ответы на них

37.1. Как устроен раздел

Возражение — в редакции, близкой к тому, как его произносят. Издёвки нет: в большинстве есть рациональное ядро. Где данных нет — сказано прямо.

1. «Наши жители не способны выбирать». Часть жителей не выбирает вербально. Выбор — каналы, не анкета: показ, наблюдение, биография, близкие (раздел 15). Австралийский Стандарт 6 с 01.11.2025 требует учитывать предпочтения независимо от когнитивного статуса³⁷. Где и наблюдение молчит — стандартный вариант: выбирать, чтобы поесть, не обязательно.

2. «Будут очереди и хаос на раздаче». Время выбора реально. Поток решается конструкцией: заказ накануне, визуальное меню до линии, маркировка (раздел 20). Успенский опыт: «страхи не подтвердились»³. Замер времени «до/после» покажет вашу правду.

3. «Это дорого». Неизвестно, пока не замерено. Сырьевая строка при парных эквивалентах близка к нулю (раздел 29), труд растёт на минуты, отходы могут падать. «Вариативность бесплатна» — недоказанное утверждение, и я его не повторяю. Семь дней замера отвечают точнее дискуссии.

4. «Санэпид не разрешит». СанПиН 3590-20 (с 01.09.2026 — 4282-26) регулирует поточность, температуру, пробы — не число вариантов¹². Вторая гастрорёмкость — тот же контур, одна точка маркировки (раздел 18). Замечание санврача — конкретика, не фольклор.

5. «У нас нет диетолога». Правда для большинства домов — и не препятствие. Пары строятся по нутриентной логике меню-раскладки (раздел 19), клинику решает врач. Диетолог ускоряет; его отсутствие не отменяет ни нормы, ни практику внедривших^{3,4}.

6. «Жители будут выбирать нездоровое». Пара эквивалентов — выбор внутри нормы, не между нормой и вредом (раздел 19). «Гречка или рис» не создаёт свободы «гречка или конфеты». Пределы задаёт меню.

7. «А если выбрал, а потом отказался?» Журнал, альтернатива, фиксация (разделы 12, 19). Норма об альтернативе при отказе — федеральная в США³⁸; у нас — выводимая из ст. 37/43 с документированием¹¹. Эпизоды неизбежны; неизбежность — предмет журнала.

8. «Лечебное питание несовместимо с выбором». Совместимо через «мост»: региональные акты связывают СОСО с системой диет (распоряжение 19РВ-32 в ДДСОЛ)²⁵, внутри диеты тоже есть пары. Диета ограничивает множество, не сжимает его до одного элемента.

9. «Персонал против». Против обычно не выбор, а непонятная надбавка к работе. Инструктаж по трём уровням, роли в приказе, ритм планёрок. Персонал проектирует линию, а не узнаёт о ней из приказа (раздел 28).

10. «Проверка спросит — что ответим?» Документом. Раздел 32 — три типовых вопроса и три документальных ответа. Страх проверки лечится комплектом, не отказом от практики.

11. «Это всё для маленьких прогрессивных домов, у нас 400 мест». Практики внедрены в ПНИ стандартной вместимости^{3,4}; Иркутская область масштабировала модель регионально⁶. Масштаб меняет логику (поточность, заказ накануне), не принцип.

12. «Зачем, если и так нормально?» «Нормально» чьими мерками? Семидневный замер отходов и журнал отказов за неделю покажут. Если после замера всё подтвердится — доклад дал инструмент проверки, не только изменений.

13. «Кухня не своя — нам не из чего выбирать». Без своей плиты директор меняет спецификацию, не «добавляет кастрюлю». Вариативность на аутсорсинге — восемь строк контракта (раздел 42). Контракт идёт без строк — пилот с допсоглашения и приёмки. Контракт впереди — осенний календарь (раздел 42.7). Публичных кейсов на аутсорсинге нет — пробел, не невозможность.

14. «Через четыре дня новый СанПиН — не время экспериментировать». 01.09.2026 4282-26 вступает целиком, перехода нет¹². Меняются формы бракеража и привязка ППК, не запрет числа вариантов. Журналы августа не переписывать; с 1 сентября — новые формы (раздел 18.10, приложение 39). Обе редакции выбор допускают. Проверка в сентябре смотрит сентябрь по новым правилам, август — по старым.

Двенадцать возражений снимаются документами, замерами, линией. 13-е — спецификацией. 14-е — чек-листом 1 сентября. «Зачем» — только своими данными. Начните с замера.

37.2. Риторика спора: как не проиграть правое дело

Три приёма губят аргумент в зале.

Моральное превосходство: «достоинство» в ответ на вопрос о деньгах. Зал слышит: «денег нет». Сначала механика (замер, пары, поток), потом смысл.

Зарубежный аргумент без фильтра: «в Онтарио диетолог 30 минут на жителя». Зал слышит чужие деньги. Подача: «время специалиста нормируется; минуты считаем сами».

Обещание результата: «отходы упадут на треть». Не упадут у слушателя — тема мертва. Замена: «замер покажет вашу цифру; вот дома, где после выбора замеряли»³.

Принцип + метод проверки + чужой измеренный факт. Веры не требует.

37.3. Возражение–лакмус: «а сами бы вы так ели?»

Самое короткое — тест на честность. Оправдания («для жителей нормально») — признание двух сортов. Процедура: руководство пробует еду с линии (тарелка, не папка), совет дегустирует, дегустации в протоколе. Кто не ел свою еду в этом месяце, спорить о качестве не вправе — обязан пойти и поесть. Ноль рублей. Чек-лист директора (приложение 18) — одна строка.

38. Десять вопросов учредителю: повестка для разговора наверх

38.1. Зачем этот список

Большинство решений в СОСО упираются не в закон, а в региональный контур: статус норм, меню, формы учёта, финансирование (раздел 24). Директор спрашивает «можно ли нам» и получает «не надо». Десять вопросов превращают разговор из просьбы в инженерную задачу. На каждый можно ответить документом.

38.2. Вопросы о нормах и документах

1. **Каков статус рекомендованных норм Минтруда (приказ 520н) в нашем регионе** — рекомендация или основа императивного регионального норматива?³² От ответа — свобода манёвра по парам эквивалентов (раздел 19).
2. **Утверждено ли в регионе собственное перспективное меню для СОСО — и какова процедура внесения изменений?** При императивном меню вариативность начинается с документа, не с линии (раздел 24).
3. **Есть ли акт, связывающий СОСО с системой лечебного питания** (образец — распоряжение 19РВ-32)²⁵? Если нет — готов ли учредитель инициировать его или санкционировать локальный «мост»?
4. **Какая форма учёта продуктов признаётся актуальной** — с учётом перехода на электронные формы по приказам Минфина¹⁰⁹ — и допускает ли она журналы заказа и замен как приложения?

38.3. Вопросы о финансах и закупках

5. **Как устроена сырьевая строка нашего финансирования** — и можем ли публиковать её внутри системы (учредителю и совету жителей) по итогам квартала? Прозрачность строки работает на её адекватность^{94,104}.
6. **Допускает ли действующий контракт (или типовая документация) парные позиции и закупку по статистике выбора** — или спецификации придётся менять при следующей закупке (разделы 30 и 42.7)?
7. **Как в регионе относятся к аутсорсингу питания — и если он у нас, включает ли контракт вариативность, текстуру и документирование замен?** Без этих строк подрядчику уходят не только кухня, но и права жителей (разделы 30 и 42).

38.4. Вопросы о полномочиях и развитии

8. **Согласен ли учредитель на пилот по модели раздела 35** — одна точка, 90 дней, панель чисел — с заранее оговорённой датой заслушивания? Просьба с датой — просьба о решении, не о благословении; на неё легче ответить «да».
9. **Готов ли регион к обмену практиками** — и поддержит ли публичный рассказ о нашем опыте по образцу уже опубликовавших^{3,4,6}? Рассказанное труднее тихо отменить.
10. **Что учредитель считает показателями качества питания** — и готов ли включить долю выбирающих и уровень отходов? Вопрос переводит вариативность из «инициативы директора» в «показатель системы».

38.5. Как вести сам разговор

Три правила. Вопросу — одностраничная справка (приложение 33). Первая повестка — 1, 2 и 8. Ответы письменно, хотя бы служебной запиской: позиция учредителя — половина защиты (раздел 32).

У учредителя есть то, чего нет у директора: право менять региональные документы. Десять вопросов — дать ему эту работу.

38.6. Если ответ «нет»: три уровня отказа и работа с каждым

Отказ — диагностика.

Ресурс («нет денег»): список нулевой стоимости и замеры; деньги — под цифры.

Риск («накажут»): документы раздела 32; старт без смены линии — замеры, карты, совет.

Статус («не положено»): ссылка на норму. Часто нормы нет — и это уже «не принято», разговор о решении.

Отказ — письменно. Через год рамка сменится; устный растворится. Одно «нет» не закрывает остальные девять.

38.7. Когда учредитель — союзник: как не потерять его

Союзник — ресурс со сроком годности: ротации, приоритеты. Отчёт — числами, не активностью. Роль — публично, по образцу внедривших^{3,4}. Риск — с защитой, не голый. Числа, роль, безопасность держат дольше ротации.

39. Предложения отрасли: что должно измениться выше уровня учреждения

39.1. Граница раздела

Предыдущее — что организация может сделать сама, в действующем поле. Этот раздел — что ей мешает и что решается только на региональном и федеральном уровнях. Предложения — повестка для обсуждения, в том числе на семинаре, не готовые законопроекты. Нормотворческое конструирование — за пределами доклада.

39.2. Пять федеральных предложений

1. Закрепить минимальный стандарт выбора в рекомендованных нормах. Приказ 520н³² задаёт нутриентные рамки. Международные системы закрепляют ещё и структуру выбора: два и более вариантов основных блюд — Онтарио²⁶, альтернатива при отказе — США³⁸, «что, когда, где и как я ем» — Австралия³⁷. Формула: в нормы — не меню, а принцип «не менее двух вариантов основной позиции там, где технологически возможно».

2. Урегулировать стык СОСО и лечебного питания. Приказы Минздрава адресованы медицинским организациям; СОСО — в серой зоне (раздел 17). Варианты — совместный акт Минтруда и Минздрава или типовой региональный «мост»²⁵. Пока стык не урегулирован, каждая организация решает клинику на свой страх и риск.

3. Два показателя в отраслевую отчётность: доля жителей, участвующих в выборе, и уровень пищевых отходов. Оба измеримы дёшево (приложения 24–25). Что измеряется наверху, то организуется внизу.

4. Снять неопределённость с формами учёта. Переход на электронные формы (приказы 61н, 142н, 100н, 157н, 174н)¹⁰⁹ порождает на местах: «всё меняется, лучше не начинать». Нужна справка: какие формы у СОСО сейчас и какие — после каждого этапа.

5. Поддержать публикацию практик. Внедрившие существуют^{3,4,6}, но опыт идёт через новостные ленты, не через методические каналы. Сборники с документальными приложениями сократили бы цикл с лет до месяцев.

39.3. Пять региональных предложений

6. Установить статус рекомендованных норм — одним абзацем: рекомендация или императив. Неопределённость — главный тормоз (раздел 24).

7. При императивном меню — процедуру его изменения с участием организаций: кто инициирует, какие обоснования, какие сроки.

8. Региональный «мост» к лечебному питанию там, где его нет, — по готовому образцу²⁵.

9. Требования к вариативности и документированию — в типовые документы закупок и аутсорсинговых контрактов (разделы 30 и 42). Без этих строк права жителей — добрая воля подрядчика.

10. Региональная площадка обмена — ежегодный семинар или рабочая группа с публикацией. Иркутский опыт: региональное решение масштабирует быстрее усилий отдельных домов⁶.

39.4. Чего доклад не предлагает

Три умолчания. Новый закон о питании в СОСО не нужен: рамка (3185-1, СанПиН, 520н)^{11, 12, 32} уже позволяет главное; проблема — статусы и стыки. Обязательная вариативность без перехода не предлагается: нет кухни или смены — получится фикция (раздел 21). Числовых нормативов стоимости нет: публичных данных о сырьевой строке российских СОСО нет, норматив на пустоте — выдумка.

Десять предложений директора формулируют вместе. Семинар — место согласования; раздел 40 — как организовать.

39.5. Как предложения становятся нормами: японский таймлайн как учебный

Япония^{98, 100}: три фазы. 1 — надбавка за добровольность, авангард. 2 — национальная база, язык цифр. 3 — обязательность, когда отрасль умеет.

Мы между 1 и 2: авангард есть^{2, 3, 4}, данных нет. Запрос вверх — «считайте», не «разрешите» и не «обязайте». Два показателя (предложение 3) запускают фазу 2 без рубля и риска.

39.6. Роль профессионального сообщества

Предложения 6–10 делают регионы, иницируют директора: они знают, где стык болит. Минимум: рабочая группа при ассоциации, ежегодный сбор практик, банк форм (приложения — первый взнос). Стоимость организационная. Методический дефицит закрывается так.

40. Организационные предложения семинару

Семинар — не глава внедрения. Сценарий трёх дней, малые группы, вопросы залу и предложения площадке — в семинарском пакете: уникальность состава, пять предложений по формату, чего не делать, инфраструктура после, конструкция трёх дней, подписка об общем замере.

Кто собирает зал — открывает пакет. Кто внедряет — разделы 35–39 и 41–43.

41. Заявление о достоверности: что в этом докладе на чём стоит

41.1. Зачем этот раздел

Предыдущие версии содержали утверждения без источников, заимствованные цифры и оценки, выдававшиеся за факты. Этот раздел — публичная отчётность: какие классы утверждений есть, как каждый подтверждён, где читатель может поймать автора.

41.2. Классы утверждений и их подтверждение

Нормы права. Каждая ссылка на акт — с реквизитами и привязкой к реестру (раздел 44: **34 записи**, маркеры S001–S035 без S026). Дата актуальности реестров — **23.07.2026**; правовая сверка — **19–21.08.2026**. Для каждого акта указано, что он подтверждает. Не все позиции — публичный первоисточник: часть — внутренние документы, вторичные пересказы или требует повторной проверки редакции. Приказ 940н из ранних материалов не подтверждён — исключён, не оставлен «на всякий случай».

Клинические данные. Числа о лекарственных взаимодействиях, дисфагии, метаболических эффектах и реабилитации — к реестру (раздел 44, **48 записей**: систематические обзоры, мета-анализы, руководства IDDSI и обществ, клинические случаи). Где доказательства сильны (клозапин — кофеин¹⁸, литий — соль¹⁹), где ограничены (частота отдельных паттернов пищевого поведения), где отсутствуют: рандомизированных исследований вариативного меню в психиатрии не найдено — раздел 27.

Международные нормы. Девять зарубежных систем — реестр (раздел 44, **44 записи**) с актом, пунктом и датой вступления там, где она значима (австралийский Стандарт 6 — с 01.11.2025³⁷). Перенос на российскую почву — рекомендация или ориентир, не обязанность.

Российская статистика. Числа о системе ПНИ — вторичная аналитика «Если быть точным»: данные за **2024 год**, публикация 09.04.2026⁷. Не статотчётность Минтруда и не исследование ТАСС; информагентства пересказывали. Где независимого подтверждения нет — сказано прямо.

Российские практики. Каждая — публичный первоисточник с датой^{2, 3, 4, 6, 25, 5}. «Мало», «растёт» — интерпретация открытого поиска, не репрезентативного обследования: такого обследования не существует.

Числовые примеры и расчёты. Модельные вычисления помечены как иллюстративные, с допущениями. Формула «вариативность почти бесплатна» удалена как недоказанная; вместо неё — порядок замера.

Четыре категории доступности нельзя смешивать под словом «верифицировано»: **публичный первоисточник, внутренний документ, вторичная публикация, требует перепроверки.**

41.3. Что доклад не знает (честный список пробелов)

Репрезентативной статистики вариативного питания в российских СОСО нет. Рандомизированных исследований эффекта вариативности в психиатрических стационарах не найдено. Судебной практики о вариативном меню не обнаружено. Данных о сырьевой строке российских СОСО в публичном поле нет. Статус норм в каждом из 51 региона не проверен индивидуально: методика — раздел 24, проверка — работа региональных групп (раздел 40). Пробелы — карта того, где читатель обязан включать собственную проверку.

41.4. Как проверить авторов

Два способа. Первый: раздел 44 — каждое утверждение имеет маркер, каждый маркер — строку списка. Второй: утверждение без маркера или маркер без строки — ошибка автора, не недоразумение читателя. Достоверность — не обещание «мы не ошибались», а конструкция «вы можете нас поймать».

41.5. Известные уязвимости этой версии

Датировка. Реестры — 23.07.2026; сверка — 19–21.08.2026. Нормы, особенно региональные и формы учёта¹⁰⁹, меняются: перед приказом проверять заново. СанПиН 2.3/2.4.4282-26 утверждён 02.06.2026, вступает 01.09.2026 — через несколько дней после семинара. Переход от 3590-20 зафиксирован; локальные акты перепривязывать самим.

Языковая асимметрия. Международные тексты читались по-английски; немецкие и шведские нюансы могли сгладиться переводом.

Отбор практик. Шесть российских — открытый поиск; одна — дом докладчика (кейс 25.5, конфликт интересов раскрыт). Без публикаций в доклад не попали.

Собирательные кейсы. Кейсы 1–22 — типовые механизмы: правдивы по логике, условны по фактуре.

Авторская позиция. Где доказательств нет, доклад занимает сторону (приоритет зафиксированной воли, «учреждение = опекун»). Аргументировано, но позиция; границы — раздел 16.

Пять уязвимостей правит не редакция, а новые данные — те, что соберёт зал (раздел 40).

42. Аутсорсинг питания: контракт как место вариативности

42.1. Почему это раздел доклада

Питание всё чаще даёт не свой пищеблок, а комбинат, фабрика-кухня, готовые блюда и чужие повара¹¹⁰. Для директора это смена модели: контракт решает, что едят жители. Санитарная рамка не зависит от того, кто у плиты¹¹⁰.

Кейсов вариативного меню на аутсорсинге в открытых источниках нет — пробел. Раздел переносит инструменты глав 19–22 и 30 в контракт. Задача — вписать выбор и проверять аутсорсера, не превращая дом в «приёмный пункт тарелок».

42.2. Правовая рамка: кто за что отвечает

Закупка услуг питания для казённых и бюджетных — как правило, 44-ФЗ (ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ)¹¹¹. Для автономных режим может быть 223-ФЗ при наличии положения о закупке: оговорка раздела 30.1, не формула «всем 44-ФЗ».

Я веду Серафимовский по 223-ФЗ. Тимур Нурбаев ведёт «Тесовый берег» по 44-ФЗ. Кухни и законы не путать. Свежий пример его контура — извещение № 0372200070825000244, открытый конкурс «Поставка продуктов питания» СПб ГБУСОН «ДСО „Тесовый берег“» (ИНН 7827661874), обеспечение заявки по ст. 45 44-ФЗ, опубликовано 24.11.2025, площадка АГЗ РТ¹¹².

Санитарная рамка не «уезжает» с кухней. СанПиН 2.3/2.4.4282-26 прямо регулирует привлечённые предприятия. П. 56 подп. 12: при готовых блюдах из общепита в стационаре СОСО выделяется помещение для приёма продукции и отбора суточных проб; пробы отбирает работник пищеблока учреждения по подп. 4 п. 56 (каждое блюдо отдельно; холодные закуски / первые / гарниры / напитки — не менее 100 г; хранение не менее 48 часов при +2...+6 °С)¹². П. 56 подп. 14: требования пункта — на предприятия, привлекаемые для питания стационара¹². Раздел VI (кейтеринг): внутренний порядок прослеживаемости изготовления, перевозки, хранения и реализации и разграничения ответственности; вскрытие упаковок и порционирование — в выделенной зоне в месте услуги¹². До 01.09.2026 — аналогичная рамка СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (п. 7.1.11–7.1.14, раздел VI)¹².

Суточные пробы, бракераж и температура можно делегировать исполнением, не ответственностью. Перед жителями и проверяющими отвечает учреждение.

42.3. Восемь строк контракта, которые делают вариативность реальной

Развитие раздела 30 для аутсорсинга.

1. Перечень как группы взаимозаменяемых («крупы гарнирные: гречка, рис, пшено»), не монопозиция — пары на уровне контракта.

2. Пропорции по статистике выбора с правом корректировки раз в квартал без изменения сути контракта.

3. Строка выбора: где заявлена вариативность — не менее двух вариантов основных позиций; срыв фиксируется в журнале замен и не считается исполнением.

4. Строка замен: при недопоставке — эквивалент из той же группы по согласованию, с актом.

5. Строка качества: характеристики для текстур (помол, консистенция полуфабрикатов) — иначе дисфагический контур становится заложником «самого дешёвого фарша» (раздел 10).

6. Строка приёмки: ответственный от учреждения, форма акта, место и процедура суточных проб по п. 56 подп. 12¹².

7. Строка состава: меню-цикл с раскладкой и массой порций — приложение к контракту; сверка с нормами 520н³².

8. Строка отчётности: доля выбора и остатки по блюдам — ежемесячно; данные для панели раздела 22.

Каждая строка — с контрактной службой заранее. Конфликт «меню против контракта» — симптом: меню меняли, спецификацию нет.

Чего нельзя отдать строкой ТЗ. Исполнение — да, ответственность — нет. Пробы отбирает работник учреждения (п. 56 подп. 12 и 4)¹²; бракераж приёмки — акт учреждения; дисфагия и текстуры — у врача и поста; эскалация отказа (раздел 12) — маршрут дома. Поставщик готовит и везёт. Учреждение решает, что безопасно сегодня.

42.4. Как проверять аутсорсера без «кухонной войны»

Замер остатков (приложение 25). **Внезапный контроль линии:** температура по п. 50 СанПиН 4282-26¹², соответствие заказанного выданному, стандартный вариант (раздел 21). **Суточные пробы:** наличие, маркировка, объём, срок. **Фото линии** без лиц жителей; здоровье — 152-ФЗ (раздел 17.6). **Раз в квартал — панель** с поставщиком: отходы, жалобы, доля выбора.

Кейсы 14 и 22 переносятся один в один. Ст. 6.6 КоАП¹³ и практика ФАС⁷⁸ никуда не делась.

Учредитель уже написал, как держать поставщика. Письмо Комитета (председатель Е. Н. Фидрикова): ст. 34, 94, 95 44-ФЗ; ежедневный мониторинг, акты, претензии, одностороннее расторжение, РНП¹³. Позиция учредителя в контуре 44-ФЗ, не пожелание директора.

42.5. Экономика: почему «дешевле отдать на сторону» — не всегда правда

Полная стоимость приёма в 3–6 раз выше сырьевой строки (раздел 29, канадский аудит)⁵⁹. Аутсорсер режет сырьё — видимую и малую часть. Контракт фиксирует состав: меню-цикл, массу порций, соответствие 520н³². Британские стандарты обязательны и для контрактников¹¹⁴; нормы Онтарио — независимо от способа обеспечения²⁶. Экономия — построчками, не «общей цифрой».

Аутсорсинг — новое место вариативности: спецификация, приёмка, отчётность. Пары, замер, журналы, пробы — в контракт, раздел 42.3. Контроль качества — исполнением, не ответственностью. Нет строк выбора и проб — вариативность невозможна.

42.7. Осенний календарь: когда править ТЗ

Выбор вне ближайшей закупки откладывается на весь срок контракта. Даты свои, логика одна.

Сентябрь. Новый СанПиН не стоп выбора (раздел 18.10). Замер и журнал — числа для спецификации.

Октябрь. Восемь строк 42.3 — с контрактной службой; пробы, бракераж, дисфагия, эскалация отказа остаются у учреждения.

Ноябрь–декабрь. Контракт кончается в первом полугодии — строки в документации сейчас. Длинный контракт без строк — допсоглашение, не «переторжка».

Январь. Пилот по таблице 35.9: своя линия или два варианта от поставщика. Без осеннего окна замер можно — обещать выбор в договоре нельзя.

Деньги — раздел 29, процедура — 30, контракт — этот.

43. Заключение: что остаётся после последней страницы

43.1. Суть доклада в пяти предложениях

Питание в стационаре — не услуга рядом с заботой. Это ежедневный тест на уважение: система сдаёт его или проваливает три-четыре раза в день. Правовое поле позволяет организовать выбор уже сегодня: нормы есть, серые зоны обозначимы, процедуры описаны. Практика работает — в Успенском, Усть-Илимске, Серафимовском^{7, 4, 5} и в регионе, масштабировавшем её решением области⁶. Если кухня не своя, то же самое начинается со спецификации (раздел 42). Доказательная база разной плотности: по клинике и международным нормам сильна, по эффекту вариативности в психиатрии — почти пуста. Последнее слово — не «внедряйте», а «измеряйте»: семь дней замера отделяют убеждение от знания.

43.2. Три образа, с которых начинался разговор

В разделе 5 обед собрал пять конфликтов за одним столом: женщина, которой нужно молчание вместо зала; мужчина, чей кофеин и клозапин конфликтуют без ведома кухни¹⁸; житель, чья дисфагия пока видна только внимательной сиделке¹; человек без слов, чьё «не хочу» система не умеет услышать; смена, которая делает «как всегда», потому что это единственный доступный сценарий. Теперь у каждого — процедура: тихая зона (раздел 20), лекарственно-пищевая таблица (раздел 11), список риска и текстуры (раздел 10), четыре канала воли (раздел 15), комплект документов и роли (разделы 28, 31). Конфликты не исчезнут. Они перестанут быть безымянными.

43.3. Что изменится для четырёх людей

Для жителя — еда перестает быть тем, что с ним происходит, и становится тем, в чём он участвует: называет, показывает, выбирает, отказывается. Отказ не превращается в голод: есть задокументированная альтернатива.

Для сиделки — «покормить» сменяется работой с опорами: карта жителя, таблица текстур, правило трёх отказов.

Для директора — питание выходит из тумана («придут — спросят») в управляемую систему: приказ, журналы, панель чисел, дата заслушивания у учредителя.

Для учредителя — работа, которую только он может сделать: статусы норм, «мост» к лечебному питанию, показатели отрасли (раздел 39).

43.4. Первый шаг

Доклад можно закрыть и начать. Первый шаг — неделя без разрешений: замер отходов, отказов, времени раздачи (приложение 25). Кто уезжает 27 августа: 1 сентября журналы не переписываются, новые формы бракеража — с утра (приложение 39). Дальше — знание о доме, не мнение. Из него растут пилот, совет, разговор с учредителем — и через год рассказ, которому зал поверит: за ним ваши числа.

Человек за столом ждёт обеда, в котором есть его выбор. Теперь вы знаете, как такой обед организовать.

43.5. Письмо директору через год

Прошёл год. Два сценария.

А. Доклад на полке. Изменилось одно: вы знаете, что у коллег работает, и жалоба на еду читается иначе.

Б. Неделя замера, совет, пилот в одном отделении; панель у учредителя; два варианта второго — как водопровод.

Разница — не деньги (пилот М1 дешевле ремонтного дня), не разрешения, не люди. Разница — первая неделя. Она дешевле года сомнений. Дальше — ваши числа и жители, которые скажут, какая каша — их. Разговор начался в зале. Продолжение — за линией раздачи, в понедельник, 8:30.

44. Библиография и источники

Сто двадцать шесть источников. Тридцать четыре российских правовых и практических (S001–S035 без S026), сорок восемь клинических, сорок четыре международных. Дата актуальности реестров — **23.07.2026**; правовая сверка — **19–21.08.2026**. Как читать классы утверждений — раздел 41.

В тексте доклада источник стоит маркером в месте первого упоминания; повтор указывает на тот же номер. Ниже — полный раскрытый список: **номер строки не равен номеру сноски**, в первой колонке — ID реестра. Пробелы списка названы прямо: часть позиций — внутренние документы или вторичные пересказы; практики S015–S019 и S030 — публикации учреждений, не аудит; S022 — единственное публично доступное судебное толкование по пищевым делам в СОСО; S013 и S014 — закупочная дисциплина, не обоснование выбора; S012 — качество и достаточность питания, не «дело о вариативности».

44.1. Российские правовые и практические источники (S) — 34

ID	Что	Где / URL	Проверено
S001	ФЗ № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ», ст. 9, 16, 17, 31, 32	https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/	Госдума — 23.07.2026
S002	Приказ Минтруда России от 13.09.2022 № 520н «Об утверждении рекомендуемых норм питания...»	https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405607433/	Минтруд России — 23.07.2026

ID	Что	Где / URL	Проверено
S003	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (пост. ГГСВ РФ от 27.10.2020 № 32), п. 7.1.11–7.1.14 — до 01.09.2026; СанПиН 2.3/2.4.4282-26 (пост. ГГСВ РФ от 02.06.2026 № 18, зарег. в Минюсте 02.06.2026 № 86854), п. 56 подп. 11–14 (СОСО, раздел VII), п. 62 (питьевой режим), раздел VI (кейтеринг)	https://rovenkiadm.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/SanPiN_2.4.4282-26.pdf	Роспотребнадзор — 17.08.2026
S004	Исследование «Если быть точным»: «Как устроены ПНИ в России» (09.04.2026)	https://tochno.st/materials/kak-ustroeny-pni-v-rossii-issledovanie-esli-byt-tocnym	проект «Если быть точным» — 23.07.2026
S005	Ведомости: «Психоневрологических интернатов за три года стало на 13% меньше» (10.04.2026)	https://www.vedomosti.ru/society/articles/2026/04/10/1189295-psihonevrologicheskikh-internatov-stalo-menshe	Ведомости — 23.07.2026
S006	Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н: статус на 2026 г.	https://base.garant.ru/58070703/	Минфин России — 23.07.2026
S007	Страница семинара на сайте Минтруда: mintrud.gov.ru/events/1481	https://mintrud.gov.ru/events/1481	Минтруд России — 23.07.2026
S008	Постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 607-п (нормы питания), актуальная ред.	https://ctonus.ru/f/normy_pitaniya.docx	Правительство Красноярского края — 23.07.2026
S009	Ст. 31 442-ФЗ + ПП РФ № 1075 (расчёт среднедушевого дохода)	https://www.consultant.ru/law/podborki/plata_za_stacionarnoe_socialnoe_obslyuzhivanie/	Правительство РФ — 23.07.2026
S010	Письмо Минтруда о семинаре + список участников (приложения пользователя)	—	Минтруд России — 23.07.2026
S011	Закон РФ № 3185-1 «О психиатрической помощи...», ст. 37, 39, 43, 44	https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4205/	ВС РФ — 23.07.2026
S012	Прокуратура: проверки питания в соцучреждениях, дела по ст. 6.6 КоАП (Кашин СРЦ 2022; Зеленогорск 2021; представление 19.03.2024 soc13.ru)	https://www.kashin.info/prokuratura-informiruet/novosti-prokuratury/9121	прокуратуры районов — 23.07.2026
S013	ФАС: картель на торгах поставки соц. значимых продуктов, 543 торга, 4,7 млрд руб. (25.07.2024, РГ)	https://rg.ru/2024/07/25/fas-raskryla-kartel-na-torgah-na-postavku-socialno-znachimyh-produktov.html	ФАС России — 23.07.2026
S014	ФАС/ФСБ: картель на школьном питании Челябинск, 27 тендеров 2022–2024, штраф 5,1 млн (01.08.2025)	https://www.pro-goszakaz.ru/news/116068	УФАС Челябинской обл. — 23.07.2026
S015	ГАУССО НСО «Болотнинский ПНИ»: «Вариативное питание» (16.08.2024)	https://bpni.nso.ru/news/2312	Болотнинский ПНИ — 23.07.2026
S016	ГАУССО НСО «Успенский ПНИ»: вариативное меню во всех отделениях (13.08.2024)	https://upni.nso.ru/news/1916	Успенский ПНИ — 23.07.2026
S017	ОГБУСО «Усть-Илимский дом социального обслуживания»: «Что за зверь такой? Вариативное питание» (27.09.2024)	https://ui-ogbuso.ru/novosti/	Усть-Илимский ДСО — 23.07.2026
S018	Иркутская область: вариативное питание в стационарных учреждениях — выбор из двух первых, вторых и гарниров (14.02.2025)	https://irkutsk.bezformata.com/listnews/variativnoe/142531226/	минсоцразвития ИО (пересказ bezformata) — 23.07.2026
S019	ДДСОЛ (Московская обл.): 14-дневное вариативное меню, совет по питанию, замены по желанию жителей с врачом	https://ddsol.ru/about/pitanie/	ДДСОЛ — 23.07.2026

ID	Что	Где / URL	Проверено
S020	Постановление Правительства Москвы № 1068-ПП (нормы питания в стационарных организациях)	—	Правительство Москвы — 23.07.2026
S021	Постановление адм. Псковской обл. № 206; постановление Правительства Красноярского края № 607-п; пост. Правительства Ленобласти № 458; пост. Правительства ХМАО № 306-п	—	органы субъектов — 23.07.2026
S022	Постановление ВС РФ от 21.02.2019 № 11-АД19-4 (переквалификация 6.6→6.7 КоАП)	https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72095418/	Верховный Суд РФ — 23.07.2026
S023	ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/	Госдума — 23.07.2026
S024	Лозовская С.О. «Правосубъектность лиц, признанных недееспособными и ограниченно дееспособными вследствие психического расстройства»	https://vestnik.msa.ru/jour/article/view/2058	Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023, № 5, с. 139–146 — 23.07.2026
S025	«Кейтеринг в организациях социального обслуживания» (отраслевое издание, 2022)	https://www.profiz.ru/sec/4_2022/Kejtinger/	Профиздат — 23.07.2026
S027	СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (пост. ГГСВ РФ от 28.09.2020 № 28, зарег. в Минюсте 18.12.2020 № 61573)	https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/	Роспотребнадзор — 23.07.2026
S028	Письмо Минтруда России от 21.04.2020 № 26-4/10/В-3076: методические рекомендации по организации работы стационарных организаций социального обслуживания в условиях COVID-19 (усиленный питьевой режим, раздача в жилые комнаты, дезинфекционный контур)	https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=8&documentId=361442	Минтруд России — проверено 18.08.2026 по тексту письма
S029	Методические рекомендации по организации питания в учреждениях (отделениях) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (пост. Минтруда России от 15.02.2002 № 12, ред. приказа от 04.06.2007 № 397): лечебно-профилактические продукты, профилактика витаминной недостаточности, санитарная безопасность	https://docs.cntd.ru/document/901816611	Минтруд России — проверено 18.08.2026 по тексту
S030	Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга: «Работа по развитию психоневрологических интернатов продолжается» (22.07.2025) — первые результаты вариативного меню в ДСО «Серафимовский»	https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/trud/news/302216/	Комитет по социальной политике СПб / ДСО «Серафимовский» — 17.08.2026

ID	Что	Где / URL	Проверено
S031	Письмо Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга руководителям государственных учреждений об усилении контроля за исполнением поставщиками питания своих обязательств (ст. 34, 94, 95 44-ФЗ; ежедневный мониторинг, акты, претензии, одностороннее расторжение, РНП)	внутренний документ Комитета (оригинал у автора)	Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга (председатель Е.Н. Фидрикова) — 19.08.2026
S032	Приказ Минздрава России от 05.08.2003 № 330н «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях РФ» (Инструкция по организации лечебного питания, диеты по Певзнеру; действующая редакция — с изм., внесёнными приказом Минздрава России от 19.02.2024 № 70н)	https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44323/	Минздрав России (рег. Минюст 12.09.2003 № 5073) — 19.08.2026
S033	Приказ Минздрава России от 21.06.2013 № 395н «Об утверждении норм лечебного питания» (действующая редакция — с изм., внесёнными приказом Минздрава России от 19.02.2024 № 70н)	https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149196/	Минздрав России (рег. Минюст 05.07.2013 № 28995) — 19.08.2026
S034	Извещение № 0372200070825000244: открытый конкурс в электронной форме «Поставка продуктов питания» СПб ГБУСОН «ДСО «Тесовый берег» (ИНН 7827661874); обеспечение заявки по ст. 45 44-ФЗ; опубликовано 24.11.2025, площадка АГЗ РТ	https://www.tenderguru.ru/tender/90473908	СПб ГБУСОН «ДСО «Тесовый берег» — 19.08.2026
S035	Приказ директора СПб ГАСУСОН «ДСО «Серафимовский» от 10.03.2026 № 124 «Об утверждении правил внутреннего распорядка жителей СПб ГАСУСОН «ДСО «Серафимовский»» (в правилах закреплено заказное питание — вариативное меню, в т.ч. для маломобильных граждан; PDF опубликован на www.pni9.ru — сайт прекратил работу, домен истёк, проверено 21.08.2026; текст правил в архивной копии: web.archive.org/web/20260415001233/https://www.pni9.ru/правила-внутреннего-распорядка/)	https://www.pni9.ru/правила-внутреннего-распорядка/	СПб ГАСУСОН «ДСО «Серафимовский» (архив сайта: web.archive.org/web/20260415001233/) — 21.08.2026

44.2. Клинические источники (М) — 48

ID	Что	Где / URL	Проверено
M-cloz_hagg	Hägg S. et al. Кофеин 400–1000 мг/день: +19% AUC клозапина, –14% клиренс	https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2014893/	2000
M-cloz_case	Yartsev P. et al. Тяжёлая токсичность клозапина при приёме энергетиков (600 мг кофеина/день; уровень 1796 нг/мл) — клинический случай	https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8043221/	2021
M-cloz_wd	Отмена кофеина: снижение уровня клозапина на 37–47% (Carrillo 1998; обзор)	https://www.pharmacytimes.com/view/caffeine-and-clozapine	клинический обзор

ID	Что	Где / URL	Проверено
M-lithium	Литий и диета: почки обрабатывают литий и натрий сходно; дефицит натрия/ обезвоживание → рост уровня лития	https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/25207-lithium-toxicity	Cleveland Clinic
M-lithium_sp	StatPearls. Lithium Toxicity: риски — дегидратация, диуретики, лихорадка, потери ЖКТ	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK499992/	StatPearls
M-carb_gf	Garg S.K. et al. Грейпфрутовый сок: пик карбамазепина 6,55→9,20 мкг/мл (+40%), AUC +41%	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9757152/	1998
M-maoi_nhs	NHS. MAOI — диетические ограничения (тирамин): пациентский листок	https://www.torbayandsouthdevon.nhs.uk/uploads/25672.pdf?last-updated=20201119	NHS
M-maoi_hist	«Сырная реакция» на ИМАО: история открытия (Blackwell; АД 160/90→220/115)	https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2738414/	исторический обзор
M-maoi_guide	MAOI diet and tyramine: руководство для назначающих (обновление 2022)	https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9172554/	prescriber's guide
M-pillinger	Pillinger T. et al. Мета-анализ 100 РКИ (25 952 пациента): прибавка веса на антипсихотиках от −0,23 кг (галоперидол) до +3,01 кг (клозапин) за медиану 6 нед (Lancet Psychiatry, 2020)	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31860457/	2020
M-crwg	Мета-анализ CRWG (прибавка ≥7% за 38 нед): клозапин 76,3%, оланзапин 36,9%, рисперидон 23,0% (BJPsych Open, January 2023, DOI 10.1192/bjo.2022.619). Campforts 2026 — другая статья (семаглутид/метформин).	https://www.cambridge.org/core/journals/bjpsych-open/article/association-between-antipsychotic-medication-and-clinically-relevant-weight-change-metaanalysis/C2DC78D062978D7C805E0E9B99B7911F	2023
M-fepwg	Мета-анализ при первом эпизоде психоза: долгосрочно оланзапин +9,34 кг, клозапин +7,19 кг	https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5589463/	мета-анализ
M-metmon	Мониторинг метаболического риска на антипсихотиках: график (вес/ИМТ: исходно, 4/8/12 нед, 6 мес, ежегодно; глюкоза/липиды/ АД: исходно, 12 нед, ежегодно)	https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8582768/	клинические рекомендации
M-lifestyle	Lifestyle interventions in mental health conditions: systematic review (57 исследований; −1,42 кг)	https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9462072/	2022
M-teasdale	Teasdale S. et al. Nutrition/dietary interventions for SMI (MJA, 2023)	https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9828433/	2023
M-resolve	RESOLVE: реалистский синтез антипсихотической прибавки веса (2025)	https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12531729/	2025
M-dysph_prev	Font L. et al. Дисфагия на фоне антипсихотиков: распространённость 21,9–69,5% (систематический обзор)	https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10455044/	систематический обзор
M-dysph_rev	Дисфагия при шизофрении: механизмы (паркинсонизм, сухость, гиперсаливация, седация, нарушения еды) — обзор	https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsy.2024.1448623/full	обзор
M-dysph_dd	Дисфагия, аспирационная пневмония и кишечная непроходимость на антипсихотиках у лиц с нарушениями развития; предупреждение FDA о запорах на клозапине (2020)	https://www.jscimedcentral.com/public/assets/articles/psychiatry-11-1183.pdf	обзор

ID	Что	Где / URL	Проверено
M-mortality	Correll C. et al. Мета-анализ смертности при шизофрении: смерть на 15–20 лет раньше; пневмония RR 7,00 — высшая из естественных причин (World Psychiatry, 2022)	https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9077617/	2022
M-mortality2	Шведский регистр: ССЗ — ведущая причина избыточной смертности при шизофрении (MRR 2,80; смерть от ССЗ на 10 лет моложе)	https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6137375/	регистровое исследование
M-iddsi2017	Cichero J.A.Y. et al. The IDDSI Framework (Dysphagia, 2017;32(2): 293–314)	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27913916/	IDDSI, 2017
M-iddsi_wu	Wu X.S. et al. IDDSI implementation: соответствие текстур 44%→90%	https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8994209/	2022
M-nijs	Nijs K. et al. Family-style mealtimes: cluster RCT (BMJ, 2006)	https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1463975/	2006
M-montessori	Montessori-based interventions for dementia: systematic review (15 исследований)	https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10336713/	2023
M-pm_rev	Porter J. et al. Protected mealtimes: systematic review & meta-analysis (Int J Nurs Stud, 2017)	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27866011/	2017
M-pm_rct	Porter J. et al. Protected Mealtimes: stepped-wedge cluster trial (2019)	https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5295189/	2019
M-sup_hous	Supported housing for people with SMI: systematic review & meta-analysis (2022)	https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsy.2022.966029/full	Frontiers in Psychiatry
M-ebt	Исследование «Если быть точным»: ПНИ России в цифрах — 466 интернатов (2024), 139 500 жителей, 74% недееспособных, 65% старше 45 лет (апрель 2026)	https://www.forbes.ru/forbeslife/558987-s-2022-po-2024-god-cislo-psihonevrologicheskikh-internatov-v-rossii-snizilos-na-13	2026
M-ebt2	Исследование «Если быть точным»: сопровождаемое проживание — 7 000 чел.; переименование ПНИ в «дома социального обслуживания» в 41 регионе (2026)	https://tochno.st/materials/kak-ustroeny-pni-v-rossii-issledovanie-esli-byt-tocnym	2026
M-oral_yoneyama	Yoneyama T. et al. Ежедневный уход за полостью рта в домах ухода: частота пневмоний 11 % против 19 % в контроле (РКИ, 366 проживающих)	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11874491/	J Am Geriatr Soc, 2002
M-oral_muller	Müller F. Обзор 4 РКИ: улучшение гигиены полости рта может предотвращать ~1 из 10 смертей от аспирационной пневмонии у немощных пожилых	https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4541086/	Gerodontology, 2015
M-dehydr_steele	Steele C.M. Нагрузка лечения загущёнными жидкостями: нет убедительных данных о снижении осложнений при доказанном снижении потребления жидкости	https://publications.ersnet.org/content/breathe/17/1/210003	Breathe (ERS), 2021
M-dehydr_li	Li W.Q. et al. Систематический обзор и мета-анализ применения загущённых жидкостей при дисфагии	https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12516007/	2025
M-constip_ep	Every-Palmer S. et al. Клозапин-индуцированная гипомотильность ЖКТ: запоры у 30–60 % пациентов, при объективных методах — до 80 %; тяжёлый запор может быть фатальным (иблиус, перфорация)	https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5533872/	Aust N Z J Psychiatry / PMC, 2017

ID	Что	Где / URL	Проверено
M-constip_nhs	NHS Specialist Pharmacy Service. Ведение запоров у принимающих клозапин: может быть фатальным; мониторинг стула, профилактические слабительные	https://sps.nhs.uk/articles/managing-constipation-in-people-taking-clozapine/	NHS, Великобритания
M-micro_vitd	LoPinto-Khoury C. et al. Мета-анализ: карбамазепин ассоциирован со снижением 25(OH)D	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34847425/	Epilepsy Research, 2021
M-micro_psyс	Cuomo A. et al. Дефицит витамина D распространён в психиатрической популяции; рекомендован рутинный скрининг	https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsy.2019.00167/full	Frontiers in Psychiatry, 2019
M-micro_b12	Hanna S. Дефицит B12 и фолата у пожилых: связь с депрессией и когнитивными нарушениями, недодиагностика	https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2781043/	Primary Care Companion / PMC, 2009
M-dental_porter	Porter J. et al. Более половины проживающих домов ухода сообщают о проблемах полости рта — преимущественно сухость во рту и плохо сидящие протезы	https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4501060/	Int J Dent Hyg / PMC, 2015
M-guss_trapl	Trapl M. et al. GUSS (Gugging Swallowing Screen): прикроватный скрининг дисфагии, валидирован против FEES, выполняется подготовленной медсестрой	https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.107.483933	Stroke, 2007
M-eat10	Belafsky P.C. et al. EAT-10: 10-пунктный опросник симптомов дисфагии (само- и интервью-версии)	https://doi.org/10.1177/000348940811701210	Ann Otol Rhinol Laryngol, 2008
M-comf_oralfeed	Oral feeding options for people with dementia: a systematic review	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21391936/	систематический обзор (2011); PMID 21391936
M-comf_jnha	Comfort feeding in hospitalised people with dementia: a retrospective study of survival following comfort feeding recommendations	https://doi.org/10.1016/j.jnha.2024.100362	J Nutr Health Aging, 2024; DOI 10.1016/j.jnha.2024.100362
M-hydr_esp	Volkert D. et al. ESPEN guideline on clinical nutrition and hydration in geriatrics (Clin Nutr, 2019, 38(1): 10–47)	https://doi.org/10.1016/j.clnu.2018.05.029	ESPEN (Европейское общество клинического питания и метаболизма); Clin Nutr
M-hydr_palt	Dehydration and Fluid Maintenance in the Long-Term Care Setting — клиническое руководство	https://paltmed.org/sites/default/files/2024-10/Dehydration%20CPG%2008092024.pdf	PALTmed (Общество паллиативной медицины), 2024
M-hydr_low	Narrative Review of Low-Intake Dehydration in Older Adults	https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8470893/	обзор (2021); PMC8470893
M-must_bapen	BAPEN. MUST — Malnutrition Universal Screening Tool: 5-шаговый скрининг (ИМТ, непреднамеренная потеря >5 % за 3–6 мес, острое заболевание); для домов ухода — регулярное (обычно ежемесячное) взвешивание	https://www.bapen.org.uk/pdfs/must/must_explan.pdf	BAPEN, Великобритания, 2003/2018

44.3. Международные нормы и практики (I) — 44

ID	Что	Где / URL	Проверено
I-cqc14	CQC. Regulation 14: Meeting nutritional and hydration needs — руководство для поставщиков	https://www.cqc.org.uk/guidance-regulation/providers/regulations-service-providers-and-managers/health-social-care-act/regulation-14	CQC, Великобритания

ID	Что	Где / URL	Проверено
I-bda	BDA. Nutrition and Hydration Digest / руководство по питанию в психиатрических стационарах	https://www.bda.uk.com/asset/A18E6711-0DCF-4191-851AB06AC59B4C90/	British Dietetic Association
I-bda_res	BDA. Практические ресурсы по питанию в психиатрии (лекарственно-пищевые взаимодействия)	https://www.bda.uk.com/practice-and-education/resources-for-practice/mental-health-learning-disability-inpatients.html	BDA
I-nhs2016	Hospital Food Standards Panel. Standards for food and drink in NHS hospitals	https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a806e1eed915d74e33fa61a/Hospital_Food_Panel_May_2016.pdf	ДН, Великобритания, 2016
I-aus6	Strengthened Aged Care Quality Standards, Standard 6 – Food and Nutrition	https://www.agedcarequality.gov.au/providers/quality-standards/strengthened-aged-care-quality-standards	ACQSC, Австралия, 2025
I-aus_iddsi	ACQSC. Texture-modified food and fluids (IDDSI, EDAR) – provider fact sheet	https://www.agedcarequality.gov.au/sites/default/files/media/fnd_providers_texturemodified.pdf	ACQSC, Австралия
I-hugo	Hugo C. et al. What does it cost to feed aged care residents in Australia? (Nutrition & Dietetics, 2018)	https://pure.bond.edu.au/ws/files/25958488/What_does_it_cost_to_feed_aged_care_residents_in_Australia.pdf	Австралия, 2018
I-fct	Milte R. et al. Foodservice Costing Tool study (2022): полная стоимость пищевой службы; надбавка \$10	https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9321358/	Ун-т Квинсленд, 2022
I-ontario	O. Reg. 246/22 (General) под Fixing Long-Term Care Act 2021, ст. 75–80	https://www.ontario.ca/laws/regulation/220246	Онтарио, Канада, 2022
I-dcbp	Dietitians of Canada. Best Practices for Nutrition, Food Service and Dining in LTC Homes	https://www.dietitians.ca/DietitiansOfCanada/media/Documents/Resources/2019-Best-Practices-for-Nutrition,-Food-Service-and-Dining-in-Long-Term-Care-LTC-Homes.pdf	Онтарио, 2019
I-m3mmar	M3 (Making the Most of Mealtimes): адекватность меню и потребление (mMAR)	https://www.jnursinghomeresearch.com/1592-food-services-in-long-term-care-homes-are-associated-with-residents-food-intake.html	Канада
I-m3rel	M3: реляционные практики за столом и качество приёма пищи	https://uwspace.uwaterloo.ca/bitstreams/5dc2e5f7-d1dc-4580-8ece-4444695c8753/download	Канада
I-ont_fao	FAO Ontario: финансирование LTC, конверт raw food	https://fao-on.org/wp-content/uploads/2024/08/Long-term-care-homes-program.pdf	Онтарио, 2019
I-osnac	OSNAC: конверт nutritional support \$13,71 CAD/рез./день	https://www.osnac-fnat.com/mltc	Онтарио, 2020-е
I-torstar	Toronto Star: конверт сырья \$8,33 CAD (2017)	https://www.thestar.com/news/canada/ontario-nursing-homes-feed-seniors-on-8-33-a-day/article_6b7fab43-437c-5ba6-bbfb-0f1d6426062b.html	Онтарио, 2017
I-cfr	42 CFR § 483.60 Food and Nutrition Services (CMS)	https://www.law.cornell.edu/cfr/text/42/483.60	США, 2016
I-ftag	The Consumer Voice. Food Appendix (F-теги пищевого блока)	https://theconsumervoice.org/wp-content/uploads/2026/06/Food-Appendix.pdf	США
I-ftag2	LTCSS. Fact Sheet: F-теги и достоинство	https://nursinghome411.org/wp-content/uploads/2023/01/Fact-Sheet-Food-and-Dietary-Services.pdf	США
I-pioneer	Pioneer Network. Home-Style Dining Interventions	http://www.pioneernetwork.org/wp-content/uploads/2016/10/Home-Style-Dining-Interventions.pdf	США

ID	Что	Где / URL	Проверено
I-ghouse	Green House Project: модель и независимая оценка (качество жизни, нейтральная стоимость)	https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5338211/	США
I-eden	Eden Alternative: философия и десять принципов	https://edenalt.org/	США
I-anfp	ANFP Benchmarking Program: расходы на сырьё в nursing homes	https://www.anfponline.org/docs/default-source/legacy-docs/docs/benchmarking-program/anfpbenchmarkingprogramarticle-marchapril2018.pdf	США
I-snn	Skilled Nursing News: >25% домов снизили расходы на питание ниже \$10 (2025)	https://skillednursingnews.com/2025/04/more-than-25-of-nursing-homes-slash-food-spending-below-10-a-day/	США, 2025
I-lvnat	Livsmedelverket. Nationella riktlinjer för måltider i äldreomsorgen (ночной интервал ≤11 ч; 6 приёмов)	https://www.livsmedelverket.se/49bd7f/globalassets/publikationsdatabas/broschyrrer-foldrar/riktlinjer_for_maltider_aldreomsorgen.pdf	Швеция, 2021
I-orebro	Örebro kommun. Riktlinjer för mat, måltid och nutrition (IDDSI, процесс нутритивной помощи)	https://www.orebro.se/download/18.5779588418bcc1d3d2313d8/1700215055156/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20mat,%20m%C3%A5ltider%20och%20nutrition%20version%206,%2023-11-16.pdf	Швеция, 2023
I-norrk	Norrköpings kommun. Riktlinje för mat och måltider (охват SoL и LSS)	https://norrkoping.se/download/18.5ff942e1184b3f255e22fdc2/1664797385777/Fastst%C3%A4lld%20riktlinje%20f%C3%B6r%20mat%20och%20m%C3%A5ltider%20september%202022.pdf	Швеция, 2022
I-tallg	Region Jämtland: кейс Tallgläntan — замеры ночного голодания 2*/год	https://www.regionjh.se/download/18.7b79416a31d3449611c4/1557149809111/2016-2-Skoglund-%C3%96hman.pdf	Швеция, 2016
I-fin_nnc	Suominen M. et al. Nutritional guidelines for older people (семейные трапезы, персонал ест вместе)	https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12877505/	Финляндия, 2022
I-fin2020	Ruokavirasto. New food recommendation for elderly care (2020)	https://www.ruokavirasto.fi/en/foodstuffs/healthy-diet/uutiset/new-food-recommendation-for-elderly/	Финляндия, 2020
I-dge	DGE-QST для стационарных учреждений (Essbiografie, Wunschkost, Fingerfood, аудит)	https://www.bmleh.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Ernaehrung/GesundeErnaehrung/DGE-Standard_Seniorenverpflegung.pdf?__blob=publicationFile&v=4	Германия
I-dge_bettr	DGE-QST Betriebe/ Kliniken: цикл ≥4 недели, вегетарианское ежедневно, перекусы в любое время	https://www.jobundfit.de/fileadmin/user_upload/medien/DGE-QST/DGE-Qualitaetsstandard_Betriebe_Behoerden_Hochschulen.pdf	Германия
I-at_qs	Qualitätsstandard Ernährung в домах престарелых (Австрия, актуализация 2022)	https://www.sozialministerium.gv.at/dam/jcr:4f9ff5dc-a44c-4dee-b8d9-a22e6cd3c300/AKTUALISIERT_QS_f%C3%BCr_die_Ern%C3%A4hrung_in_Wohn-_und_Pflegeeinrichtungen_f%C3%BCr_Seniorinnen_und_Senioren.pdf	Sozialministerium Австрия
I-noe	Niederösterreich «Tut gut». Leitlinie Gemeinschaftsverpflegung (цикл ≥4 недели, частоты)	https://www.noetutgut.at/fileadmin/user_upload/noetutgutmedia/Downloads/Vitalkueche/Gemeinschaftsverpflegung_Leitlinie_Senioren.pdf	Австрия, 2021
I-sunrise	MedUni Graz (SUNRISE): аппетитные описания блюд меняют выбор	https://www.medunigraz.at/frontend/user_upload/OEs/institute/pflegewissenschaft/pdf/Leitfaden_Interessierte.pdf	Австрия, 2021
I-jp2005	NIPH Journal: реформа LTCI 2005 и пищевые доплаты	https://www.niph.go.jp/journal/data/55-1/200655010006.pdf	Япония, 2006
I-jpcov	Доплата за нутритивный менеджмент: охват 87–94% учреждений (2020)	https://comimi.jp/archives/column/kasan3	Япония, 2021

ID	Что	Где / URL	Проверено
I-jp2021	Ревизия тарифов 2021: усиленная доплата, обязательный стандарт, вычет, LIFE	https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/2021housyuukaitei/documents/eiyoucaremanezimentonozyuuzitu.pdf	MHLW, Япония
I-jperia	ERIA. Outcomes of Long-term Care in Japan (доплаты и исходы, HR 0,90)	https://www.eria.org/uploads/media/Research-Project-Report/2020-13-Outcomes-of-Long-term-Care-Japan/Outcome-of-Long-term-Care-Insurance-Service-in-Japan-new.pdf	Япония, 2020
I-jpdiet	Больше диетологов → ниже потенциально предотвратимые госпитализации: HR 0,72 (95% ДИ 0,54–0,97), когорта 2909 жителей 235 домов	https://doi.org/10.1186/s12877-023-04278-2	BMC Geriatrics, Япония, 2023
I-crpd28	КПИ, ст. 28 «Адекватный жизненный уровень и социальная защита»	https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities	ООН
I-gc1	Замечание общего порядка № 1 (2014) Комитета ООН по правам инвалидов о ст. 12 КПИ (CRPD/C/GC/1)	https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-comment-no-1-article-12-equal-reco	Комитет ООН по правам инвалидов, 2014
I-qr_wafr	Moro M.F. et al. Quality of care in mental health services, 4 страны Зап. Африки (BJPsych Open, 2022)	https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8811781/	WHO QualityRights
I-qr_ghana	Moro M.F. et al. Nationwide QualityRights evaluation, Ghana (BMC Public Health, 2022)	https://link.springer.com/article/10.1186/s12889-022-13102-2	2022
I-easyread	Великобритания: Accessible Information Standard — информация для пациентов с нарушениями предоставляется в доступных форматах (включая easy read: короткие фразы + изображения); Mencap — методические материалы	https://www.mencap.org.uk/help-and-advice/health/accessible-information-standard	NHS England / Mencap, Великобритания

Итого: 34 + 48 + 44 = 126. Маркер без строки в этом списке — ошибка автора.

Часть II. Учебные кейсы (22 разбора)

Двадцать два ситуационных разбора переводят главы в ежедневные решения: что нельзя, что сделать сразу, кто решает, какие документы нужны, каково долгосрочное решение и где граница вывода. Все кейсы учебные; они не описывают конкретные дома и людей.

Учебные кейсы 1–4

Все кейсы в этом блоке — учебные ситуации, составленные для анализа. Они не описывают конкретные организации и конкретных людей. Правовые и медицинские основания — ориентиры для разбора, не заключение по реальному делу.

Кейс 1. Один вариант закончился до подхода последнего отделения

Ситуация. На обед два варианта второго: гречка с котлетой и рис с рыбой. Рыба кончилась на третьем из пяти отделений. Последние два получают только гречку; часть жителей выбирала рыбу утром по визуальному меню.

Проблема. Выбор реален для первых и фиктивен для последних. Срыв система обязана фиксировать, а не списывать на «неудачный день».

Что нельзя делать. Выдавать гречку молча, без объяснения. Переписывать лист заказа задним числом. По одному эпизоду решать, что «вариативность не работает».

Немедленно. Предложить замену из остатков линии — альтернативный гарнир, если есть. Записать в журнал срывов выбора: дата, позиция, сколько порций не хватило, кому предложена замена.

Кто принимает решение. Старшая смены раздачи — о замене на месте. Заведующий производством — о причине: неверный расчёт заказа или кривая статистика выбора.

Документы. Журнал срывов выбора (приложение 8), журнал заказа (приложение 7).

Долгосрочное решение. Пересчёт объёмов по статистике выбора за 2–4 недели (раздел 21). Живое распределение редко бывает «пятьдесят на пятьдесят». Стандартный вариант — с резервом, вариативный — по статистике.

Основания. Замена при недоступности выбранного — 42 CFR §483.60 (международный ориентир)³⁸. В российской рамке — обязанность обеспечить питание по СанПиН 2.3/2.4.3590-20¹² и уважение достоинства (ст. 37, 43 закона 3185-1)¹¹.

Ограничение вывода. Один эпизод — не статистика. Объёмы меняют по серии записей журнала.

Кейс 2. Человек выбирает блюдо, противопоказанное по назначению врача

Ситуация. Житель с диетой с ограничением соли просит солёную рыбу соседа. Дееспособен, настроение решительное.

Проблема. Столкнулись две законные нормы: право на выбор и врачебное назначение. Серая зона: персонал чаще запрещает «вообще всё» или пускает на самотёк.

Что нельзя делать. Решать силой на линии раздачи. Давать запрещённое «чтобы не скандалил». Выяснять диагноз при других жителях.

Немедленно. Предложить разрешённый эквивалент из меню. Сказать: вопрос солёного — к врачу сегодня же. Зафиксировать запрос.

Кто принимает решение. Врач — единолично: скорректировать назначение, подтвердить ограничение и разъяснить его жителю либо оформить исключение с фиксацией риска. Персонал и директор назначения не меняют.

Документы. Пищевая карта с назначением, запись врача; при изменении — обновлённая карта.

Долгосрочное решение. Конфликт «выбор против назначения» в тот же день уходит врачу — правило положения о питании. У диетических столов тоже пары эквивалентов (раздел 19).

Основания. Врачебное назначение персонал СОСО не имеет права пересматривать. Стык соцобслуживания и лечебного питания — региональный «мост» (раздел 24, пример — распоряжение 19РВ-32)²⁵. Выбор — внутри назначенных рамок (ст. 37, 43 закона 3185-1)¹¹.

Ограничение вывода. Кейс задаёт маршрут, не судит, «кто прав». Ответ даёт врач.

Кейс 3. Недееспособный житель показывает на фотографию блюда

Ситуация. На визуальном меню житель с выраженным когнитивным снижением тычет в борщ. Сиделка: «Он всегда на первую картинку показывает, это не выбор».

Проблема. Как отличить выбор от рефлекса — и кто вправе объявить жест «не выбором».

Что нельзя делать. Игнорировать жест: «всё равно не выбор». Исполнять без проверки, если человек показывает на любую первую картинку. Исключать из процедуры навсегда по одному наблюдению.

Немедленно. Поменять порядок фотографий. Показывает на борщ независимо от места — выбор. Всегда на первую картинку — позиция, не содержание. Результат — в форму наблюдения.

Кто принимает решение. Смена фиксирует. Вывод о предпочтениях — в пищевую карту по нескольким наблюдениям: знающий жителя персонал, при возможности — близкие (раздел 15).

Документы. Форма наблюдения за невербальным выбором (приложение 6), пищевая карта.

Долгосрочное решение. Индивидуальный протокол: две карточки, не пять; время показа; проверка позиционного эффекта раз в месяц. Предпочтения и способности меняются.

Основания. Предпочтения учитывают независимо от когнитивного статуса: австралийский Стандарт 6 с 01.11.2025³⁷; Онтарио — preferences в плане питания²⁶. В российской рамке — ст. 37 через процедуру¹¹.

Ограничение вывода. Перестановка — скрининг, не психологическая диагностика. Она не подменяет знание человека.

Кейс 4. Персонал заполняет лист выбора заранее

Ситуация. Заведующая отделением обнаруживает: лист заказа на завтра заполнен сегодня днём — до показа меню. Сиделка: «Так быстрее, я и так знаю, кто что ест».

Проблема. Процедура есть, выбора нет. Документы при проверке «докажут» то, чего не было (раздел 21).

Что нельзя делать. Устраивать показательный разбор при смене. Списывать на «лень» — почти всегда не хватает времени на процедуру. Отменять журнал как «бесполезный»: проблема в наполнении, не в журнале.

Немедленно. Аннулировать предзаполненный лист. Провести выбор с жителями заново в тот же вечер. Спросить сиделку, сколько времени реально занимает показ меню.

Кто принимает решение. Заведующая отделением — о процедуре. Директор — если причина в дефиците времени смены (нормы нагрузки, раздел 28).

Документы. Журнал заказа, служебная записка о нарушении процедуры; при повторении — материалы внутренней проверки.

Долгосрочное решение. Меню висит заранее, показ — минуты на человека, выбор фиксируется при жителе. Проверка реальности (приложение 24): раз в неделю случайный опрос пяти жителей — «что вы вчера заказывали».

Основания. Документ, не соответствующий фактам, — худшая позиция перед проверкой (раздел 32). Нормы о выборе требуют реальной, не бумажной альтернативы^{38, 26}.

Ограничение вывода. Злого умысла эпизод не доказывает. «я знаю, кто что ест» часто правда по содержанию. Беда — подмена процедуры знанием.

Учебные кейсы 5–8

Все кейсы — учебные ситуации, составленные для анализа.

Кейс 5. Житель отказывается от еды из-за подозрения в отравлении

Ситуация. Житель с психотическим расстройством второй день не ест: «Здесь отравлено». Убеждение бредовое. Вес пока стабилен.

Проблема. Отказ встроен в клинику: обычные приёмы не работают, бездействие опасно.

Что нельзя делать. Доказывать, что еда не отравлена: логика против бреда усиливает недоверие. Кормить принудительно — насилие недопустимо ни в какой форме (раздел 12). Ждать «пока проголодается» без мониторинга.

Немедленно. Врач — в тот же день. Правило трёх отказов срабатывает раньше: бредовая мотивировка сама по себе клинический сигнал. Приёмы смены, не нарушающие доверия: запечатанная упаковка, еда из общего котла при жителе, выбор тарелки из нескольких, участие человека, которому он доверяет.

Кто принимает решение. Врач — о клинической тактике, включая коррекцию терапии. Смена — о формате подачи. Директор — об условиях: выбор тарелки, упакованные продукты.

Документы. Журнал отказов (приложение 9), запись врача, динамика веса.

Долгосрочное решение. План питания на обострение: упаковка, «магазинные» продукты, приготовление на глазах, где возможно. Структурированная доступность еды (раздел 13) здесь держит нутритивный статус.

Основания. Принудительное кормление недопустимо — ст. 37 закона 3185-1 (гуманное обращение)¹¹. Недоедание при отказах имеет летальную значимость (пневмония, истощение)^{1, 17}.

Ограничение вывода. Приёмы «обхода» бреда — тактика на обострение, не постоянная модель. По выходе формат пересматривает врач.

Кейс 6. Житель спит во время завтрака из-за седативного эффекта

Ситуация. Вечерний приём препаратов перенесён на 22:00. Утром пятеро спят через завтрак; к 11:00 голодны и раздражительны, кухня завтрак уже убрала.

Проблема. Фармакология столкнулась с расписанием: режим питания не подстроен под ритм жителей.

Что нельзя делать. Будить насильно «потому что завтрак». Оставлять без завтрака — «виноваты сами». Менять время препаратов самостоятельно: компетенция врача.

Немедленно. Сохранить завтрак для спящих: отложенные порции — с температурным режимом и сроками (раздел 18). Сообщить врачу картину утра.

Кто принимает решение. Врач — о времени приёма: перенос на более ранний вечер часто закрывает проблему. Заведующий производством — о формате отложенного завтрака. Директор — о расписании.

Документы. Расписание, запись врача о времени приёма, журнал выдачи отложенных порций.

Долгосрочное решение. Гибкое окно завтрака — например, 8:00–9:30 — вместо точки 8:30. Согласование расписания с назначением — постоянная процедура при каждой смене схем терапии.

Основания. Режим питания СОСО по СанПиН — не реже трёхразового, с учётом заключения врача для нуждающихся (п. 7.1.11–7.1.14 3590-20; с 01.09.2026 — п. 56 подп. 11 4282-26)¹². Седация как побочный эффект — реальность антипсихотической терапии⁶⁴. Ориентир гибкости: «что, когда, где и как я ем» (Стандарт 6)³⁷.

Ограничение вывода. Гибкое окно — диапазон режима, не его отмена. Температура и сроки выдачи сохраняются полностью.

Кейс 7. Два жителя отбирают еду друг у друга

Ситуация. За столом на шестерых один систематически забирает котлету у соседа. Тот не сопротивляется, потом доедает хлеб с чаем. Смена «не замечает»: вмешательство провоцирует агрессию.

Проблема. Скрытое недоедание одного плюс пищевая агрессия другого. Молчание смены подписывает обоих в риск.

Что нельзя делать. Наказывать отбирающего лишением еды — еда не инструмент вознаграждения и наказания (раздел 20). Сажать «обидчика» в одиночку навсегда без наблюдения. Считать, что «они сами разберутся».

Немедленно. Развести по разным столам сегодня же. Потерпевшему — полная порция под наблюдением. Зафиксировать эпизод.

Кто принимает решение. Старшая смены — о рассадке. Врач — об оценке пищевого поведения: гиперфагия, импульсивность, когнитивное снижение — разные механизмы (раздел 13). Заведующая отделением — о постоянной схеме столов.

Документы. Запись об инциденте, пищевые карты обоих; при повторении — протокол разбора (приложение 34).

Долгосрочное решение. Схема рассадки как документ отделения: кто с кем сидит и почему. Для жителя с гиперфагией — структурированный режим доступности еды, снижающий «охоту» за чужими порциями (раздел 13). Для потерпевшего — контроль веса.

Основания. Пищевая агрессия и гиперфагия — описанные паттерны при психических расстройствах^{43, 115}. Защищать жителя от вредного воздействия других — из логики ст. 37¹¹.

Ограничение вывода. Рассадка — рабочий инструмент, не наказание. Схему пересматривают, не закрепляют пожизненно.

Кейс 8. Человек быстро заглатывает куски

Ситуация. Житель ест очень быстро, не прожёвывая, большими кусками. Дважды за месяц — поперхивание с кашлем. Врач в отпуске, замещающий придёт через неделю.

Проблема. Быстрое заглатывание — фактор риска аспирации. Ждать врача неделю без промежуточных мер — неоправданный риск.

Что нельзя делать. Ждать без изменений. Переводить на полностью протёртое «на всякий случай» без назначения: излишняя модификация бьёт по качеству жизни и питательности. Команда «есть медленно!» не работает.

Немедленно. Меньшие порции с добавкой, не большая сразу. Куски меньшего размера по просьбе повара — сервировка, не диета. Напиток под рукой. Место в поле зрения смены. Его стол обслуживается первым — снять мотив «надо успеть».

Кто принимает решение. Смена — о сервировке и наблюдении. Замещающий врач — о скрининге дисфагии по прибытии. При повторном поперхивании — врач вне очереди: признак из списка дисфагического риска (раздел 10).

Документы. Форма наблюдения, запись о поперхиваниях; после врача, при подтверждении риска — назначение текстуры по IDDSI⁴⁵.

Долгосрочное решение. Скрининг дисфагии; при подтверждении — текстура, темповые техники, позиция за столом. Обучение смены приёмам безопасного кормления (раздел 10).

Основания. Поперхивание при еде — маркер риска аспирационной пневмонии, самого летального осложнения дисфагии^{27, 44}. Связь текстуры с исходами — во внедрениях IDDSI⁴⁶.

Ограничение вывода. Организационные меры — мост до врача, не замена скрининга. «Ест дважды поперхнулся» — основание для внеочередной оценки.

Учебные кейсы 9–12

Все кейсы — учебные ситуации, составленные для анализа.

Кейс 9. Кухня приготовила протёртое блюдо, не соответствующее назначенной текстуре

Ситуация. Жителю назначена текстура IDDSI 6 — мягкая, кусочками. Кухня дала «как обычно протёртое»: однородное пюре, это IDDSI 4. Разница видна невооружённым глазом — но не тому, кто не обучен.

Проблема. Ошибка в обе стороны опасна. Слишком грубая текстура — риск аспирации. Слишком гладкая — избыточная модификация: меньше питательной плотности, хуже сытость, унижающий «детский» вид тарелки.

Что нельзя делать. Выдать как есть — «протёртое же». Разбавлять пюре водой или бульоном «до нужной консистенции»: текстура и питательность меняются непредсказуемо. Считать, что «пюре безопаснее, пусть будет пюре»: избыточная модификация тоже вред.

Немедленно. Не выдавать. Дать порцию назначенной текстуры из доступных компонентов: мягкие кусочки — котлета, тушёные овощи — есть в стандартном меню. Зафиксировать несоответствие.

Кто принимает решение. Заведующий производством — о порции сегодня. Врач — если несоответствие повторяется: возможно, назначение не доведено до кухни. Директор — если кухня не обучена шкале IDDSI.

Документы. Назначение текстуры в пищевой карте и на кухонной карточке, запись о несоответствии.

Долгосрочное решение. Карточка текстур на стене кухни: вилка IDDSI с фотографиями из собственного меню. Обучение поваров тесту вилок и тесту наклона — минута на блюдо (раздел 10). Проверка текстур старшей сменой при выходе линии.

Основания. IDDSI — международный стандарт описания текстур⁴⁵. Внедрение улучшает соответствие назначенной текстуры фактической⁴⁶. Исполнение назначения — п. 7.1.12 СанПиН 3590-20 (с 01.09.2026 — п. 56 подп. 11 4282-26: питание по медицинским показаниям)¹².

Ограничение вывода. Самопроверка кухни — организационная мера. Назначение и его пересмотр остаются на враче.

Кейс 10. Родственник требует запретить продукт без врачебного назначения

Ситуация. Дочь требует: «Уберите отцу сахар совсем — у него преддиабет, я читала». Назначения по сахару нет. Отец сахар любит, споров не хочет, на вопросы отмалчивается.

Проблема. Третья сторона требует ограничить права жителя без клинического основания. Конфликт заботы, контроля и автономии.

Что нельзя делать. Исполнить молча — «родственникам виднее». Отмахнуться — «вы нам не указ»: родственник важен и может знать факты. Втягивать жителя в спор, «кто главнее».

Немедленно. Зафиксировать запрос письменно — заявление родственника. Маршрутизировать врачу: есть основания — назначит; нет — разъяснит родственнице. Позицию жителя выяснить отдельно и спокойно.

Кто принимает решение. Врач — о клинической стороне. Житель (дееспособный) — о питании в пределах назначений. Директор — о регламенте приёма заявлений.

Документы. Заявление родственника, запись врача, пищевая карта (позиция жителя).

Долгосрочное решение. Регламент «третьих сторон»: запрос на ограничение — только через врача и с учётом позиции жителя. Памятка родственникам (приложение 32): заранее объявленное правило снимает большинство конфликтов.

Основания. Права жителя не ограничивают по требованию третьих лиц без оснований (ст. 37, 43 закона 3185-1)¹¹. Близкие — источник информации, не источник запретов (раздел 15).

Ограничение вывода. Если житель недееспособен и опекун — учреждение, конфликт интересов — по процедуре раздела 16: зафиксированные предпочтения имеют приоритет над «усреднённым благом».

Кейс 11. Житель требует добавку при медицинском ограничении

Ситуация. Житель с ожирением на фоне терапии — набор веса известный эффект его препаратов — требует вторую порцию каждый обед. Врач рекомендовал контроль калорийности. Житель кричит: «Вы меня морите голодом».

Проблема. Гиперфагия лекарственного генеза против назначенного ограничения. Публичный конфликт за столом дестабилизирует отделение.

Что нельзя делать. Давать добавку «чтобы замолчал»: назначение обесценивается ежедневным исключением. Читать нотации о весе при всех. Оставлять конфликт на уровне «сиделка решает каждый день по настроению».

Немедленно. Выдать запланированную порцию спокойно, без лекции. Эскалация врачу — не «жалоба на жителя», а запрос на пересмотр тактики: низкокалорийные объёмные добавки (овощи), дробность, пересмотр препарата.

Кто принимает решение. Врач — о назначении и его коррекции. Смена исполняет назначение одинаково каждый день. Директор обеспечивает кухне низкокалорийные объёмные добавки.

Документы. Назначение врача, пищевая карта, динамика веса, записи о конфликтах.

Долгосрочное решение. Структурированный ответ на гиперфагию (раздел 13): объёмные низкокалорийные компоненты, дробный режим, ночная доступность там, где ночное едение — часть картины. Метаболический мониторинг веса, глюкозы, липидов — по стандартам для его терапии^{64, 62}.

Основания. Набор веса на антипсихотиках — документированный дозозависимый эффект^{16, 63}. Гиперфагия и ночное едение — специфические синдромы⁴³. Исполнять назначение — п. 7.1.12 СанПиН 3590-20 (с 01.09.2026 — п. 56 подп. 11 4282-26)¹².

Ограничение вывода. «Добавка или нет» — вопрос назначения, не дисциплины. Смягчение и ужесточение — только через врача.

Кейс 12. Выбор есть только на бумаге

Ситуация. Положение о вариативном питании утверждено полгода назад. Меню с двумя колонками висит, кухня готовит один вариант — «второй никто никогда не заказывал». Журнал заказов пуст.

Проблема. Фиктивная вариативность организационного масштаба — не операционного, как в кейсе 4. Система самообмана, которая при проверке становится обманом документальным.

Что нельзя делать. Считать: «положение есть — практика есть». Наказывать кухню: она рационально адаптировалась к нулевому спросу. Тихо снять колонку меню и забыть.

Немедленно. Диагностика по пяти признакам фиктивной вариативности (раздел 21): знают ли жители о выборе; показывает ли кто-то меню; реально ли приготовить второй вариант; что с журналом; спросить пятерых: «вы знали, что можно выбрать?».

Кто принимает решение. Директор. Это провал внедрения, не исполнителей: процедура не была встроена в ритм отделений.

Документы. Положение, меню, журнал, результаты диагностики, служебная записка.

Долгосрочное решение. Перезапуск как пилот (раздел 35): одна точка, показ меню как обязанность смены, журнал, замер через 90 дней. Положение без процедуры — предмет для переписывания, не для полки.

Основания. Различие «документ — практика» — ядро международных проверок: рейтинги CQC оценивают фактический опыт жителей, а не положения⁴². Соответствие документов практике — ответственность управленческая (раздел 33).

Ограничение вывода. Нулевой спрос в первые недели — норма: эффект новизны работает в обе стороны. Вывод о фиктивности — по данным месяцев, не дней.

Учебные кейсы 13–16

Все кейсы — учебные ситуации, составленные для анализа.

Кейс 13. Бухгалтерия не может связать выбор со списанием

Ситуация. Вариативная линия работает месяц. Бухгалтерия: «Журнал заказа живёт в отделении, списание продуктов идёт по укрупнённым нормам — как нам свести, сколько гречки и сколько риса списать?»

Проблема. Два потока данных — заказы и склад — не соединены. Риск — необоснованное списание при первой финансовой проверке.

Что нельзя делать. Списывать «как раньше, пополам»: фиктивная точность хуже честного метода. Требовать от бухгалтерии «разобраться самим» — им не хватает данных отделений. Сворачивать вариативность из-за учёта: задача решаемая (раздел 29).

Немедленно. Назначить ответственного за сведение. Ежедневные итоги журнала заказа — сколько порций какого варианта выдано — уходят в бухгалтерию: одна строка на позицию.

Кто принимает решение. Главный бухгалтер совместно с заведующим производством — о методике списания по фактической выдаче. Директор приказом закрепляет форму и ответственных.

Документы. Форма сведения (приложение 7 + учётная форма), приказ о порядке учёта вариативных позиций, действующие учётные формы по 52н с учётом переходного статуса¹⁰⁹.

Долгосрочное решение. Списание по факту выдачи: статистика выбора за месяц даёт пропорцию списания парных продуктов. Уточнить у учредителя признаваемую форму — статусы форм меняются поэтапно¹⁰⁹.

Основания. Принцип достоверности учёта. Методика «выдано по заказам = списано по пропорции» — стандарт поточных кухонь, не изобретение.

Ограничение вывода. Методика согласуется с учредителем и учётной политикой. Приложение — проект локальной формы, не норматив.

Кейс 14. Поставщик не привёз один из вариантов

Ситуация. По контракту на завтра — рыба для вариативной позиции. Поставщик вечером: рыбы нет, будет курица. Заказы собраны, треть выбрала рыбу.

Проблема. Разрыв цепочки «закупка — меню — заказ»: выбор сделан под продукт, которого не будет.

Что нельзя делать. Молча заменить рыбу курицей во всех порциях. Объявить «завтра без выбора» как новую норму. Скандал поставщику без бумаги: претензионная работа живёт в документах (раздел 30).

Немедленно. Повторный показ вечером: «рыбы завтра не будет, есть курица и второй вариант — перезаказ». При честном перезаказе почти весь спрос перераспределяется без конфликтов.

Кто принимает решение. Заведующий производством — о замене позиции. Старшая смены отделений — о перезаказе. Ответственный за контракт — о претензии поставщику.

Документы. Акт о недопоставке, претензия по контракту, запись о перезаказе в журнале заказа.

Долгосрочное решение. В спецификации закупки — правило взаимозаменяемости с нутриентными эквивалентами (раздел 30). Резервная пара из долгохранящихся продуктов на случай срыва. Статистика срывов — аргумент при следующей закупке.

Основания. Исполнение контракта и претензионная работа — 44-ФЗ и условия контракта. Полноценный приём пищи при срыве — из обязанности обеспечить питание¹².

Ограничение вывода. Единичный срыв — рабочая ситуация. Систематические — повод пересмотреть отношения с поставщиком по документам, не по раздражению.

Кейс 15. Персонал использует десерт как поощрение

Ситуация. В отделении укоренилось: «Кто убрал за собой — получает компот с булочкой, кто нет — просто компот». Сиделки считают это педагогикой.

Проблема. Еда стала рычагом поведения. Нарушение принципа «питание — право, а не награда» (раздел 20) и нормы о гуманном обращении.

Что нельзя делать. Закрывать глаза — «мелочь же»: из мелочей собирается культура столовой. Наказывать сиделок без объяснения: практика укоренилась — вина системная. Запрещать булочки «чтобы не было соблазна».

Немедленно. Прекратить дифференциальную выдачу сегодня же: десерт получают все по норме. Разговор со сменой — не о «плохих людях», а о правиле и его основаниях.

Кто принимает решение. Заведующая отделением — о прекращении практики. Директор — о фиксации правила в документах. Врач — если у кого-то ограничения по сладкому: альтернатива, не лишение.

Документы. Правило в положении о питании: «пища не используется как поощрение или наказание». Памятка персоналу (приложение 31), запись об инструктаже.

Долгосрочное решение. Инструктаж первого уровня (раздел 28) с правилом в явном виде. Правило — в контрольные вопросы обходов. Для сиделок — легальные инструменты поощрения: словесные, режимные, привилегии вне еды.

Основания. Гуманное обращение и недопустимость лишения питания — ст. 37 закона 3185-1¹¹. Еда как рычаг — маркер институциональной культуры; СЭС трактует это как дефект ухода⁴².

Ограничение вывода. Правило касается еды как рычага. Оно не запрещает праздничные столы и совместную готовку как деятельность. Граница — в условности: «получишь, если».

Кейс 16. Житель не говорит, но систематически оставляет одну кашу

Ситуация. Немой житель два месяца подряд не трогает манную кашу — ест всё остальное. Смена: «не ест манную». Диетолога нет. Врач: «раз ест остальное — порядок».

Проблема. Невербальное сообщение система уже расшифровала, но не закрепила. Предпочтение живёт в голове смены и умрёт с её ротацией.

Что нельзя делать. Выдавать манную «по меню» и выбрасывать: отходы плюс ежедневное игнорирование сказанного. Делать из одного наблюдения теорию — «у него аверсия к текстуре»: возможно, но это гипотеза для наблюдения (раздел 15). Оставлять знание неформальным.

Немедленно. В пищевую карту: «манную не ест (наблюдение, 2 мес.) — замена: любая другая каша». Проверить: при выдаче другой каши — ест.

Кто принимает решение. Смена фиксирует. Заведующая отделением утверждает запись в карте. Врач — если появятся признаки, что дело не во вкусе, а в текстуре или глотании (раздел 10).

Документы. Пищевая карта, форма наблюдения (приложение 6).

Долгосрочное решение. Пересмотр пищевых карт раз в квартал: предпочтения меняются, карта — живой документ. Замены из карты — в статистику планирования закупок (раздел 21).

Основания. Наблюдение — легитимный канал воли невербального жителя (раздел 15). Учёт предпочтений независимо от способности их высказать — международная норма^{37,26}.

Ограничение вывода. «Не ест манную» — фиксация наблюдаемого, не диагноз. При признаках дисфагии маршрут становится клиническим.

Учебные кейсы 17–20

Все кейсы — учебные ситуации, составленные для анализа.

Кейс 17. Житель хочет есть позже установленного времени

Ситуация. Ужин в 17:30. Житель годами ужинал дома в 20:00: в 17:30 не голоден, к 20:00 — голоден и зол. Просит «просто оставить мне тарелку».

Проблема. Режим против биографии. Одна из самых частых и самых решаемых точек трения (раздел 9).

Что нельзя делать. Отвечать «режим для всех один»: режим — инструмент, не ценность. Оставлять тарелку на столе на 2,5 часа — санитарно недопустимо: температура, сроки. Делать вид, что просьбы не было.

Немедленно. Отложенная порция по правилам: снимается с линии, хранится по температурному режиму, выдаётся в 20:00. Либо поздний перекус — чай, выпечка, кефир — из буфетной зоны, если она есть.

Кто принимает решение. Старшая смены — о ежедневной отложенной порции. Заведующий производством — о санитарно корректной схеме. Директор — если таких жителей много: сдвиг режима или второе окно ужина.

Документы. Пищевая карта (привычное время), распорядок с правилом отложенных порций, журнал выдачи.

Долгосрочное решение. Гибкие окна приёмов пищи (раздел 20) и ночная доступность там, где она показана (раздел 13). При массовом запросе — пересмотр распорядка. Международный опыт идёт к «когда я ем» как элементу прав³⁷. Шведская норма ночного интервала — не более 11 часов: режимы проектируют от физиологии, не от удобства кухни³³.

Основания. СанПиН задаёт кратность — не реже трёхразового — и учёт заключения врача, а не астрономическое время ужина¹². Привычный ритм — элемент уважения биографии (ст. 37)¹¹.

Ограничение вывода. Отложенная порция — сервис для отдельных жителей. Когда исключение становится массовым, менять надо режим, а не плодить исключения.

Кейс 18. В отделении не хватает работников для помощи за столом

Ситуация. 12 жителей нуждаются в помощи при еде. В смену — две сиделки. Норма помощи под «готовые руки» (1:2)²⁶ выполняется формально: кормят всех одновременно, темп конвейерный, двое регулярно не доедают.

Проблема. Дефицит рук — самая дорогая и самая честная проблема питания (раздел 28). Её не закрывают ни журналы, ни меню.

Что нельзя делать. Ускорять кормление — «по ложке в минуту»: риск аспирации и ежедневное унижение. Переводить всех на пюре «чтобы быстрее елось» без назначения. Писать, что помощь оказывается «в полном объёме».

Немедленно. Помощь по приоритету риска: сначала жители с дисфагическим риском (список из раздела 10). Для остальных — порционная сервировка, адаптивная посуда, рассадка «помогающий между двумя нуждающимися». Дефицит — служебной запиской директору, документ для раздела 38.

Кто принимает решение. Директор — о перераспределении смен между отделениями и о запросе учредителю (форма сообщения о дефиците — приложение 33). Старшая смены — о приоритете внутри смены.

Документы. Список дисфагического риска, служебная записка о дефиците, форма учёта трудозатрат (приложение 26) — замер реальных минут помощи.

Долгосрочное решение. Замер трудозатрат: минуты на жителя × число нуждающихся × приёмы пищи. Честный аргумент в разговоре о ставках (раздел 29: стоимость кормления — самая скрытая строка)⁵⁹. Параллельно — форматы самостоятельности: адаптивная посуда, «семейная» подача части блюд.

Основания. Норма 1:2 под «готовые руки» — онтарийский стандарт, ориентир, не российский норматив²⁶. Обеспечить потребление назначенного питания — из ст. 37/43 и СанПиН^{11,12}.

Ограничение вывода. Перераспределение и форматы — купирование, не решение. Решение — штатное, путь к нему — документированный замер дефицита.

Кейс 19. Директор получает жалобу от родственника

Ситуация. Письмо: «Моего брата кормят одной перловкой, на фото из отделения — серая масса. Требую разобраться, копия — в прокуратуру». Факты: перловка была вчера, фото месяц назад при неудачном свете, брат ест нормально, меню действительно монотонно.

Проблема. Жалоба неточна по фактам и точна по существу — монотонность. Формальная отписка здесь проигрывает.

Что нельзя делать. Отвечать одним опровержением — «перловка была один раз»: родственник читает это как «нам всё равно». Искать виноватого до выяснения. Обещать «разобраться и наказать»: жалоба не о наказании.

Немедленно. Запросить факты: меню за месяц, журнал замен, вес жителя. Пригласить родственника на обед — личный визит снимает 80% конфликта. Письменный ответ по существу: что проверено, что подтвердилось, что меняется.

Кто принимает решение. Директор лично. Жалоба с копией в прокуратуру не делегируется.

Документы. Жалоба, материалы проверки, ответ заявителю; при системном выводе — пилот вариативности (раздел 35) или совет жителей с участием родственников (раздел 34).

Долгосрочное решение. Регламент разбора жалоб и инцидентов (приложение 34): сроки, обязательный личный контакт, системные выводы. Родственники — неоплаченные аудиторы качества. Дни открытых дверей и дегустации совета дешевле любой PR-службы.

Основания. Прокурорский контур по жалобам — реальный риск-градиент (раздел 33)^{78, 79}. Ответ по существу — и правовая, и управленческая норма.

Ограничение вывода. Не каждая жалоба справедлива. Регламент защищает обе стороны: жителя — от плохой еды, организацию — от капризных конфликтов.

Кейс 20. Прокуратура просит показать, как учитывается мнение недееспособных жителей

Ситуация. Запрос по итогам плановой проверки: «Представить документы, подтверждающие учёт мнения и предпочтений жителей, признанных недееспособными, при организации питания». В организации 70% жителей недееспособны.

Проблема. Нет документированных процедур учёта невербальной воли — ответить нечем.

Что нельзя делать. Отвечать «их интересы представляет опекун»: опекун здесь само учреждение, конфликт интересов очевиден (раздел 16). Изготавливать документы задним числом: это выясняется и усугубляет. Отделываться фразами о «заботе».

Немедленно. Собрать то, что есть честно: пищевые карты с наблюдениями, протоколы совета жителей — если есть представители интересов, — журнал замен. Документов мало — честный ответ о текущем состоянии плюс план с датами: формы наблюдения (приложение 6), опрос, совет.

Кто принимает решение. Директор — об ответе. Заведующие отделениями — о сборе существующих записей. Юрист / учредитель — о форме ответа.

Документы. Ответ на запрос, план мероприятий с датами и ответственными, приказ о внедрении процедур.

Долгосрочное решение. Полный контур раздела 15: четыре канала воли, формы наблюдения, пищевые карты, протоколы совета. После внедрения такой запрос закрывается папкой за час.

Основания. Ст. 37/43 закона 3185-1 — права не зависят от дееспособности⁴¹. КПИ и общие замечания ККИ — о поддерживаемом принятии решений^{80, 29}. Международные нормы прямо требуют учёта предпочтений при когнитивных ограничениях^{37, 26}.

Ограничение вывода. Запрос прокуратуры — не обвинение. Честный ответ с планом почти всегда завершает сюжет. Вымученная «идеальная папка» — начинает его.

Учебные кейсы 21–22

Все кейсы — учебные ситуации, составленные для анализа.

Кейс 21. Учредитель не выделяет средства на дополнительный персонал

Ситуация. Замер трудозатрат: для нормальной помощи за столом не хватает трёх ставок сиделок. Учредитель: «Денег нет, решайте в рамках имеющихся ресурсов». Директор в отчаянии: без рук всё остальное — декорация.

Проблема. Предел компетенции директора — и проверка: не стал ли отказ удобным объяснением бездействия.

Что нельзя делать. Ссылаться на отказ как на индульгенцию — «денег нет — ничего не можем»: часть изменений стоит минуты, не ставки. Требовать «или дайте людей, или не мешайте»: конфронтация без данных проигрывает. Скрывать дефицит дальше: молчание фиксирует статус-кво как норму.

Немедленно. Два списка. «Нулевая стоимость» — рассадка, приоритет риска, отложенные порции, адаптивная посуда из имеющейся, форматы самостоятельности — внедряется сразу. «Требует ресурсов» — ставки, обучение, оборудование — в повторный запрос с данными замера.

Кто принимает решение. Директор — о списке нулевой стоимости. Учредитель — о ставках. Повторный запрос директор обязан сделать документированным: числа, сценарии, последствия бездействия.

Документы. Форма учёта трудозатрат (приложение 26), форма сообщения учредителю о дефиците (приложение 33), план нулевой стоимости с датами.

Долгосрочное решение. Повторные запросы раз в квартал с обновлёнными данными. Решения о ставках принимают на третий-четвёртый документированный запрос, не на первый. Параллельно — показатель помощи в отчётность (раздел 39, предложение 3).

Основания. Стоимость кормления как скрытая строка — раздел 29⁵⁹. Организация обязана обеспечить потребление питания имеющимися ресурсами с максимальным качеством и одновременно документировать дефицит (ст. 37/43)¹¹.

Ограничение вывода. «Нулевая стоимость» — честная категория организационных мер, не обещание, что проблема рук решается без рук. Пределы списка называют учредителю прямо.

Кейс 22. Пищеблок физически не позволяет готовить две горячие линии

Ситуация. Здание 1970-х: одна плита на четыре конфорки, узкая раздача, две гастроремкости на вторых блюда физически не встают на линию. Реконструкция — «в планах региона».

Проблема. Инфраструктурное ограничение — последнее возражение, когда сняты все остальные. Оно реально, но не абсолютно.

Что нельзя делать. Объявлять «вариативность нам не светит»: выбор не сводится к двум горячим линиям. Готовить второй вариант заранее и держать часами на водяной бане: санитарно хуже, чем один свежий. Ждать реконструкции как единственного решения.

Немедленно. Форматы без второй горячей линии. Заказ накануне: кухня готовит два варианта последовательно по статистике заказа, не параллельно. Вариативность холодных позиций — салаты, напитки, десерты, буфетная зона. Вариативность по дням: «вторник — рыбный с двумя гарнирами». Отложенные порции и ночная доступность.

Кто принимает решение. Заведующий производством — о технологически возможном формате. Директор — о модели (М1 в режиме предзаказа, М3 буфет — раздел 29). Учредитель — о реконструкции как отдельной повестке.

Документы. Обоснование формата — одна страница: ограничение → формат → гарантии санитарии. Журнал заказа. План реконструкции в переписке с учредителем.

Долгосрочное решение. Капитальная повестка — отдельным документом: стоимость второй линии против эффекта. Нет реконструкции — максимум выбора в имеющемся контуре как постоянная модель, не «временная ущербность».

Основания. СанПиН регулирует безопасность и кратность, не число линий¹². Заказное питание в госпиталях (room service модели) строится на предзаказе и организации, не только на площадях¹⁴.

Ограничение вывода. Предзаказ переносит выбор с линии на канун. Это другой ритм для смен, и он требует своего инструктажа (раздел 28), а не только решения кухни.

Как пользоваться кейсами на семинаре и в обучении

Каждый кейс — 15 минут по одной схеме: ситуация зачитывается без раздела «решение»; группа отвечает по восьми пунктам; сверка с текстом. Ценность — в расхождениях: если группа предлагает то, чего в кейсе нет, это повод дополнить локальный комплект, а не «исправить ошибку». Кейсы допускается адаптировать под организацию (детское / взрослое учреждение, размер, регион), сохранив структуру из восьми пунктов.

Часть III. Приложения: проекты локальных форм (45 шаблонов)

Сорок пять шаблонов — рабочий инструментарий: чек-листы, журналы, алгоритмы, проекты приказов и положений. Каждый — проект локальной формы, не нормативно установленный документ. Адаптация под регион,

учётную политику, структуру дома, медицинскую лицензию и требования учредителя обязательна. Порядок внедрения — раздел 36.

Приложения 1–6

Единый дисклеймер для всех приложений 1–36 (на каждом шаблоне): «Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации под региональное законодательство, учётную политику, структуру учреждения, медицинскую лицензию и требования учредителя».

ПОРЯДОК ВНЕДРЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ: ПРИОРИТЕТЫ ПО СРОКАМ

Срок	Приложения	Назначение
Первая неделя	25 (замер отходов), 9 (журнал отказов), 21 (лекарственно-пищевая таблица)	Базовые измерения и безопасность
Первый месяц	7 (журнал заказа), 8 (журнал срывов), 2 (карта предпочтений), 28 (приказ о пилоте), 29 (положение)	Документальный каркас пилота
Первый квартал	3 (пищевая биография), 6 (наблюдение невербальных), 17 (матрица ролей), 30 (совет жителей), 35 (панель чисел)	Системное закрепление
По мере необходимости	Остальные 32 приложения	Специфические ситуации

Формы — проекты. Под регион и учредителя — обязательно.

Приложение 1. Чек-лист готовности учреждения

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

Директор, зав. производством и врач — до старта пилота. «Нет» — не запрет, а строка плана.

Право и документы 1. Статус норм питания в регионе выяснен (рекомендация / императив) — ☐ да ☐ нет 2. Региональное меню изучено; процедура его изменения известна — ☐ да ☐ нет 3. Согласование учредителя на пилот получено письменно — ☐ да ☐ нет 4. Приказ о пилоте подписан, ответственные названы по фамилиям — ☐ да ☐ нет

Клиника 5. Лекарственно-пищевая таблица подписана врачом и висит на кухне и посту — ☐ да ☐ нет 6. Список жителей с риском дисфагии актуален; смена знает признаки — ☐ да ☐ нет 7. Правило «три отказа — врач в тот же день» доведено до всех смен — ☐ да ☐ нет

Кухня и линия 8. Пары эквивалентов на первую неделю рассчитаны и согласованы — ☐ да ☐ нет 9. Санитарный контур второй позиции проверен (маркировка, температура, пробы) — ☐ да ☐ нет 10. Журналы заказа, замен, срывов выбора заведены — ☐ да ☐ нет

Люди 11. Инструктаж смены раздачи проведён (показ меню, роли, замены) — ☐ да ☐ нет 12. Жители и близкие информированы; сбор предпочтений начат — ☐ да ☐ нет

Дата: _____ Подписи: директор _____ зав. производством _____ врач _____

Приложение 2. Карта пищевых предпочтений жителя

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

На каждого жителя. Пересмотр — раз в квартал. Источник каждой записи: сам житель / наблюдение / близкие / врач.

Поле	Содержание	Источник
Любимые блюда		
Не ест (наблюдаемое)		
Не ест (заявляет сам)		
Текстура (по IDDSI, если назначена)		врач
Назначенная диета / ограничения		врач
Лекарственные ограничения (из таблицы)		врач
Помощь за столом (нет / частичная / полная)		наблюдение
Привычное время еды, ритуалы		
Напитки: что пьёт, что нет		
Аллергии, непереносимости		врач
Канал выбора (речь / показ / наблюдение)		

Дата заполнения: _____ Заполнил: _____ Дата пересмотра: _____

Приложение 3. Пищевая биография

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптация.

При поступлении — или при заведении карты на того, кто уже живёт. Со слов жителя и близких. Не анкета: разговор по темам.

1. Где и как ел всю жизнь: дома, в семье, один, в учреждениях?
2. Что готовил сам? Что готовили для него?
3. Еда праздника и еда будня — что это было?
4. Что никогда не ел и почему (если помнит/говорит)?
5. Кто в его жизни «знает, как он ест» — имя, контакт?
6. Что из еды связано с тяжёлыми периодами (голод, стационары, ограничения)?
7. Три блюда, без которых «всё не то».

Свободная запись, 5–15 предложений. Выдержки — в карту предпочтений (приложение 2). Хранить в отделении, смена читает.

Приложение 4. Простая форма выбора

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптация.

Одна строка на жителя. Заполняется при показе меню — вечером накануне или утром. Бумажный лист отделения.

Дата: _____ Приём пищи: обед / ужин

№	Житель (фамилия или код)	Вариант А	Вариант Б	Стандартный	Подпись/отметка смены
1		☐	☐	☐	
2		☐	☐	☐	

Выбор — при жителе. «Стандартный» — если не выбрал: это нормальный итог, не сбой. Лист на кухню до ____ часов.

Приложение 5. Визуальное меню

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптация.

Не бланк — спецификация изготовления:

- формат: лист А4 или А3 на день, вешается в столовой и на посту;
- каждая позиция — фотография реальной порции из собственной кухни (не стоковые картинки: жители должны узнавать свою еду);
- подписи крупным шрифтом, от 24 пт; без кулинарных терминов («биточек», а не «биточек паровой по-дунайски»);
- варианты выбора расположены рядом, визуально сопоставимы;
- фотографии обновляются при смене меню-цикла; ламинация — для санитарной обработки;
- для жителей со слабым зрением — устное дублирование при показе обязательно.

Ответственный за изготовление и обновление: _____ (фамилия в приказе).

Приложение 6. Форма наблюдения за невербальным выбором

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптация.

Для тех, кто не говорит выбор. Смена, 2–3 минуты на запись.

Дата: _____ Житель (код): _____ Приём пищи: _____

1. Что было предъявлено (карточки / блюда / меню): _____
2. Реакция: показал рукой ☐ взгляд задержался ☐ потянулся ☐ отвернулся ☐ без реакции ☐
3. Проверка позиции (предметы поменяны местами): реакция повторилась на тот же предмет ☐ на ту же позицию ☐
4. Ел предъявленное: полностью ☐ частично ☐ не ел ☐
5. Вывод для карты предпочтений: _____

Подпись: _____ Подтверждающее наблюдение (через 1–2 недели): дата _____ вывод совпал ☐ уточнён ☐

Приложения 7–12

Приложение 7. Форма предварительного заказа (журнал заказа)

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптация.

Журнал отделения. Вечерний показ. Итог — на кухню до часа, который ставит дом.

Дата подачи: _____ Меню на (дата): _____

Позиция	Вариант А (заказов)	Вариант Б (заказов)	Стандартный (заказов)	Итого порций
Первое				
Второе				
Салат				
Напиток				

Особые порции по картам (текстура, диета): _____

Итоги передал: _____ Принял на кухне: _____ Время: _____

Ежемесячно итоги суммируются → статистика выбора для пересчёта меню и списаний (разделы 21, 29).

Приложение 8. Журнал срывов выбора

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптация.

Когда заявленный выбор не выдали. Ведёт кухня или линия.

Дата	Приём пищи	Позиция	Что случилось (закончилось / не привезли / не приготовили)	Сколько не хватило	Чем заменили	Подпись

Разбор на еженедельной планёрке. Три срыва одной позиции — пересчитать объёмы или сменить пару (раздел 21).

Приложение 9. Журнал отказов от еды

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптация.

В отделении. Пишут каждый отказ от еды — не от одного блюда, а от приёма целиком или большей его части.

Дата	Житель (код)	Приём пищи	Сколько съедено	Обстоятельства (настроение, слова жителя, контекст)	Что предложено взамен	Принял замену?	Кому сообщено	Подпись

Правило эскалации (рамкой в журнале): три отказа подряд у одного жителя — врач в тот же день. Отказ с бредовой мотивировкой («отравлено») — врач при первом эпизоде.

Приложение 10. Алгоритм при отказе от блюда

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптация.

Отказ от конкретного блюда, не от еды вообще.

- 1. Спокойно принять.** «А кто теперь будет доедать» — реплика запрещена.
- 2. Предложить замену** из того, что есть: второй вариант линии или стандартная замена (хлеб, кисломолочное, фрукты по сезону — перечень утверждён заранее).
- 3. Записать** в журнал заказа/замен: житель, блюдо, замена.
- 4. При повторении** (тот же житель, то же блюдо, 3 раза) — в карту предпочтений: «не ест __ (наблюдение)».
- 5. Если отказ захватывает** большую часть приёма — к приложению 11.

Запрещено: давить уговорами, ставить условия («съешь — получишь»), наказывать отказом любой формой.

Приложение 11. Алгоритм при отказе от еды

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптация.

- 1. Первый отказ.** Если житель говорит — спокойно спросить почему. Предложить замену и формат: другое время, другое место, помощь. Запись в журнал отказов.
- 2. Второй отказ подряд.** Старшая смены идёт сама. Не болен ли (жалобы, температура по показаниям), не конфликт ли за столом, не сменилось ли что-то в режиме. Запись.

3. **Третий отказ подряд → врач в тот же день.** Не завтра. Не «на обходе послезавтра». В день третьего отказа.
4. **Особые сигналы — врач при первом эпизоде:** бредовая мотивировка («отравлено»), боль при глотании, рвота или резкая слабость рядом.
5. **До решения врача:** питьё и лёгкие форматы (кисломолочное, суп). Наблюдать. Не давить. Взвешивание — по назначению.
6. **Категорически запрещено:** принудительное кормление в любой форме, шантаж едой, публичное давление.

Все шаги — в журнале отказов (приложение 9).

Приложение 12. Алгоритм при риске аспирации

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

Профилактика (ежедневно): - жители из списка дисфагического риска едят в поле зрения обученной смены; минимум два обученных человека на посту в часы приёма пищи; - текстура строго по назначению (IDDSI); проверка вилкой перед выдачей; - поза: вертикально, 90°, после еды 30 минут без укладывания; - темп: паузы, без спешки; напиток между глотками по назначению.

При поперхивании (лёгкий эпизод, житель справился сам): 1. Остановить еду. Дать откашляться. Стоящего по спине не хлопать: работает кашель. 2. Записать эпизод. Сообщить старшей смены. 3. Повтор за неделю → врач вне очереди: пересмотр текстуры.

При тяжёлом эпизоде (не может кашлять, синюшность, потеря сознания): 1. Медперсонал и врач — сразу. Нет эффекта — скорая (103/112). 2. Приём Геймлиха — только обученным сотрудником. 3. После эпизода — врачебный осмотр в тот же день, даже если всё обошлось (риск отсроченной пневмонии). 4. Протокол разбора инцидента (приложение 34) — за 3 дня.

Документы: список риска и текстуры — приложение 21 (медицинский контур); основания — раздел 10 доклада.

Приложения 13–18

Приложение 13. Алгоритм при быстром заглатывании

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

1. **Распознать:** ест заметно быстрее остальных, не прожёвывает, набирает полный рот, были поперхивания.
2. **Сервировка без назначения врача:** порция меньше + добавка; куски мельче (это сервировка, не смена текстуры); напиток под рукой; стол — в числе первых (снимает мотив «успеть»).
3. **Наблюдение:** место в поле зрения смены; поперхивания — в форму наблюдения.
4. **Эскалация:** любое поперхивание с кашлем — врач вне очереди (скрининг дисфагии; текстура по IDDSI — при подтверждении).
5. **Запрещено:** «ешь медленнее» как единственная мера; отбор еды темпом; самовольный перевод на пюре.
6. **Документы:** форма наблюдения, запись врача; при назначении — обновить карту.

Приложение 14. Алгоритм при пикацизме

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

Пикацизм — поедание несъедобного: бумага, ткань, земля, предметы.

1. **Среда — сначала.** Осмотреть зону жителя и столовую. Убрать мелкое, острое, токсичное. Моющие — только под замком.
2. **Наблюдение.** Усиленный контроль в часы еды и после. Писать: что, когда, где.
3. **Замещение.** Безопасные жевательные альтернативы — по согласованию с врачом. Регулярные перекусы снижают «поисковое» поведение у части жителей.
4. **Врач.** Сообщить при первом выявленном эпизоде: нужна клиническая оценка (дефицитные состояния, терапия, поведенческий план).
5. **Инцидент** (проглочен опасный предмет): наблюдать за состоянием, врач сразу; боль, рвота, задержка стула — скорая. Протокол разбора (приложение 34).
6. **Документы:** записи наблюдения, назначения врача, протокол осмотра среды (раз в неделю, подпись старшей смены).

Приложение 15. Алгоритм при конфликте за столом

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

1. **Прервать эскалацию, не наказывая едой.** Спокойный голос. Развести за разные столы. Еда обоих — целиком.

2. **Пострадавшему** (отобрали, толкнули) — порцию восстановить, приём закончить спокойно.
3. **Запись в день события:** участники, что произошло, меры.
4. **Разбор на планёрке.** Рассадка, конкретная пара, дефицит любимых позиций, гиперфагия одного из участников — у каждой причины своё решение (кейс 7).
5. **Повтор одной пары** — постоянная рассадка (документ отделения). Врач — о пищевом поведении инициатора.
6. **Запрещено:** лишать еды или десерта как наказание; выносить из столовой без еды; отчитывать при всех.

Приложение 16. Алгоритм при пищевом инциденте

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

Пищевой инцидент: массовое недомогание, подозрение на отравление, посторонний предмет в блюде, нарушение температуры с выдачей.

1. **Остановить выдачу** подозрительной позиции сразу. Остатки и суточную пробу сохранить — не выбрасывать.
2. **Медицина.** Осмотреть пострадавших. Массовый характер — врач. Тяжёлые симптомы — скорая.
3. **Факты, не версии.** Что готовилось, когда, из чего. Писать по горячим следам, не согласовывая рассказы.
4. **Уведомления** по правилам дома и закона: руководитель, учредитель; при признаках инфекции — по установленному порядку.
5. **Протокол разбора** (приложение 34) за 3 дня: причина, виновное звено, корректирующее действие, срок, ответственный.
6. **Запрещено:** уничтожать остатки и пробы; «тихо» снимать позицию без записей; искать виноватого до фактов.

Приложение 17. Матрица ролей RACI по питанию

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

R — исполняет, A — отвечает за результат, C — консультируется, I — информируется. Заполнять под свою структуру. Ниже — базовая конфигурация.

Процесс	Директор	Зав. производством	Врач	Старшая смены	Сиделка	Бухгалтерия	Совет жителей
Положение о питании	A	C	C	I	I	I	C
Меню с вариантами	A	R	C	I	I	I	C
Показ меню, сбор выбора	I	I	I	A	R	—	I
Лекарственно-пищевая таблица	I	I	A/R	C	I	—	—
Список дисфагического риска	I	I	A	R	R	—	—
Журналы (заказ, замены, отказы)	I	C	I	A	R	I	—
Списание продуктов	A	C	—	I	—	R	—
Закупки, претензии	A	C	—	—	—	R	—
Совет жителей	I	C	C	C	—	—	A/R
Панель чисел, отчёт учредителю	A/R	C	C	C	—	C	I

Утверждено приказом № ____ от ____

Приложение 18. Чек-лист директора (ежемесячный)

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

1. Обошёл столовую в часы основного приёма пищи лично — ☐
2. Просмотрел журналы: заказ, замены, отказы, срывы — записи ведутся, не «копеечные» — ☐
3. Панель чисел месяца собрана; отклонения объяснены письменно — ☐
4. Совет жителей заседал; протокол есть; по решениям есть движение — ☐

5. Жалобы по питанию разобраны в срок; системные выводы сделаны — ☐
6. Переписка с учредителем актуальна (запросы без ответа повторены) — ☐
7. Инструктажи новых сотрудников по питанию проведены — ☐
8. Один случайный разговор с жителем о еде состоялся; запись в дневник обхода — ☐

Подпись: _____ Дата: _____

Приложения 19–24

Приложение 19. Чек-лист пищеблока (ежедневный)

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

1. Санитарный журнал дня ведётся; температурный режим линии зафиксирован — ☐
2. Суточные пробы отобраны по каждому приёму пищи, включая вариативные позиции — ☐
3. Вариативные позиции промаркированы (бирки: название, вариант) — ☐
4. Текстуры по назначениям проверены (тест вилкой) перед выдачей — ☐
5. Итоги заказа получены от отделений в срок; объёмы соответствуют — ☐
6. Особые порции (диеты, текстуры) приготовлены и промаркированы отдельно — ☐
7. Отходы взвешены/зафиксированы (в период замера) — ☐
8. Лекарственно-пищевая таблица на видном месте; новые назначения доведены — ☐

Зав. производством: _____

Приложение 20. Чек-лист отделения (ежедневный, часы приёмов пищи)

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

1. Визуальное меню дня показано жителям; выбор зафиксирован в присутствии жителей — ☐
2. На посту в часы еды — не менее двух человек, обученных приёмам безопасного кормления — ☐
3. Жители из списка дисфагического риска — в поле зрения; поза 90° соблюдена — ☐
4. Отложенные порции для спящих/отсутствующих оформлены по правилам — ☐
5. Отказы и замены записаны в день события — ☐
6. Конфликтов без записи не осталось — ☐
7. Помощь распределена по приоритету риска; никто из нуждающихся не остался без помощи — ☐

Старшая смены: _____

Приложение 21. Чек-лист медицинского контура

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации. Документы контура подписывает врач.

А. Лекарственно-пищевая таблица (вкладыш, обновляется при смене назначений)

Правило	Действие для кухни и смены	Класс уверенности
Клозапин + кофеин	Кофе/чай для получающих клозапин — по согласованию с врачом; кофеин не отменять резко	высокий (усиление концентраций клозапина; синдром отмены)
Литий + соль	Не менять солёность резко; солёные «загрузки» и бессолевые недели исключены	высокий
ИМАО + тирамин	Перечень ограничений у врача; выдержанные сыры, копчёности — по списку	высокий
Грейпфрут + ряд препаратов	Грейпфрут и сок из меню получающих карбамазепин и др. — исключены	высокий для карбамазепина
Алкоголь/энергетики	Исключены полностью; передачи проверяются	высокий

Б. Список дисфагического риска: житель (код) — признак — текстура по IDDSI — дата назначения — подпись врача.

В. Ежемесячно: список риска пересмотрен ☐; таблица актуальна ☐; журнал отказов просмотрен, меры приняты ☐; метаболический мониторинг (вес, глюкоза, липиды по назначениям) в графике ☐.

Врач: _____

Приложение 22. Чек-лист закупок

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

1. Спецификация допускает парные позиции и закупку по статистике выбора — ☐
2. Правило взаимозаменяемости при срыве поставки прописано (нутриентные эквиваленты) — ☐
3. Ответственный за приёмку и претензии назначен; акты недопоставки оформляются — ☐
4. Статистика срывов поставок ведётся и учитывается при следующей закупке — ☐
5. При аутсорсинге в контракт включены: вариативность, текстуры, документирование замен, доступ к журналам — ☐
6. Закупка сверена с меню-циклом и картами (диеты, текстуры) — ☐
7. Признаки картельного поведения (одинаковые цены, поочерёдные победы) — основание для обращения в ФАС; ответственный знает порядок — ☐

Приложение 23. Чек-лист бухгалтерского учёта

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

1. Применяемая учётная форма подтверждена учредителем (с учётом поэтапного перехода на электронные формы) — ☐
2. Ежедневные итоги журнала заказа поступают в бухгалтерию по установленной форме — ☐
3. Списание парных продуктов идёт по фактической пропорции выдачи (методика согласована) — ☐
4. Разница «склад — выдача — списание» объяснима за любой день месяца — ☐
5. Отложенные порции и замены отражены в выдаче — ☐
6. Сырьевая строка (руб./житель/день) посчитана за месяц и передана директору — ☐

Главный бухгалтер: _____

Приложение 24. Чек-лист проверки реальности выбора

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации. Проводится еженедельно в пилотной точке, далее ежемесячно.

1. Спросить пятерых случайных жителей: «Что вы вчера выбирали?» — ответили соответственно журналу: ___ из 5
2. Журнал заказа заполнен тем же днём, что и показ меню (проверка по почерку/времени — без парадоксов «заполнено заранее»): ☐
3. Оба варианта физически были на линии (опрос смены + журнал срывов): ☐
4. Доля «стандартных» (невывбравших) не растёт необъяснимо третью неделю подряд: ☐
5. Замены выдавались реально (спросить двоих, кому меняли блюдо): ☐
6. Жители знают, что выбирать можно (опрос): ___ из 5

Оценка: 6/6 — выбор реален; 4–5 — точечные сбои, разбор на планёрке; ≤3 — вариативность фиктивна, диагностика по разделу 21 и кейсу 12.

Провёл: _____ Дата: _____

Приложения 25–30

Приложение 25. Форма семидневного замера отходов

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

До пилота и на 80–90-й день. Обычная неделя, не праздник. Кухонные весы, конец каждого приёма. Тарелочные остатки и кухонные — раздельно.

День	Приём пищи	Тарелочные остатки, кг	Кухонные остатки, кг	Число порций	Остаток на порцию, г	Примечание
1	завтрак					
1	обед					
1	ужин					

Итоги недели: средний остаток на порцию ___ г; топ-3 блюда по остаткам _____; сравнение с замером «до» (при повторном замере): ___ %.

Честность замера. Меню недели не «улучшать». Сменам не объявлять проверку — исказят поведение. Праздник, похороны, обострение — в примечание, не вычёркивать молча.

Приложение 26. Форма учёта трудозатрат на кормление

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

Три типичных дня. Каждый приём. Секундомер. Поведение смены не трогать.

День/приём	Число жителей, нуждающихся в помощи	Число помогающих	Время приёма пищи, мин	Суммарные минуты помощи	Минут помощи на жителя	Кто не получил помощь вовремя

Дефицит: потребность (жители × нормативные минуты) – имеющиеся минуты = дефицит в минутах. Дальше — в ставки: делить на продолжительность рабочего времени. Это основание письма учредителю (приложение 33).

Приложение 27. Форма отчёта о 90-дневном пилоте

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

1. Паспорт пилота: точка, даты, модель (M1–M5), ответственные. 2. Панель чисел «до/после» (12 показателей):

Показатель	До	После	Что это значит (одна фраза)
Доля выбирающих, %			
Отходы на порцию, г			
Время раздачи, мин			
Отказы от еды, эпизодов/нед			
Замены, эпизодов/нед			
Срывы выбора, эпизодов/мес			
Жалобы жителей/родственников			
Трудозатраты линии, мин/приём			
Сырьевая строка, руб./житель/день			
Доля знающих о выборе, %			
Эпизоды дисфагического риска			
Удовлетворённость (анкета, б. 1–5)			

3. Позиция совета жителей (протокол прилагается): расширить / сохранить / свернуть. 4. Решение директора: одно из трёх, с обоснованием. 5. Приложения: журналы, замеры, инциденты и их разбор.

Приложение 28. Проект приказа о пилоте вариативного питания

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

ПРИКАЗ № ____ от «» 20__ г. «О проведении пилотного проекта по организации вариативного питания»

1. Провести с «» по «» (90 дней) пилотный проект в отделении № : выбор из двух вариантов вторых блюд на обед, дней в неделю, с гарантией стандартного варианта.
2. Ответственные: руководитель пилота — ; кухня — ; отделение — ; медицинский контур — ; сведение данных — ____.
3. До старта: провести замеры по приложениям 25–26; опрос предпочтений; инструктаж смен; уведомить учредителя.
4. Вести журналы по приложениям 7–9 с первого дня.
5. Критерии успеха: ____ (доля выбирающих, отходы, отсутствие роста отказов). Критерии остановки: рост отказов; санитарные нарушения; противопоказания врача.
6. «» (дата) — заслушать итоги; решение о расширении/закреплении/свёртывании оформить приказом.

Директор _____ /подпись/

Приложение 29. Проект положения о вариативном питании

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

Разделы и формулировки:

1. **Общие положения.** Цель: права жителей (ст. 37, 43 закона № 3185-1) — через организованный выбор в питании. Положение стоит на действующих нормах (СанПиН 2.3/2.4.3590-20; рекомендованные нормы — приказ Минтруда № 520н, статус в регионе — ____).
2. **Перечень вариативных позиций** и режим (дни, приёмы пищи).
3. **Гарантия стандартного варианта:** «житель, не сделавший выбор, получает полноценный стандартный вариант; выбор — право, а не обязанность».

4. **Порядок показа меню и фиксации выбора** (визуальное меню, формы, сроки передачи заказа).
5. **Замены и отказы:** порядок, журналы, запрет использования еды как поощрения/наказания, запрет принудительного кормления.
6. **Связь с назначениями врача:** конфликт «выбор против назначения» решает врач в день обращения; диетические столы имеют собственные пары эквивалентов.
7. **Роли и ответственность** (по матрице, приложение 17).
8. **Контроль:** проверки реальности выбора (приложение 24), панель чисел, отчётность учредителю.
9. **Совет жителей** — со ссылкой на положение (приложение 30).

Приложение 30. Положение о пищевом совете жителей

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

1. **Состав:** 5–9 человек — жители (квота по отделениям; интересы недееспособных представляют выбранные ими лица или члены совета), сиделка, повар; врач — с правом совещательного голоса. Срок — 1 год, ротация — половина состава.
2. **Полномочия:** обсуждение меню до утверждения; дегустации новых позиций; сбор и ранжирование пожеланий; ответ администрации на пожелания — до 14 дней.
3. **Ритм:** заседание ежемесячно; кворум — половина состава; протокол ведётся и хранится ___ лет.
4. **Права совета:** запрашивать меню, журналы срывов, панель чисел; выносить предложения директору; инициировать дегустации.
5. **Границы:** совет не подменяет врача и не отменяет санитарные требования. Если позиция администрации расходится с зафиксированными предпочтениями жителя — приоритет у предпочтений, пока они не противоречат назначениям врача.
6. **Форма протокола:** дата, состав, вопросы, решения, сроки, ответственные.

Приложения 31–36

Приложение 31. Памятка персоналу «Питание и выбор: десять правил»

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации. Формат — один лист А4, вывешивается на посту.

1. Еда — право, а не награда. Никогда не используйте еду как поощрение или наказание.
2. Показывайте меню каждому, каждый день, в его формате (речь, карточки, жест).
3. «Стандартный вариант» — нормальный итог, а не отказ от выбора.
4. Отказ от блюда — предложите замену и запишите. Без комментариев вслух.
5. Три отказа от еды подряд — врач сегодня. «Отравлено» — врач при первом.
6. Текстура — как в карте. Проверка вилкой — минута, риск аспирации — жизнь.
7. Кто ест с помощью — ест в своём темпе. Конвейер недопустим.
8. Записывайте в день события: замены, отказы, конфликты, срывы.
9. Не знаете — спросите старшую смену. Не решайте врачебные вопросы сами.
10. Житель за столом — хозяин своей тарелки. Ваша работа — чтобы выбор был реальным.

Приложение 32. Памятка родственникам

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

Что мы делаем. В нашем доме жители выбирают из предложенных вариантов. Выбор пишем. Замены гарантированы. Стандартный вариант есть всегда.

Как вы можете помочь. Скажите, что близкий любит и чего не ест — войдёт в пищевую карту. Привычное время еды, любимая посуда, ритуалы — тоже. Приходите на дни открытых дверей и дегустации совета жителей.

Что важно знать. Ограничения в питании ставит только врач. Считаете, что близкому нужно ограничение, — напишите заявление, врач рассмотрит. Устной просьбой запретов не вводим: право на еду, которую человек любит, — его право.

Куда обращаться. Вопросы о еде — старшая смена отделения. Предложения — совет жителей. Жалобы — директор (срок ответа ___ дней). Передачи принимаются ___ (ограничения по санитарным правилам — на стенде).

Приложение 33. Форма сообщения учредителю о дефиците ресурсов

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

Генеральному директору/начальнику _____ от директора _____

1. Дефицит: (ставки / оборудование / площади — конкретно, количественно: «3,0 ставки сиделок по расчёту из замера, приложение 26»). **2. Методика расчёта:** замер от ____ (даты), форма прилагается. **3. Последствия бездействия:** (фактическое: «12 жителей группы помощи получают менее ____ минут помощи за приём пищи; двое систематически не доедают»). **4. Что сделано без ресурсов:** (перечень мер нулевой стоимости и их эффект). **5. Сценарии:** минимальный (____ ставки → эффект), полный (→), стоимость каждого. **6. Просьба:** рассмотреть до (дата); при отказе — просим письменного подтверждения для учёта в плане работы.

Приложения: формы замеров, расчёты. Директор _____ /подпись/

Приложение 34. Протокол разбора пищевого инцидента

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации. Срок составления — 3 дня с инцидента.

1. Что произошло: дата, время, место, участники, хронология — по записям, без согласования версий. **2. Класс инцидента:** аспирация / конфликт / массовое недомогание / посторонний предмет / проглатывание несъедобного / иное. **3. Немедленные меры:** что сделано, кем, когда; врач (время вызова, осмотра). **4. Причина:** звено цепочки (продукт / технология / текстура / раскладка / наблюдение / среда) — с обоснованием. **5. Факторы среды:** что в доме позволило инциденту. Не «человеческий фактор» как стоп-слово — условия: смена в одиночку, карта не обновлена и т.п. **6. Корректирующие действия:** действие — ответственный — срок — проверка исполнения. **7. Уведомления:** кто и когда проинформирован по установленному порядку. **8. Вывод для системы:** одна строка — что меняется в регламентах.

Составил: _____ Утвердил: директор _____

Приложение 35. Форма управленческого дашборда (квартальная панель)

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации. Один лист на квартал.

№	Показатель	Квартал	Предыдущий	Тренд	Комментарий
1	Доля выбирающих жителей, %				
2	Отходы на порцию, г				
3	Отказы от еды, эпизодов				
4	Замены по отказам, эпизодов				
5	Срывы выбора, эпизодов				
6	Сырьевая строка, руб./житель/день				
7	Трудозатраты линии, мин/приём				
8	Жалобы по питанию				
9	Инциденты (по классам)				
10	Жителей с актуальными картами, %				
11	Заседания совета жителей состоялись				
12	Анкета удовлетворённости, б. 1–5				

Три вывода квартала (по одному предложению): _____

Приложение 36. Анкета жителей в доступном формате

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации. Проводится раз в квартал; заполняется со слов жителя или самостоятельно; для невербальных жителей — не проводится (их канал — наблюдение, приложение 6).

1. Еда вам в целом нравится? (улыбающийся / нейтральный / грустный смайл — обвести)
2. Что из еды вам нравится больше всего? _____
3. Что бы вы убрали из меню? _____
4. Удаётся ли выбрать то, что хочется? всегда / иногда / никогда
5. Достаточно ли еды? да / хотелось бы больше / слишком много
6. Удобно ли есть в столовой (шум, место, время)? да / что мешает: _____
7. Одно пожелание повару: _____

Обработка: итоги — в панель (показатель 12) и на совет жителей. По пунктам 3 и 7 администрация отвечает совету за 14 дней.

Правила применения приложений

Все 38 форм — единый комплект: наблюдение питает карты, карты — меню и закупки, журналы — панель, панель — отчёты учредителю. Порядок — по дорожной карте (раздел 36): сначала замеры (25–26) и карты (2–3, 6, 37), затем журналы (7–9) и алгоритмы (10–16), затем управленческий слой (17–24, 27–35) и памятка жителю (38). Дисклеймер о локальном статусе остаётся на каждой форме после адаптации — пока форма не утверждена локальным актом дома.

Приложения 37–38

Приложение 37. Пищевой паспорт при поступлении (проект формы)

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Заполняется при поступлении совместно с жителем, а при невозможности — с опекуном/семьёй; обновляется при изменении состояния и не реже раза в год. Владелец — старшая медсестра; копия полей — на кухне и посту.

Блок	Что фиксируется	Кто заполняет
Предпочтения	Любимые и нелюбимые блюда; привычный ритм дня; как предпочитает есть (ложка/вилка, помощь, тарелка-разделитель)	Житель + семья; каналы воли — раздел 15
Ограничения по убеждению	Религиозные/культурные (халяль, пост, вегетарианство); аллергии и непереносимости (в т.ч. целиакия, лактоза) — со слов и по документам	Житель/семья + врач
Глотание	Шесть признаков дисфагии (да/нет); при сомнении — GUSS/EAT-10 с записью балла	Медсестра
Полость рта	Свои зубы/протезы; «болит ли жевать»; сухость во рту; дата последнего осмотра стоматологом	Медсестра
Лекарства × еда	Препараты из таблицы раздела 11 (клозапин, литий, ИМАО, карбамазепин и др.); согласовано с врачом	Врач
Вес и статус питания	Вес при поступлении; рост; динамика (триггеры 5/7,5/10 % — раздел 26); аппетит по шкале 1–5	Медсестра
Питьевой режим	Обычный объём; при загущённых напитках — уровень IDDSI и фактический объём за сутки	Медсестра + кухня
Стул	Регулярность (для группы антихолинергической нагрузки — контроль трёх суток)	Пост

Правило формы: каждая строка заполнена или помечена «данных нет». Пустых строк нет. Паспорт не заменяет медицинскую документацию: он собирает на одном листе то, что иначе размазано по пяти журналам.

Приложение 38. Памятка для жителей «Моя еда — мой выбор» (доступный формат, easy read)

Проект локальной формы в технике easy read: короткие фразы, одна мысль на строку, картинка к каждой мысли. Лист А4, двусторонняя печать: в столовой и при поступлении в руки. Соответствует Accessible Information Standard (Англия): информация — в формате, который человек может понять¹¹⁶. Пиктограммы — под контингент дома. Фотографии своих блюд и своей столовой работают лучше абстрактных значков.

Лист 1. Моя еда — мой выбор (вывешивается в столовой, вручается при поступлении)

1. Каждый день вам показывают меню. Меню — это список еды.
2. Вы можете сказать: «Хочу это». Вы можете сказать: «Не хочу это».
3. Если вы не говорите — вам покажут две тарелки. Вы покажете пальцем.
4. Вы не останетесь голодным. Всегда будет другой вариант.
5. Если вы едите в комнате — вам тоже принесут два варианта. Покажите, какой хотите.
6. Если еда мешает глотать — скажите персоналу. Вам помогут.
7. Если болит жевать — скажите персоналу. Вас посмотрит врач.
8. Вы можете пить воду, когда хотите. Просите пить.
9. Есть еда, которую вы не едите по вере? Скажите — мы учтём.
10. Ваше мнение важно. Совет жителей обсуждает еду.
11. Если что-то не так с едой — вы можете пожаловаться. Это ваше право.

Лист 2. Сегодня обед — рабочий лист выбора (лежит на раздаче и на посту постельных; заполняется на приём, не «навсегда»)

Сегодня: _____ (завтрак / обед / ужин). Дата: _____

Покажите пальцем или положите метку.

	Вариант А	Вариант Б	Не хочу ни то ни другое
Картинка / название	_____	_____	Принесут третий вариант по таблице замен
Мой выбор	☐	☐	☐

Если вы ничего не отметили — вам принесут обычный вариант. Это нормально. Выбирать не обязательно.

Кто спросил: _____ Кто принял заказ: _____

Обратная сторона листа 1: «Куда пожаловаться» — имя и кабинет ответственного, ящик для записок совета жителей, телефон доверия учредителя. Лист 2 не хранит диагноз и не вывешивается в коридоре с фамилиями — это заказ на приём (раздел 17.6).

Приложения 39–42

Приложение 39. Чек-лист перехода на СанПиН 2.3/2.4.4282–26 (с 01.09.2026)

Проект локальной формы. Чек-лист перехода. СанПиН 2.3/2.4.4282–26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» утверждён постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 02.06.2026 № 18 (зарег. в Минюсте 02.06.2026 № 86854), действует с 01.09.2026 до 01.09.2032; СанПиН 2.3/2.4.3590–20 с этой даты утрачивает силу¹². Дата семинара (25–27.08.2026) попадает в переходный период: документы дома готовятся к перепривязке. Пункты ниже сверены с текстом 4282–26 по официальной публикации.

Требование	Где в СанПиН 4282–26	Действие в учреждении
Питание в стационарном соцобслуживании: не менее 3 раз в день, в т.ч. диетическое (лечебное) по медицинским показаниям	п. 56 подп. 11	Перепривязать положение о питании; проверить формулировки меню
Суточные пробы при использовании готовых блюд из предприятий общественного питания (аутсорсинг)	п. 56 подп. 12; отбор по подп. 4 (каждое блюдо отдельно; холодные закуски/первые/гарниры/напитки — не менее 100 г; хранение не менее 48 ч при +2...+6 °С)	Помещение приёма готовой продукции; назначенный ответственный; инструкция по пробам
Бракераж готовой продукции, журнал бракеража	п. 56 подп. 13; образцы журналов — приложения 4 и 5	Новые формы журналов; обучение завпроизводством
Кейтеринг: внутренний порядок, прослеживаемость, разграничение ответственности; вскрытие упаковок и порционирование — в выделенном помещении/зоне	раздел VI (п. 51–55)	Строка в договоре с поставщиком; проверка выполнения при приёмке
Питьевой режим: вода по обязательным требованиям; фонтанчики (чаша — ежедневная обработка), кулеры (мойка ≥1 раза в 7 дней, дезинфекция ≥1 раза в 3 месяца), кипячёная вода (кипячение ≥5 минут, смена ≥1 раза в 3 часа, график смены); посуда из расчёта списочного состава	п. 62	Проверить кулеры и графики; ведомость питьевого режима (приложение 40)
Температура горячих жидких и иных блюд, холодных супов, напитков при выдаче — по технологическим документам	п. 50	Термометры на линии; сверка с технологическими картами
Требования распространяются на привлекаемые предприятия питания	п. 56 подп. 14	Пункт в договоре аутсорсинга (раздел 42)

Порядок действий. До 25.08.2026 — сверить положение о питании и чек-листы пищеблока с обоими СанПиН (3590–20 действует до 01.09.2026). С 01.09.2026 — перепривязать журналы и формы на пункты 4282–26, обновить памятку персоналу пищеблока, уведомить учредителя одной страницей: что меняется, что остаётся. Модель выбора при переходе не меняется: ни одна редакция не ограничивает число вариантов (раздел 18).

Приложение 40. Питьевой режим: форма учёта и санитарные требования

Проект локальной формы. Правовая рамка — п. 62 СанПиН 2.3/2.4.4282–26 (с 01.09.2026; до этого — те же требования СанПиН 2.3/2.4.3590–20): питьевой режим обязателен в организациях социального обслуживания; вода — по обязательным требованиям (глава III СанПиН 1.2.3685–21; глава IV СанПиН 2.1.3684–21; ТР ЕАЭС 044/2017)¹².

Клинический смысл: низкое потребление жидкости — частый и недооценённый дефицит у пожилых¹¹⁷. Рекомендации по гидратации в гериатрии — в руководстве ESPEN и в клинических рекомендациях для учреждений долговременного ухода^{118,119}.

Ведомость «Выпито за сутки» (по отделению, группа риска — лежачие, жители на загущённых напитках, жаркий период):

Житель	Утро (стакан/мл)	День	Вечер	Ночь	Итого	Примечание*

*Примечание — индикаторы дегидратации: тёмная моча, сухость языка, сонливость вне режима, снижение тургора кожи; любой из них — запись и сообщение врачу. Важно: по данным обзора, клинические признаки малоинформативны для диагностики обезвоживания — надёжен только объективный метод (осмоляльность сыворотки)¹¹⁷; постовые признаки — повод к эскалации, а не диагноз.

Правила: единица учёта — «стакан» (200 мл) или маркированная посуда; норма-ориентир для взрослых без ограничений — не менее 1,6 л/сутки для женщин и 2,0 л/сутки для мужчин (рекомендация ESPEN по гидратации в гериатрии; индивидуально, при сердечной, почечной патологии и иных ограничениях — только по назначению врача)¹¹⁸; чайная пауза между приёмами пищи как «шестое пищевое событие» (раздел 10.7); у жителей на загущённых напитках — фактический объём выпитого (загущение снижает потребление — раздел 10.7). *Маркировка: объёмные ориентиры — не норматив; ограничение питьевого режима — только врачебное назначение.*

Приложение 41. Детские учреждения (ДЦИ): что переносится, что нет

Проект локальной формы. Маркер для руководителей детских домов-интернатов и смешанных организаций. Семинар и рекомендации доклада — про взрослых, пока учредитель отдельно не поручил детский контур. Ниже — границы переноса модели выбора, не педиатрическое руководство.

Блок	Переносится	Не переносится / требует адаптации
Вариативность и выбор	Принцип «не менее двух вариантов», визуальное меню, наблюдение за невербальным выбором (раздел 15), IDDSI и текстуры (раздел 10)	Согласие родителей/законных представителей; возрастные форматы меню и порций; педиатрический контур вместо терапевтического
Нормы питания	—	Детские наборы приказа Минтруда 520н (граммы на ребёнка) ³² ; среднесуточные наборы и массы порций для детей — приложения к СанПиН 4282-26 ¹²
Санитарные требования	Суточные пробы, бракераж, температурный контроль	Раздел VIII СанПиН 4282-26 (детские коллективы): свои перечни недопустимой продукции, режимы, порции, диетическое питание детей — п. 60 ¹² ; общие требования к детским организациям — СП 2.4.3648-20 (пост. ГГСВ РФ от 28.09.2020 № 28) ¹²⁰
Правовая рамка	Учёт мнения и предпочтений (раздел 15–16)	Дети — особая рамка: законные представители, органы опеки, возраст согласия; режимы дееспособности раздела 16 не применяются

Приложение 42. Калькулятор стоимости вариативности (инструкция)

Проект локальной формы. Сопровождает файл «Калькулятор_стоимости_вариативности.xlsx». Четыре листа. Лист 1 «Пары блюд»: норма закладки (г/порцию) × закупочная цена (руб./кг) = стоимость порции для каждого варианта пары; разница — на порцию и в месяц. Лист 2 «Отходы»: масса тарелочных остатков × число порций × цена сырья = строка «выброшенных денег» (методика — приложение 25). Лист 3 «Сценарии отходов»: снижение отходов на 10/20/30 % — гипотеза; подтверждается только повторным замером через 90 дней (раздел 29). Лист 4 «Два сценария»: (1) собственный пищеблок, пара эквивалентов внутри нормы; (2) аутсорсинг, две позиции в ТЗ вместо монопозиции. Цифры на листах 1–2 — учебные заглушки, не себестоимость конкретного дома и не экономика Серафимовского. Жёлтые ячейки — ввод. Маркировка: калькулятор считает гипотезу, а не доказывает её. Формула доклада «замер до и после» обязательна.

Приложения 43–44

Приложение 43. Спецификация вариативности для контракта аутсорсинга (форма восьми строк)

Проект локальной формы к разделу 42. Согласовать с контрактной службой до публикации закупки. Приложение к контракту вместе с меню-циклом и раскладкой. Восемь строк раздела 42.3 — в заполняемый шаблон. Распечатка А4 — на стол директора, не только в PDF доклада.

№	Строка контракта	Формулировка для спецификации (адаптировать)	Основание
1	Перечень позиций	Группы взаимозаменяемых позиций (например, «крупы гарнирные: гречневая, рисовая, пшённая»), а не монопозиции	Разделы 19, 42.3
2	Пропорции	Пропорции вариантов внутри группы — по статистике выбора учреждения; корректировка раз в квартал без изменения предмета контракта	Раздел 21
3	Гарантия выбора	На приёмах пищи с заявленной вариативностью — не менее двух вариантов основных позиций; срыв выбора фиксируется поставщиком в журнале замен и не считается исполнением	Раздел 42.3
4	Замены при недопоставке	Эквивалент из той же группы по согласованию с учреждением, двусторонний акт в сутки замены	Раздел 19
5	Качество текстур	Характеристики полуфабрикатов, значимые для текстур (помол, консистенция), — в спецификации качества; дисфагические позиции — отдельным пунктом	Раздел 10
6	Приёмка и пробы	Ответственный от учреждения, место и процедура суточных проб	СанПиН 2.3/2.4.4282-26, п. 56 подп. 12 (с 01.09.2026); до этой даты — п. 7.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 ¹²
7	Состав и нормы	Меню-цикл с раскладкой и массой порций — приложение к контракту; соответствие нормам питания	Приказ Минтруда № 520н ³²
8	Отчётность	Ежемесячно: доля выбора по позициям, остатки по блюдам, журнал замен — данные для панели чисел учреждения	Раздел 22

Негативный список — в ТЗ отдельной строкой. Поставщику нельзя отдать: отбор суточных проб; бракераж приёмки готовой продукции как акт учреждения; список дисфагического риска и текстурные назначения; маршрут эскалации отказа от еды. Фотофиксация приёмки — линия, маркировка, термометр. Лица жителей на кадр не попадают (раздел 17.6).

Дисклеймер: проект формы, не нормативный документ; требует адаптации под 44-ФЗ/223-ФЗ и позицию контрактной службы учредителя¹¹¹.

Приложение 44. Письмо учредителю о пилоте вариативности при аутсорсинге (шаблон)

Проект локальной формы. Письмо на одну страницу. Цель — санкция учредителя: строки выбора в спецификацию у действующего поставщика (при изменении) или в новую закупку. Отправлять за 30+ дней до срока планирования закупки.

Уважаемый _____!

Государственное учреждение «_____» (стационарная форма социального обслуживания, ____ мест) просит согласовать включение в спецификацию закупки услуг питания следующих позиций: (1) группы взаимозаменяемых позиций вместо монопозиций; (2) гарантия не менее двух вариантов основных блюд на приёмах пищи с заявленной вариативностью с фиксацией срыва выбора поставщиком; (3) процедура замен при недопоставке из той же группы; (4) ежемесячная отчётность поставщика о доле выбора и остатках.

Обоснование. Право не ограничивает число вариантов блюд (СанПиН¹²; нормы питания — рекомендуемые³²). Выбор при своей кухне и при аутсорсинге совпадает по содержанию: журналы, замеры, гарантия стандартного варианта. Различается место фиксации — контракт.

По сырьевой строке пары эквивалентов, как правило, сопоставимы. Меняются спецификация и отчётность. Это не обещание «пилот без затрат»: обучение смены, маркировка, весы, иногда посуда и ставки — отдельные строки. Понадобятся — напомним следующим письмом с расчётом, а не спрячем за «финансирование не запрашиваем».

Просим согласовать до «___» _____ 20__ г. (срок планирования закупки на 20__ год).

Приложения: форма восьми строк (приложение 43); панель чисел учреждения за последний квартал; проект графика перехода.

С уважением, _____

Приложение 45. План Б: питание при закрытии столовой

Проект локальной формы. Одностраничный бланк к разделу 18.11. Подписывается до вспышки, не утром закрытия. Не заменяет санитарные предписания по конкретному карантину.

Когда включается. Закрытие столовой, карантин отделения, ОРИ, невыход кухни / срыв аутсорсера.

Блок	Что заранее	Кто владелец	Отметка
Выбор в комнате	Два варианта основных позиций на подносе (не вторая линия в коридоре); стандартный вариант всегда есть	Старшая смены + кухня	☐
Заказ	Лист у поста или визуальное меню на двери; журнал замен ведётся усиленно	Пост	☐
Температура	Горячее доходит до комнаты по технологическим документам (п. 50 СанПиН 4282-26) ¹² : мармит → коридор → палата — замер на последней выдаче, не только на линии	Завпроизводством	☐
Питьё	График тёплого питья; ведомость приложения 40	Пост	☐
Посуда	Запас одноразовой / раздельной по карантинному контуру	Завхоз	☐
Холодный буфет	Перечень (хлеб, кисломолочное, фрукты по правилам буфета раздела 18.4), не «что осталось в холодильнике»	Кухня	☐
Если не вышла кухня / не приехал аутсорсер	Кто готовит или кто принимает аварийную поставку; чей телефон в 7:00; что выдаём в первый приём без горячего цеха	Директор / зам	☐
Смена	График раздачи по отделениям с запасными руками; нагрузка не «обнаруживается в 8 утра»	Зам. по АХЧ	☐

Витаминация и любые ограничения рациона при ОРИ — только по назначению врача (раздел 4.3). Выбор не отменяем: меняется форма подачи.

Подпись руководителя: _____ дата: _____ следующий пересмотр: не реже раза в год или после каждой вспышки.

Часть IV. Одностраничные инфографики (для печати)

Шесть одностраничных А4 уже лежат в каталоге листовок раздатки и на стол не дублируются здесь:

- лестница вариативности;
- «Моя еда — мой выбор» (easy read);
- план Б: питание при закрытии столовой;
- таблица замен;
- что сделать в понедельник;
- шесть измерений стола.

Печатать из 04_листовки/. Викторина зала — 05_викторина/.

Указатель сносок

Номер сноски — порядок первого упоминания. Полные записи с URL — раздел 44.

1 M-dysph_prev · 2 S015 · 3 S016 · 4 S017 · 5 S030 · 6 S018 · 7 S004 · 8 Sxxx · 9 M-xxx · 10 I-xxx · 11 S011 · 12 S003 · 13 S012 · 14 S008 · 15 S021 · 16 M-pillinger · 17 M-mortality · 18 M-cloz_hagg · 19 M-lithium · 20 M-maoi_nhs · 21 M-carb_gf · 22 S032 · 23 S033 · 24 S022 · 25 S019 · 26 I-ontario · 27 M-dysph_rev · 28 M-cloz_case · 29 I-gc1 · 30 M-mortality2 · 31 I-dge_betr · 32 S002 · 33 I-lvnat · 34 I-dge · 35 I-fin_nnc · 36 M-nijs · 37 I-aus6 · 38 I-cfr · 39 I-bda · 40 I-ghouse · 41 I-at_qs · 42 I-cqc14 · 43 M-resolve · 44 M-dysph_dd · 45 M-iddsi2017 · 46 M-iddsi_wu · 47 I-aus_iddsi · 48 M-dehydr_steele · 49 M-dehydr_li · 50 M-guss_trapl · 51 M-eat10 · 52 M-oral_yoneyama · 53 M-oral_muller · 54 M-dental_porter · 55 M-cloz_wd · 56 M-lithium_sp · 57 M-maoi_guide · 58 M-maoi_hist · 59 I-dcbp · 60 M-comf_oralfeed · 61 M-comf_jnha · 62 M-crwg · 63 M-fepwg · 64 M-metmon · 65 M-lifestyle · 66 M-teasdale · 67 M-must_bapen · 68 M-constip_ep · 69 M-

constip_nhs · **70** M-micro_psys · **71** M-micro_vitd · **72** M-micro_b12 · **73** M-montessori · **74** I-orebro · **75** S001 · **76** S024 · **77** S009 · **78** S013 · **79** S014 · **80** I-crpd28 · **81** S028 · **82** S029 · **83** I-pioneer · **84** I-edén · **85** I-tallg · **86** S010 · **87** S005 · **88** S020 · **89** S035 · **90** I-bda_res · **91** M-pm_rev · **92** M-pm_rct · **93** I-hugo · **94** I-fct · **95** I-ftag · **96** I-fin2020 · **97** I-sunrise · **98** I-jp2005 · **99** I-jpcov · **100** I-jp2021 · **101** I-jperia · **102** I-jpdiet · **103** M-sup_hous · **104** I-ont_fao · **105** I-torstar · **106** I-anfp · **107** I-snn · **108** I-m3mmar · **109** S006 · **110** S025 · **111** S023 · **112** S034 · **113** S031 · **114** I-nhs2016 · **115** M-ebt · **116** I-easyread · **117** M-hydr_low · **118** M-hydr_esp · **119** M-hydr_palt · **120** S027